



Optimal
Untuk
Negeri



Bunga Rampai

KESEHATAN MENTAL PEREMPUAN

PENDEKATAN KEBIDANAN DARI REMAJA HINGGA LANSIA

Fitriana • Nurun Ayati Khasanah • Deny Eka Widyastuti
Subang Aini Nasution

Editor: Sukmawati



**BUNGA RAMPAI
KESEHATAN MENTAL PEREMPUAN:
PENDEKATAN KEBIDANAN DARI REMAJA
HINGGA LANSIA**

Penulis:

Dr. Fitriana, S.ST., M.Kes.

Bdn. Nurun Ayati Khasanah, SST., S.KM., M.Kes.

Deny Eka Widyastuti, SST., M.Kes., M.Keb.

Dr. Subang Aini Nasution, M.Kes.

Editor:

Dr. Sukmawati, S.Si.T., M.Kes.

Bunga Rampai Kesehatan Mental Perempuan: Pendekatan Kebidanan dari Remaja Hingga Lansia

Penulis: Dr. Fitriana, S.ST., M.Kes.
Bdn. Nurun Ayati Khasanah, SST., S.KM., M.Kes.
Deny Eka Widyastuti, SST., M.Kes., M.Keb.
Dr. Subang Aini Nasution, M.Kes.

Editor: Dr. Sukmawati, S.Si.T., M.Kes.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan
Penata Letak: Muhammad Ilham

ISBN: 978-634-7426-08-6

Cetakan Pertama : Oktober, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025



PRAKATA



Perubahan psikologis perempuan berlangsung dinamis sepanjang daur kehidupan dari remaja, masa kehamilan, pascapersalinan, dewasa, hingga lansia dan membutuhkan pendekatan yang peka konteks serta berbasis bukti. Buku bab ini, "Bunga Rampai Kesehatan Mental Perempuan: Pendekatan Kebidanan dari Remaja Hingga Lansia," disusun untuk menjembatani kesenjangan antara teori ilmiah, praktik kebidanan, dan kebutuhan nyata perempuan di layanan kesehatan. Kontribusi penulis dari berbagai latar profesi memperkaya perspektif klinis, komunitas, dan keluarga, sehingga pembaca memperoleh panduan yang sistematis namun tetap aplikatif. Kami menempatkan kebidanan bukan sekadar sebagai ranah klinis, melainkan sebagai disiplin yang berperan strategis dalam promosi, pencegahan, deteksi dini, intervensi, serta advokasi kesehatan mental perempuan.

Struktur buku dirancang berlapis: Bab 1 menguraikan landasan teoritis dan konseptual selama kehamilan, merujuk pada definisi kesehatan mental terkini (WHO, 2022), Rubin's Theory of Maternal Role Attainment, hingga model stress–diathesis untuk memahami kerentanan dan pemicu gangguan. Bab 2 menyoroti periode pascapersalinan dari kondisi psikologis umum, baby blues, depresi, kecemasan, hingga psikosis serta strategi pencegahan, deteksi dini, tata laksana, dan kolaborasi lintas tenaga kesehatan. Bab 3 memperluas cakupan pada perempuan dewasa dengan menelaah determinan, spektrum masalah umum, dampak lintas peran (keluarga, kerja, sosial), dan praktik baik berbasis kasus. Bab 4 memusat pada lansia perempuan, mengulas faktor biologis-psikososial, peran keluarga dan lingkungan, intervensi yang ramah usia, serta pemanfaatan teknologi dan media untuk mempertahankan kemandirian dan kualitas hidup. Setiap bab diakhiri dengan simpulan, referensi, dan glosarium untuk memudahkan telaah lebih lanjut.

Kami berharap bunga rampai ini menjadi rujukan praktis bagi bidan, perawat, tenaga kesehatan, pendidik, dan mahasiswa dalam merancang layanan yang menyatukan evidence-based practice dan kepekaan budaya. Pembaca didorong menggunakan buku ini sebagai panduan menyusun program promosi dan pencegahan, melakukan skrining berjenjang, mengintegrasikan intervensi psikososial, serta memperkuat jejaring rujukan dan dukungan keluarga. Terima kasih kami sampaikan kepada para penulis atas kontribusi ilmiah yang bernilai, serta kepada para sejawat dan institusi yang mendukung proses penerbitan. Semoga karya ini memperkuat ekosistem layanan kebidanan yang holistik menjaga martabat, keselamatan, dan kesejahteraan mental perempuan Indonesia di setiap tahap kehidupannya.

Editor



DAFTAR ISI



PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
CHAPTER 1 KESEHATAN MENTAL SELAMA KEHAMILAN	1
Dr. Fitriana, S.ST., M.Kes.	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Konsep Kesehatan Mental (WHO, 2022)	2
C. Teori Adaptasi Psikologis Selama Kehamilan: Rubin's Theory of Maternal Role Attainment	3
D. Teori Stress-Diathesis pada Gangguan Mental	4
E. Gangguan Kesehatan Mental yang Umum pada Kehamilan.....	4
F. Strategi Deteksi dan Intervensi Kesehatan Mental pada Kehamilan	8
G. Perspektif Global dan Lokal	9
H. Referensi	15
CHAPTER 2 TANTANGAN KESEHATAN MENTAL PASCA PERSALINAN	17
Bdn. Nurun Ayati Khasanah, SST., S.KM., M.Kes.	17
A. Pendahuluan/Prolog.....	17
B. Kondisi Psikologis Umum pada Masa Pasca Persalinan	18
C. Baby Blues: Gejala, Penyebab, dan Dampaknya	20
D. Depresi Pasca Persalinan (Postpartum Depression).....	22
E. Gangguan Kecemasan Pasca Persalinan (Postpartum Anxiety).....	25
F. Gangguan Psikosis Pasca Persalinan (Postpartum Psychosis).....	27
G. Faktor Risiko yang Meningkatkan Tantangan Kesehatan Mental Pasca Persalinan.....	30
H. Strategi Pencegahan dan Deteksi Dini Gangguan Kesehatan Mental Pasca Persalinan.....	32
I. Pendekatan dan Terapi untuk Mengatasi Tantangan Kesehatan Mental Pasca Persalinan	34
J. Peran Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Kesehatan Mental Pasca Persalinan.....	36
K. Simpulan	39
L. Referensi	40
M. Glosarium.....	42

CHAPTER 3 KESEHATAN MENTAL PEREMPUAN DEWASA.....45

Deny Eka Widyastuti, SST., M.Kes., M.Keb.	45
A. Pendahuluan/Prolog.....	45
B. Konsep Dasar Kesehatan Mental pada Perempuan Dewasa	47
C. Faktor Risiko dan Determinan Kesehatan Mental.....	49
D. Gangguan Kesehatan Mental yang Umum pada Perempuan Dewasa	51
E. Dampak Kesehatan Mental terhadap Kehidupan Perempuan Dewasa	54
F. Strategi Promosi dan Pencegahan Kesehatan Mental	56
G. Peran Tenaga Kesehatan dalam Menangani Kesehatan Mental Perempuan	59
H. Studi Kasus dan Praktik Baik.....	61
I. Tantangan dan Hambatan dalam Penanganan Kesehatan Mental Perempuan Dewasa	64
J. Simpulan	66
K. Referensi	67
L. Glosarium.....	69

CHAPTER 4 KESEHATAN MENTAL PEREMPUAN LANSIA73

Dr. Subang Aini Nasution, M.Kes.	73
A. Pendahuluan/Prolog.....	73
B. Konsep Dasar Kesehatan Mental pada Lansia.....	75
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesehatan Mental Perempuan Lansia	76
D. Masalah Umum Kesehatan Mental pada Perempuan Lansia	79
E. Peran Keluarga dan Lingkungan Sosial	81
F. Strategi Pencegahan dan Promosi Kesehatan Mental Lansia.....	84
G. Intervensi dan Pendekatan dalam Menangani Gangguan Mental Lansia.....	87
H. Pemanfaatan Teknologi dan Media dalam Mendukung Kesehatan Mental Lansia.....	91
I. Tantangan dan Hambatan dalam Peningkatan Kesehatan Mental Lansia	93
J. Simpulan	96
K. Referensi	97
L. Glosarium.....	99

PROFIL PENULIS103

CHAPTER 1

KESEHATAN MENTAL SELAMA KEHAMILAN

Dr. Fitriana, S.ST., M.Kes.

A. Pendahuluan

Kehamilan merupakan fase kehidupan yang unik sekaligus penuh tantangan, di mana seorang perempuan mengalami perubahan biologis, psikologis, dan sosial yang signifikan. Selain adaptasi fisik, masa kehamilan juga merupakan periode yang rentan terhadap gangguan kesehatan mental. World Health Organization (World Health Organization, 2022) menegaskan bahwa kesehatan mental ibu hamil adalah bagian integral dari kesehatan maternal, karena gangguan psikologis selama kehamilan dapat berdampak pada kesejahteraan ibu, perkembangan janin, serta hubungan ibu-anak di kemudian hari.



Gambar 1.1: Stress In Pregnancy: Risks, Reasons & How to Lower

Secara global, diperkirakan sekitar 10% ibu hamil dan 13% ibu pascapersalinan mengalami gangguan kesehatan mental, terutama depresi dan kecemasan (World Health Organization, 2022). Angka ini bahkan lebih tinggi di negara berpenghasilan rendah dan menengah, yaitu mencapai 15,6% selama kehamilan dan 19,8% setelah melahirkan. Sebuah tinjauan sistematis melibatkan lebih dari 616.000 perempuan di 51 negara menunjukkan prevalensi depresi perinatal sebesar 24,7%, dengan variasi

antarwilayah, misalnya 21,4% di Asia Timur dan Pasifik serta 31,5% di Timur Tengah dan Afrika Utara (Shorey et al., 2023)

Situasi ini semakin kompleks ketika pandemi COVID-19 melanda. Isolasi sosial, keterbatasan akses layanan kesehatan, serta ketidakpastian ekonomi menyebabkan lonjakan gejala psikologis pada ibu hamil. Studi melaporkan sekitar 29–33% ibu hamil mengalami gejala depresi, 30–33% mengalami kecemasan, dan hampir 27–29% melaporkan stres signifikan selama pandemi (Fan et al., 2022). Kondisi ini mengindikasikan bahwa kesehatan mental maternal memerlukan perhatian serius sebagai bagian dari pelayanan antenatal yang komprehensif.

Dengan demikian, kehamilan bukan hanya periode transisi biologis, tetapi juga masa kritis psikologis yang membutuhkan dukungan multidimensi. Upaya deteksi dini, intervensi psikologis, serta peningkatan dukungan sosial sangat penting untuk menekan dampak negatif gangguan mental maternal terhadap ibu, anak, dan keluarga.

B. Konsep Kesehatan Mental (WHO, 2022)

Kesehatan mental didefinisikan oleh **World Health Organization (WHO, 2022)** sebagai kondisi kesejahteraan yang memungkinkan individu menyadari potensinya, mampu menghadapi tekanan hidup yang normal, bekerja secara produktif, serta berkontribusi pada komunitasnya. Dalam konteks kehamilan, kesehatan mental menjadi komponen fundamental yang memengaruhi kesehatan ibu maupun janin. Kehamilan bukan hanya proses biologis, tetapi juga fase perkembangan psikologis dan sosial yang kompleks. WHO menekankan bahwa gangguan mental selama kehamilan—seperti depresi antenatal, kecemasan, dan stres—dapat meningkatkan risiko komplikasi obstetri, memperburuk kualitas hidup ibu, serta berdampak jangka panjang terhadap perkembangan anak. Oleh karena itu, pemeliharaan kesehatan mental pada ibu hamil dipandang sebagai bagian integral dari pelayanan maternal dan perinatal. Kesehatan mental ibu hamil juga sangat dipengaruhi oleh determinan sosial kesehatan, misalnya status ekonomi, dukungan pasangan, hubungan keluarga, dan akses terhadap pelayanan kesehatan. Kondisi-kondisi seperti kekerasan berbasis gender, diskriminasi, dan kemiskinan terbukti memperburuk kerentanan psikologis ibu hamil (World Health Organization, 2022)

C. Teori Adaptasi Psikologis Selama Kehamilan: Rubin's Theory of Maternal Role Attainment

Reva Rubin (1984) mengembangkan teori *maternal role attainment* yang relevan dalam memahami adaptasi psikologis selama kehamilan. Teori ini menjelaskan bagaimana seorang perempuan bertransisi menjadi ibu melalui empat tahap psikologis: **Anticipatory stage** – terjadi sebelum hamil atau pada awal kehamilan, di mana ibu mulai membentuk harapan terhadap perannya sebagai orang tua. **Formal stage** – selama kehamilan, ibu mulai mempelajari peran ibu berdasarkan norma sosial, pengalaman orang lain, dan interaksi dengan tenaga kesehatan. **Informal stage** – setelah persalinan, ibu mulai menyesuaikan harapan dengan pengalaman nyata dalam mengasuh bayi. **Personal stage** – ibu menginternalisasi peran barunya dan mencapai identitas maternal yang stabil. Dalam konteks kesehatan mental, teori ini menunjukkan bahwa kehamilan adalah fase adaptasi yang rentan memunculkan konflik identitas, kecemasan, dan stres, terutama bila dukungan sosial tidak memadai. Penelitian terkini menunjukkan bahwa keberhasilan maternal role attainment berhubungan erat dengan dukungan pasangan, kesejahteraan psikologis, serta self-efficacy dalam mengasuh anak (Astuti et al., 2023).

Perspektif Biopsikososial

Model **biopsikososial** menjelaskan kesehatan mental ibu hamil sebagai hasil interaksi tiga dimensi utama:

1. **Biologis**: perubahan hormonal (misalnya peningkatan progesteron dan estrogen), kondisi fisik kehamilan, penyakit penyerta (anemia, hipertensi, diabetes gestasional).
2. **Psikologis**: kepribadian, riwayat trauma, mekanisme koping, dan kesiapan menjadi ibu.
3. **Sosial**: dukungan keluarga, status ekonomi, relasi pernikahan, dan budaya yang memengaruhi pengalaman kehamilan.

Model ini menegaskan bahwa tidak ada faktor tunggal yang sepenuhnya menentukan kesehatan mental, melainkan kombinasi yang saling berinteraksi. Misalnya, perempuan dengan predisposisi kecemasan (faktor psikologis) yang menghadapi kemiskinan (faktor sosial) dan mengalami komplikasi obstetri (faktor biologis) memiliki risiko lebih tinggi mengalami depresi antenatal. Pendekatan biopsikososial menjadi dasar dari praktik kebidanan modern dan intervensi psikososial, seperti konseling kehamilan, terapi kelompok, dan intervensi berbasis mindfulness yang terbukti efektif menurunkan depresi antenatal (Pawluski & Lonstein, 2021).

D. Teori Stress-Diathesis pada Gangguan Mental

Teori *stress-diathesis* menjelaskan bahwa gangguan mental muncul dari interaksi antara **kerentanan individu (diathesis)** dan **stres lingkungan**. Dalam konteks kehamilan:

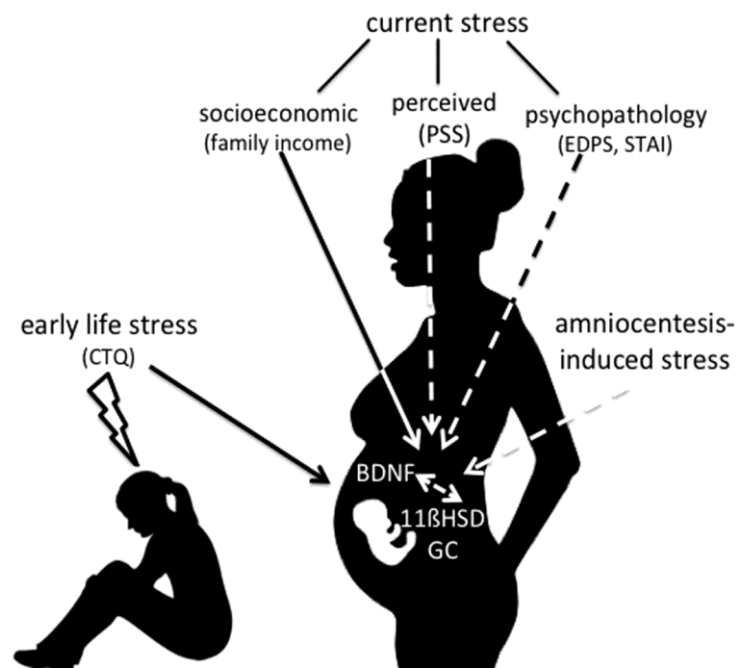
1. **Diathesis** dapat berupa faktor genetik, riwayat depresi atau kecemasan, kepribadian rentan, atau pengalaman trauma masa lalu.
2. **Stresor** meliputi perubahan hormon, beban ekonomi, konflik rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, hingga stres akibat pandemi COVID-19.

Ketika stresor tinggi dialami oleh individu dengan kerentanan psikologis, maka risiko munculnya gangguan mental seperti depresi antenatal dan kecemasan meningkat signifikan. Model ini menjelaskan mengapa tidak semua ibu hamil mengalami depresi meski menghadapi stres yang sama—karena adanya perbedaan kerentanan dasar pada masing-masing individu.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pendekatan *stress-diathesis* membantu dalam skrining risiko gangguan mental pada ibu hamil. Misalnya, identifikasi faktor risiko biologis (riwayat penyakit mental), psikologis (tingkat kecemasan), dan sosial (dukungan keluarga) dapat memprediksi kemungkinan terjadinya depresi pascapersalinan (O'Hara & Wisner, 2023)

E. Gangguan Kesehatan Mental yang Umum pada Kehamilan

Kehamilan merupakan periode penting dalam kehidupan seorang perempuan yang ditandai oleh perubahan biologis, psikologis, dan sosial yang signifikan. Selain mempersiapkan diri menghadapi proses persalinan, ibu hamil juga dihadapkan pada berbagai tantangan emosional dan psikologis. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa gangguan kesehatan mental selama kehamilan tidak hanya berdampak pada kesejahteraan ibu, tetapi juga pada kesehatan janin, ikatan ibu-anak, serta perkembangan anak jangka panjang (Shorey et al., 2023).



Gambar 1.2: Pengaruh Stres Maternal dan Faktor Sosial Ekonomi terhadap Regulasi Neurotropik Janin (Deuschle et al., 2018)

Lingkungan prenatal merupakan fase krusial yang membentuk fenotipe janin, termasuk perkembangan sistem saraf. Berbagai bukti ilmiah menunjukkan bahwa stres yang dialami ibu, baik stres transgenerasional maupun stres selama kehamilan, dapat memengaruhi neurobiologi janin melalui mekanisme molekuler tertentu. Dua mediator utama yang terlibat adalah **Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF)** dan **glukokortikoid**.

BDNF memiliki peran penting dalam proses neurogenesis, diferensiasi, dan plastisitas sinaps pada otak janin. Menariknya, penelitian menemukan bahwa kadar BDNF dalam cairan amnion sebagian besar berasal dari janin, sehingga mencerminkan regulasi intrinsik perkembangan saraf anak. Sebaliknya, glukokortikoid—seperti kortisol dan kortison—lebih banyak berasal dari ibu, sehingga kondisi stres maternal dapat memengaruhi paparan janin terhadap hormon ini.

Sebuah penelitian terhadap **79 ibu hamil** yang menjalani **amniosentesis pada trimester kedua** meneliti hubungan antara kadar BDNF, kortisol, dan kortison dalam cairan amnion dengan faktor psikososial ibu. Faktor yang diukur meliputi riwayat stres masa kecil (**Childhood Trauma Questionnaire/CTQ**), tingkat stres subjektif (**Perceived Stress Scale/PSS**), kecemasan, status sosial ekonomi (pendapatan keluarga), dan adanya gangguan psikiatri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa **riwayat kejadian buruk di masa kecil ibu** (early life adversity) berkorelasi positif dengan peningkatan kadar BDNF dalam cairan amnion. Hal ini mengindikasikan bahwa pengalaman traumatis ibu di masa

lalu dapat memengaruhi regulasi neurotropik janin, yang berpotensi berdampak pada perkembangan otak anak. Selain itu, ditemukan bahwa **status sosial ekonomi rendah** berhubungan dengan kadar glukokortikoid yang lebih tinggi dalam cairan amnion. Peningkatan paparan glukokortikoid pada janin diketahui dapat mengganggu perkembangan neurobiologis dan meningkatkan kerentanan terhadap gangguan kesehatan mental di kemudian hari.

Menariknya, penelitian ini tidak menemukan hubungan langsung antara kadar glukokortikoid dengan kadar BDNF dalam cairan amnion. Hal ini menunjukkan bahwa jalur pengaruh faktor stres maternal terhadap janin dapat bekerja melalui mekanisme biologis yang berbeda, dan tidak selalu bersifat linier.

Secara keseluruhan, hasil ini memperkuat teori bahwa **pengalaman hidup ibu dan kondisi sosial ekonomi keluarga dapat meninggalkan jejak biologis pada janin**. Dengan demikian, kondisi psikososial ibu hamil tidak hanya memengaruhi kesejahteraan dirinya, tetapi juga berpotensi menentukan kualitas perkembangan neuropsikologis generasi berikutnya. Penelitian lanjutan masih diperlukan untuk memahami sejauh mana perubahan BDNF janin ini berimplikasi terhadap hasil perkembangan kognitif dan emosional anak.

Beberapa gangguan kesehatan mental yang paling umum terjadi pada masa kehamilan antara lain **depresi antenatal, kecemasan, gangguan stres pasca-trauma (PTSD), dan gangguan obsesif-kompulsif (OCD)**.

1. Depresi Antenatal

Depresi antenatal adalah salah satu gangguan mental paling sering dialami selama kehamilan. Gejalanya meliputi perasaan sedih berkepanjangan, hilangnya minat atau kesenangan dalam aktivitas sehari-hari, gangguan tidur, kelelahan, serta pikiran negatif tentang diri dan kehamilan. Prevalensi depresi antenatal secara global diperkirakan berkisar antara 10–20% pada ibu hamil di negara berpendapatan tinggi, dan bahkan lebih tinggi di negara berpendapatan rendah-menengah, yakni mencapai 25–40% (Shorey et al., 2023). Faktor risiko utama meliputi riwayat depresi, stres psikososial, kurangnya dukungan sosial, kemiskinan, serta komplikasi kehamilan.

Dampak depresi antenatal tidak hanya dialami ibu, melainkan juga berhubungan dengan peningkatan risiko kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, dan gangguan perkembangan neurokognitif anak (Junge et al., 2021).

2. Gangguan Kecemasan

Kecemasan selama kehamilan dapat berupa generalized anxiety disorder (GAD), kecemasan spesifik terhadap kehamilan dan persalinan, maupun serangan panik. Gejalanya termasuk kekhawatiran berlebihan, ketegangan otot, kesulitan konsentrasi, insomnia, hingga gejala somatik seperti palpitasi dan sesak napas.

Prevalensi kecemasan antenatal dilaporkan cukup tinggi, sekitar 15–25. Faktor risiko yang sering ditemukan adalah kehamilan tidak direncanakan, riwayat gangguan cemas sebelumnya, pengalaman obstetri negatif, serta kurangnya dukungan pasangan.(Siddiqui & Malik, 2020).Kecemasan yang tidak ditangani dapat memicu gangguan tidur, peningkatan tekanan darah, dan risiko depresi pascapersalinan. Selain itu, kecemasan berlebihan dapat memengaruhi ikatan emosional ibu-anak serta proses menyusui (Yang et al., 2020).

3. Gangguan Stres Pascatrauma (PTSD)

PTSD pada kehamilan biasanya berkaitan dengan pengalaman trauma sebelumnya, seperti kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, atau pengalaman obstetri yang buruk. Gejalanya meliputi flashback, mimpi buruk, hipervigilansi, dan penghindaran terhadap hal-hal yang mengingatkan pada trauma. Prevalensi PTSD pada kehamilan diperkirakan berkisar 3–10%, namun dapat lebih tinggi pada kelompok dengan riwayat trauma berat PTSD selama kehamilan dapat meningkatkan risiko depresi, gangguan ikatan ibu-janin, serta komplikasi persalinan akibat respons fisiologis stres kronis.(Ramadan & Ataallah, 2021)

4. Gangguan Obsesif-Kompulsif (OCD)

Gangguan obsesif-kompulsif pada kehamilan relatif jarang, namun tetap menjadi perhatian karena dapat menimbulkan kecemasan signifikan. Ibu hamil dengan OCD biasanya mengalami obsesi tentang kesehatan janin, ketakutan berlebihan akan kontaminasi, atau dorongan kompulsif untuk melakukan pemeriksaan dan ritual tertentu.Prevalensi OCD selama kehamilan diperkirakan sekitar 2–3%, dengan risiko meningkat pada perempuan dengan riwayat OCD atau kecemasan sebelumnya (Fairbrother et al., 2021). OCD pada kehamilan berpotensi mengganggu kualitas hidup ibu dan meningkatkan risiko depresi antenatal maupun pascapersalinan.

5. Implikasi Klinis dan Pencegahan

Gangguan kesehatan mental pada kehamilan memiliki implikasi besar terhadap ibu, janin, dan keluarga. Deteksi dini melalui skrining rutin kesehatan mental selama antenatal care menjadi sangat penting. Intervensi berbasis bukti, seperti konseling psikologis, terapi kognitif-perilaku (CBT), mindfulness-based therapy, serta dukungan sosial terbukti efektif menurunkan tingkat depresi dan kecemasan antenatal (Pawluski & Lonstein, 2021).

Selain itu, penting bagi tenaga kesehatan untuk menggunakan pendekatan biopsikososial dan sensitif gender dalam memberikan perawatan, mengingat faktor sosial seperti kekerasan berbasis gender, kemiskinan, dan pandemi dapat memperburuk kondisi mental ibu hamil (World Health Organization, 2022).

F. Strategi Deteksi dan Intervensi Kesehatan Mental pada Kehamilan

1. Skrining Kesehatan Mental(Csontos et al., 2024)

Skrining kesehatan mental pada ibu hamil merupakan langkah awal yang sangat penting untuk mendeteksi risiko gangguan psikologis secara dini. Instrumen yang paling banyak digunakan antara lain:

- a. **Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS)** – instrumen yang dikembangkan khusus untuk mendeteksi depresi perinatal, dengan sensitivitas dan spesifisitas tinggi pada populasi ibu hamil dan menyusui.
- b. **Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9)** – kuesioner singkat yang menilai gejala depresi berdasarkan kriteria DSM-5.
- c. **Generalized Anxiety Disorder-7 (GAD-7)** – instrumen valid untuk menilai gejala kecemasan umum, yang juga relevan pada kehamilan.

Penggunaan instrumen ini dapat diintegrasikan dalam kunjungan antenatal, sehingga skrining dilakukan secara rutin dan hasilnya dapat ditindaklanjuti segera.

2. Peran Tenaga Kesehatan dalam Deteksi Dini

Bidan, perawat, dan dokter kandungan memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam layanan kesehatan ibu. Bidan, sebagai tenaga kesehatan yang paling dekat dengan ibu hamil di komunitas, dapat melakukan skrining awal dan memberikan edukasi. Perawat berperan dalam konseling serta rujukan, sementara dokter kandungan dan psikiater dapat menegaskan diagnosis dan menentukan penatalaksanaan. Kolaborasi interprofesional menjadi kunci dalam memastikan penanganan yang komprehensif.(Csontos et al., 2024)

3. Psikoterapi

Dukungan sosial, yang sangat relevan bagi ibu hamil. Kedua pendekatan ini dapat dilakukan secara individu maupun kelompok, bahkan dengan bantuan *telehealth*.(Borrelli et al., 2023)

4. Intervensi Farmakologis

Pada kasus sedang hingga berat, terapi farmakologis seperti antidepresan (misalnya SSRI: sertraline, fluoxetine) dapat dipertimbangkan. Keputusan penggunaan obat harus mempertimbangkan **keamanan janin**, trimester kehamilan, serta risiko-manfaat bagi ibu. Kolaborasi antara dokter kandungan dan psikiater penting untuk menentukan pilihan obat yang aman.(Mohamed et al., 2023)

5. Dukungan Sosial dan Komunitas

Dukungan dari keluarga, pasangan, dan komunitas terbukti menjadi faktor protektif utama dalam menurunkan risiko depresi perinatal. Program

pendampingan ibu hamil, kelompok diskusi ibu, serta komunitas daring dapat meningkatkan resiliensi psikologis ibu.(Munafiah et al., 2023)

6. Integrasi Layanan Kesehatan Mental dalam Perawatan Antenatal

WHO merekomendasikan agar kesehatan mental menjadi bagian dari **perawatan antenatal rutin**. Integrasi ini dapat berupa skrining, konseling singkat, rujukan ke spesialis, hingga layanan komunitas berbasis keluarga. Model integratif ini terbukti meningkatkan kualitas hidup ibu hamil dan menurunkan risiko komplikasi obstetri.(Lovero, 2019)

G. Perspektif Global dan Lokal

1. Perbandingan Negara Maju dan Berkembang

Negara maju memiliki sistem skrining rutin, akses psikoterapi luas, dan ketersediaan obat dengan pengawasan ketat. Sebaliknya, di negara berkembang, skrining mental masih jarang dilakukan, stigma tinggi, serta layanan kesehatan jiwa terbatas.(Fisher et al., 2022)

2. Tantangan di Negara (*Low- and Middle-Income Countrie*) LMICs

Tantangan utama meliputi keterbatasan tenaga kesehatan terlatih, rendahnya kesadaran masyarakat, stigma budaya, serta kurangnya integrasi layanan kesehatan mental dalam sistem antenatal.(Pawluski & Lonstein, 2021)

3. Praktik Baik (*Best Practice*)

Beberapa negara menunjukkan keberhasilan dengan pendekatan sederhana, misalnya India dengan pelatihan bidan dalam skrining depresi, serta Afrika Selatan yang mengembangkan konseling berbasis komunitas.(Smith & Brown, 2021). Prevalensi depresi dan kecemasan perinatal di LMICs lebih tinggi (sekitar 20–25%) dibandingkan negara berpenghasilan tinggi (~10–15%) (Shorey et al., 2023).

4. Konteks Indonesia

Di Indonesia, prevalensi depresi perinatal diperkirakan mencapai 20–25%. Namun, skrining belum menjadi praktik standar di semua fasilitas. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mulai mengintegrasikan **program kesehatan jiwa ibu** dalam layanan primer, namun masih menghadapi tantangan keterbatasan sumber daya dan stigma. Perlu strategi lebih komprehensif untuk memperkuat layanan di tingkat komunitas.(Garcia et al., 2022).

Edinburgh Postnatal Depression Scale¹ (EPDS)

Name: _____ Address: _____

Your Date of Birth: _____

Baby's Date of Birth: _____ Phone: _____

As you are pregnant or have recently had a baby, we would like to know how you are feeling. Please check the answer that comes closest to how you have felt **IN THE PAST 7 DAYS**, not just how you feel today.

Here is an example, already completed.

I have felt happy:

- ☐ Yes, all the time
☒ Yes, most of the time This would mean: "I have felt happy most of the time" during the past week.
☐ No, not very often Please complete the other questions in the same way.
☐ No, not at all

In the past 7 days:

- | | |
|---|--|
| 1. I have been able to laugh and see the funny side of things
☐ As much as I always could
☐ Not quite so much now
☐ Definitely not so much now
☐ Not at all | *6. Things have been getting on top of me
☐ Yes, most of the time I haven't been able to cope at all
☐ Yes, sometimes I haven't been coping as well as usual
☐ No, most of the time I have coped quite well
☐ No, I have been coping as well as ever |
| 2. I have looked forward with enjoyment to things
☐ As much as I ever did
☐ Rather less than I used to
☐ Definitely less than I used to
☐ Hardly at all | *7. I have been so unhappy that I have had difficulty sleeping
☐ Yes, most of the time
☐ Yes, sometimes
☐ Not very often
☐ No, not at all |
| *3. I have blamed myself unnecessarily when things went wrong
☐ Yes, most of the time
☐ Yes, some of the time
☐ Not very often
☐ No, never | *8. I have felt sad or miserable
☐ Yes, most of the time
☐ Yes, quite often
☐ Not very often
☐ No, not at all |
| 4. I have been anxious or worried for no good reason
☐ No, not at all
☐ Hardly ever
☐ Yes, sometimes
☐ Yes, very often | *9. I have been so unhappy that I have been crying
☐ Yes, most of the time
☐ Yes, quite often
☐ Only occasionally
☐ No, never |
| *5. I have felt scared or panicky for no very good reason
☐ Yes, quite a lot
☐ Yes, sometimes
☐ No, not much
☐ No, not at all | *10. The thought of harming myself has occurred to me
☐ Yes, quite often
☐ Sometimes
☐ Hardly ever
☐ Never |

Administered/Reviewed by _____ Date _____

¹Source: Cox, J.L., Holden, J.M., and Sagovsky, R. 1987. Detection of postnatal depression: Development of the 10-item Edinburgh Postnatal Depression Scale. *British Journal of Psychiatry* 150:782-786.

²Source: K. L. Wisner, B. L. Parry, C. M. Plonk, Postpartum Depression N Engl J Med vol. 347, No 3, July 18, 2002, 194-199

Users may reproduce the scale without further permission providing they respect copyright by quoting the names of the authors, the title and the source of the paper in all reproduced copies.

<https://med.stanford.edu/content/dam/sm/neonatology/documents/edinburghscale.pdf>

Edinburgh Postnatal Depression Scale¹ (EPDS)

Postpartum depression is the most common complication of childbearing.² The 10-question Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) is a valuable and efficient way of identifying patients at risk for "perinatal" depression. The EPDS is easy to administer and has proven to be an effective screening tool.

Mothers who score above 13 are likely to be suffering from a depressive illness of varying severity. The EPDS score should not override clinical judgment. A careful clinical assessment should be carried out to confirm the diagnosis. The scale indicates how the mother has felt **during the previous week**. In doubtful cases it may be useful to repeat the tool after 2 weeks. The scale will not detect mothers with anxiety neuroses, phobias or personality disorders.

Women with postpartum depression need not feel alone. They may find useful information on the web sites of the National Women's Health Information Center <www.4women.gov> and from groups such as Postpartum Support International <www.chss.iup.edu/postpartum> and Depression after Delivery <www.depressionafterdelivery.com>.

SCORING

QUESTIONS 1, 2, & 4 (without an *)

Are scored 0, 1, 2 or 3 with top box scored as 0 and the bottom box scored as 3.

QUESTIONS 3, 5-10 (marked with an *)

Are reverse scored, with the top box scored as a 3 and the bottom box scored as 0.

Maximum score: 30
Possible Depression: 10 or greater
Always look at item 10 (suicidal thoughts)

Users may reproduce the scale without further permission, providing they respect copyright by quoting the names of the authors, the title, and the source of the paper in all reproduced copies.

Instructions for using the Edinburgh Postnatal Depression Scale:

1. The mother is asked to check the response that comes closest to how she has been feeling in the previous 7 days.
2. All the items must be completed.
3. Care should be taken to avoid the possibility of the mother discussing her answers with others. (Answers come from the mother or pregnant woman.)
4. The mother should complete the scale herself, unless she has limited English or has difficulty with reading.

¹Source: Cox, J.L., Holden, J.M., and Sagovsky, R. 1987. Detection of postnatal depression: Development of the 10-item Edinburgh Postnatal Depression Scale. *British Journal of Psychiatry* 150:782-786.

²Source: K. L. Wisner, B. L. Parry, C. M. Plonk, Postpartum Depression N Engl J Med vol. 347, No 3, July 18, 2002, 194-199

<https://med.stanford.edu/content/dam/sm/neonatology/documents/edinburghscale.pdf>

PATIENT HEALTH QUESTIONNAIRE-9 (PHQ-9)

Over the last 2 weeks, how often have you been bothered by any of the following problems?
(Use "✓" to indicate your answer)

	Not at all	Several days	More than half the days	Nearly every day
1. Little interest or pleasure in doing things	0	1	2	3
2. Feeling down, depressed, or hopeless	0	1	2	3
3. Trouble falling or staying asleep, or sleeping too much	0	1	2	3
4. Feeling tired or having little energy	0	1	2	3
5. Poor appetite or overeating	0	1	2	3
6. Feeling bad about yourself — or that you are a failure or have let yourself or your family down	0	1	2	3
7. Trouble concentrating on things, such as reading the newspaper or watching television	0	1	2	3
8. Moving or speaking so slowly that other people could have noticed? Or the opposite — being so fidgety or restless that you have been moving around a lot more than usual	0	1	2	3
9. Thoughts that you would be better off dead or of hurting yourself in some way	0	1	2	3

FOR OFFICE CODING 0 + _____ + _____ + _____
=Total Score: _____

If you checked off any problems, how difficult have these problems made it for you to do your work, take care of things at home, or get along with other people?

Not difficult at all ☐	Somewhat difficult ☐	Very difficult ☐	Extremely difficult ☐
--	--	--	---

Developed by Drs. Robert L. Spitzer, Janet B.W. Williams, Kurt Kroenke and colleagues, with an educational grant from Pfizer Inc. No permission required to reproduce, translate, display or distribute.

<https://www.apa.org/depression-guideline/patient-health-questionnaire.pdf>

Generalised Anxiety Disorder 7-item (GAD-7) scale

Name: _____ Date of Birth: _____

GP _____ Date Completed: _____

<i>Over the last 2 weeks, how often have you been bothered by the following problems?</i>	Not at all	Several days	Over half the days	Nearly every day
1. Feeling nervous, anxious, or on edge	0	1	2	3
2. Not being able to stop or control worrying	0	1	2	3
3. Worrying too much about different things	0	1	2	3
4. Trouble relaxing	0	1	2	3
5. Being so restless that it's hard to sit still	0	1	2	3
6. Becoming easily annoyed or irritable	0	1	2	3
7. Feeling afraid as if something awful might happen	0	1	2	3

Add the score for each column + + +

Total Score (add your column scores) = _____

If you checked off any problems, how difficult have these made it for you to do your work, take care of things at home, or get along with other people?

Not difficult at all _____

Somewhat difficult _____

Very difficult _____

Extremely difficult _____

Source: Spitzer RL, Kroenke K, Williams JBW, Lowe B. A brief measure for assessing generalized anxiety disorder. *Arch Intern Med.* 2006;166:1092-1097.

GAD-7 Anxiety Severity Scoring

This is calculated by assigning scores of 0, 1, 2, and 3, to the response categories of "not at all", "several days", "more than half the days", and "nearly every day", respectively.

GAD-7 total score for the seven items ranges from 0 to 21. Scores of 5, 10, and 15 represent cut points for mild, moderate, and severe anxiety, respectively.

Though designed primarily as a screening and severity measure for generalized anxiety disorder, the GAD-7 also has moderately good operating characteristics for three other common anxiety disorders – panic disorder, social anxiety disorder, and post-traumatic stress disorder. When screening for anxiety disorders, a recommended cut point for further evaluation is a score of 10 or greater.

Total Score	Interpretation
≥ 10	Probable diagnosis of GAD; confirm by further evaluation
5	Mild anxiety
10	Moderate anxiety
15	Severe anxiety

Source: Spitzer RL, Kroenke K, Williams JBW, Lowe B. A brief measure for assessing generalized anxiety disorder. *Arch Intern Med*. 2006;166:1092-1097.

https://castcentre.org/wp-content/uploads/2022/09/gad7_en-gb.pdf

H. Referensi

- Astuti, D. P., Damayanti, R., Mutikai, W. T., & Maryana, J. (2023). *Identifikasi Karakteristik Ibu Hamil Risiko Tinggi*. 2(1), 17–22.
- Borrelli, S., Downey, J., Colciago, E., Fumagalli, S., Nespoli, A., & Spiby, P. H. (2023). Mothers' perspectives on the potential use of video-calling during early labour in the United Kingdom and Italy: A qualitative study. *Women and Birth*, 36(4), e405–e411. <https://doi.org/10.1016/j.wombi.2023.01.004>
- Csontos, J., Edwards, D., Gillen, E., Hounsborne, J., Kiseleva, M., Mann, M., Sidhu, A., Macey, S., Lewis, R., Edwards, A., & Cooper, A. (2024). *Supporting women, girls and people who menstruate to participate in physical activity – Rapid evidence summary*. <http://medrxiv.org/lookup/doi/10.1101/2024.09.02.24311982>
- Deuschle, M., Hendlmeier, F., Witt, S., Rietschel, M., Gilles, M., Sánchez-Guijo, A., Fañanas, L., Hentze, S., Wudy, S. A., & Hellweg, R. (2018). Cortisol, cortisone, and BDNF in amniotic fluid in the second trimester of pregnancy: Effect of early life and current maternal stress and socioeconomic status. *Development and Psychopathology*, 30(3), 971–980. <https://doi.org/10.1017/S0954579418000147>
- Fan, S., Guan, J., Cao, L., & others. (2022). Psychological effects of COVID-19 on pregnant women and newborns: A systematic review. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 22, 52. <https://doi.org/10.1186/s12884-022-05243-4>
- Fisher, J., de Mello, M., Patel, V., & others. (2022). Perinatal mental health: A global priority. *The Lancet Global Health*, 10(9), e1230–e1242. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(22\)00190-5](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(22)00190-5)
- Garcia, A. R., Filipe, S. B., Fernandes, C., Estevão, C., & Ramos, G. (2022). *WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience*.
- Junge, K. M., Buchenauer, L., Elter, E., Butter, K., Kohajda, T., Herberth, G., Röder, S., Borte, M., Kiess, W., von Bergen, M., Simon, J. C., Rolle-Kampczyk, U. E., Lehmann, I., Gminski, R., Ohlmeyer, M., & Polte, T. (2021). Wood emissions and asthma development: Results from an experimental mouse model and a prospective cohort study. *Environment International*, 151. <https://doi.org/10.1016/j.envint.2021.106449>
- Lovero, K. L. (2019). Mixed-methods evaluation of mental healthcare integration into tuberculosis and maternal-child healthcare services of four South African districts. *BMC Health Services Research*, 19(1). <https://doi.org/10.1186/s12913-019-3912-9>
- Mohamed, S., Chipeta, M. G., Kamninga, T., Nthakomwa, L., Chifungo, C., Mzembe, T., Vellemu, R., Chikwapulo, V., Peterson, M., Abdullahi, L., Musau, K., Wazny, K., Zulu, E., & Madise, N. (2023). Interventions to prevent unintended pregnancies among adolescents: a rapid overview of systematic reviews. *Systematic Reviews*, 12(1), 1–19. <https://doi.org/10.1186/s13643-023-02361-8>

- Munafiah, D., Mayangsari, D., Maftuchah, M., Rahayu, H., & Suhud, H. (2023). Pemberdayaan Bidan Melalui Aplikasi E-Profbid Dalam Upaya Peningkatan Skill Stase Persalinan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sasambo*, 5(1), 67. <https://doi.org/10.32807/jpms.v5i1.1402>
- O'Hara, M. W., & Wisner, K. L. (2023). Perinatal mental illness: Definition, description and aetiology. *Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology*, 85, 3–14. <https://doi.org/10.1016/j.bpobgyn.2022.102456>
- Pawluski, J. L., & Lonstein, J. S. (2021). Perinatal mental health: Lessons from animal models. *Current Psychiatry Reports*, 23(11), 68. <https://doi.org/10.1007/s11920-021-01294-y>
- Ramadan, A. M. H., & Ataallah, A. G. (2021). Are climate change and mental health correlated? *General Psychiatry*, 34(6), 1–9. <https://doi.org/10.1136/gpsych-2021-100648>
- Shorey, S., Chee, C. Y. I., Ng, E. D., Lau, Y., Dennis, C. L., & Chan, Y. H. (2023). Prevalence and incidence of perinatal depression and anxiety among women in low- and middle-income countries: A systematic review and meta-analysis. *The Lancet Psychiatry*, 10(1), 1–12. [https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(22\)00313-2](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(22)00313-2)
- Siddiqui, F., & Malik, A. A. (2020). Comparison of oxidative stress markers and anti-oxidant defense system in asthmatic and non-asthmatic women during second trimester of pregnancy. *Khyber Medical University Journal*, 12(2), 81–85. <https://doi.org/10.35845/kmu.j.2020.19646>
- Smith, J., & Brown, L. (2021). Holistic approaches to preconception health: Integrating physical, mental, and social care. *Journal of Reproductive Health*, 28(3), 210–220. <https://doi.org/10.1093/jrh/210>
- World Health Organization. (2022). *WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience*.
- Yang, Q., Chen, Q., Zhang, M., Cai, Y., Yang, F., Zhang, J., Deng, G., Ye, T., Deng, Q., Li, G., Zhang, H., Yi, Y., Huang, R. P., & Chen, X. (2020). Identification of eight-protein biosignature for diagnosis of tuberculosis. *Thorax*, 75(7), 576–583. <https://doi.org/10.1136/thoraxjnl-2018-213021>

CHAPTER 2

TANTANGAN KESEHATAN MENTAL PASCA PERSALINAN

Bdn. Nurun Ayati Khasanah, SST., S.KM., M.Kes.

A. Pendahuluan/Prolog

Masa pasca persalinan merupakan periode krusial dalam kehidupan seorang perempuan, yang ditandai oleh berbagai perubahan signifikan, baik secara fisik, psikologis, maupun emosional. Selama masa ini, kesehatan mental ibu menjadi perhatian penting yang perlu mendapatkan penanganan khusus, mengingat kesejahteraan mental yang optimal sangat menentukan kualitas hidup ibu dan memberikan dampak langsung terhadap tumbuh kembang bayi, serta harmoni dalam kehidupan keluarga secara keseluruhan. Sayangnya, kondisi kesehatan mental pasca persalinan sering kali kurang mendapat perhatian yang memadai, baik dari ibu sendiri maupun dari lingkungan terdekat dan tenaga kesehatan.

Dalam perspektif kesehatan masyarakat, pemahaman mengenai pentingnya kesehatan mental pasca persalinan memiliki urgensi tinggi karena gangguan mental yang dialami ibu setelah melahirkan tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri, tetapi juga mempengaruhi kemampuan ibu dalam memberikan perawatan optimal kepada bayi yang baru lahir. Sebagai contoh, ibu yang mengalami depresi pasca persalinan cenderung mengalami kesulitan dalam membangun hubungan emosional yang sehat dengan bayinya, yang pada akhirnya bisa mempengaruhi tumbuh kembang emosi dan sosial anak di masa depan. Bayi yang tidak mendapatkan stimulasi emosional dan interaksi yang hangat secara konsisten dari ibunya juga lebih rentan mengalami gangguan tumbuh kembang, seperti gangguan perkembangan bahasa, emosional, maupun sosial.

Tidak hanya berdampak pada bayi, gangguan kesehatan mental ibu juga memiliki konsekuensi jangka panjang terhadap kualitas hidup ibu sendiri. Gangguan mental yang tidak terdeteksi atau tidak tertangani dengan baik akan menyebabkan ibu mengalami berbagai masalah, mulai dari kelelahan kronis, isolasi sosial, menurunnya produktivitas, hingga gangguan hubungan interpersonal dengan pasangan maupun anggota keluarga lainnya. Bahkan dalam kasus yang parah, kondisi tersebut bisa mengarah pada gangguan psikologis yang lebih serius seperti depresi mayor atau gangguan kecemasan yang berlangsung lama, yang selanjutnya menurunkan kualitas hidup ibu secara signifikan.

Di samping itu, tantangan kesehatan mental pasca persalinan juga memberikan dampak besar pada keharmonisan keluarga secara keseluruhan. Sebuah keluarga yang anggotanya mengalami masalah kesehatan mental, terutama ibu, sering kali menghadapi tantangan dalam menjaga kestabilan dan harmoni hubungan antar anggota keluarga. Kecemasan, depresi, atau bahkan gangguan emosional lainnya yang dialami ibu pasca persalinan dapat menyebabkan meningkatnya ketegangan dalam keluarga, terutama dalam hubungan dengan pasangan atau suami. Pasangan yang kurang memahami atau tidak mengetahui kondisi yang dialami oleh ibu bisa menimbulkan kesalahpahaman, ketidaknyamanan, atau bahkan konflik yang serius, yang selanjutnya mengurangi dukungan emosional yang sangat dibutuhkan ibu dalam menjalani masa-masa adaptasi setelah melahirkan.

Mengingat besarnya dampak gangguan kesehatan mental pasca persalinan ini, maka pemahaman tentang kesehatan mental ibu setelah melahirkan menjadi sangat esensial. Pemahaman ini penting tidak hanya bagi ibu sendiri, tetapi juga bagi keluarga, masyarakat, serta tenaga kesehatan sebagai pihak yang terlibat langsung dalam memberikan pelayanan kesehatan pasca persalinan. Dengan memahami pentingnya isu ini, setiap pihak akan mampu mengidentifikasi sejak dini tanda-tanda gangguan mental yang muncul setelah melahirkan, sehingga dapat melakukan intervensi yang tepat dan memberikan dukungan yang dibutuhkan secara cepat dan efektif.

Oleh karena itu, upaya-upaya dalam meningkatkan pemahaman mengenai tantangan kesehatan mental pasca persalinan harus menjadi perhatian prioritas dalam program kesehatan ibu dan anak. Edukasi kesehatan mental bagi ibu hamil dan keluarganya, pelatihan bagi tenaga kesehatan dalam mengenali gejala-gejala gangguan mental secara dini, serta penyediaan layanan dukungan psikologis yang mudah diakses menjadi bagian integral dalam mengatasi tantangan ini. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi kesehatan mental ibu, tetapi juga merupakan bentuk investasi dalam memastikan masa depan generasi yang lebih sehat secara mental dan emosional. Melalui upaya ini, diharapkan tercipta keluarga yang sejahtera secara holistik, di mana ibu mampu menjalankan perannya secara optimal, bayi tumbuh dan berkembang secara sehat, serta keluarga secara keseluruhan dapat menjalani kehidupan yang harmonis dan penuh kebahagiaan.

B. Kondisi Psikologis Umum pada Masa Pasca Persalinan

Masa pasca persalinan adalah periode yang kompleks, di mana seorang ibu mengalami berbagai perubahan psikologis dan emosional yang cukup signifikan. Perubahan tersebut tidak hanya diakibatkan oleh faktor fisik, seperti pemulihan

tubuh setelah melahirkan dan perubahan hormon yang drastis, namun juga sangat dipengaruhi oleh penyesuaian peran baru sebagai seorang ibu, serta tekanan psikologis yang muncul dari harapan maupun tantangan dalam mengasuh bayi yang baru lahir. Perubahan psikologis ini sangat wajar, namun seringkali menimbulkan ketidaknyamanan bahkan kesulitan bagi ibu, terutama bila tidak didukung oleh pemahaman yang baik dari lingkungan sekitar.

Salah satu kondisi psikologis yang sangat umum dirasakan oleh ibu pada masa ini adalah kecemasan. Perasaan cemas ini biasanya muncul sebagai respons alami terhadap berbagai tantangan baru dalam merawat bayi, seperti khawatir akan kemampuan merawat bayi dengan baik, ketakutan akan terjadinya sesuatu yang buruk pada bayi, hingga rasa khawatir yang berlebihan terhadap kesehatan bayi maupun dirinya sendiri. Kecemasan tersebut dapat bervariasi mulai dari tingkat yang ringan hingga sangat berat. Dalam bentuk yang ringan, kecemasan biasanya bersifat sementara dan dapat mereda seiring waktu. Namun, pada tingkat yang lebih serius, kecemasan ini bisa berubah menjadi gangguan kecemasan pasca persalinan yang ditandai dengan pikiran yang terus-menerus mengganggu, rasa khawatir berlebihan yang sulit dikendalikan, hingga gangguan fisik seperti jantung berdebar, sulit tidur, dan gangguan konsentrasi.

Selain kecemasan, kelelahan emosional juga sering dialami oleh ibu pasca melahirkan. Kelelahan emosional ini berbeda dari sekadar rasa lelah secara fisik. Kondisi ini merupakan perpaduan antara kelelahan fisik akibat kurang tidur serta kelelahan mental akibat tuntutan emosional yang tinggi selama masa penyesuaian sebagai ibu baru. Seorang ibu yang baru melahirkan seringkali harus menghadapi kondisi tidur yang tidak teratur, terbangun berulang kali pada malam hari, serta tugas baru dalam merawat bayi yang membutuhkan perhatian sepanjang waktu. Jika kondisi ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama tanpa adanya dukungan emosional yang memadai dari lingkungan sekitar, ibu berisiko mengalami kelelahan emosional yang signifikan. Akibatnya, ibu mungkin akan merasakan energi yang sangat rendah, motivasi yang menurun, mudah menangis, sulit berkonsentrasi, hingga menurunnya rasa percaya diri dalam menjalani perannya sebagai ibu.

Perubahan suasana hati, atau yang dikenal sebagai mood swings, juga merupakan hal yang umum dialami ibu setelah persalinan. Perubahan suasana hati ini seringkali disebabkan oleh fluktuasi hormon estrogen dan progesteron yang turun drastis setelah proses melahirkan. Gejala perubahan suasana hati biasanya tampak jelas dalam bentuk perubahan emosi yang tiba-tiba dan intens, seperti perasaan bahagia yang tiba-tiba berganti dengan sedih, merasa sangat antusias yang berganti dengan rasa putus asa, atau rasa tenang yang tiba-tiba berubah menjadi mudah tersinggung tanpa alasan jelas. Pada sebagian besar ibu, perubahan

suasana hati ini umumnya berlangsung singkat dan relatif ringan, yang dikenal dengan istilah baby blues. Biasanya kondisi ini mulai dirasakan sekitar hari ketiga hingga kelima setelah persalinan dan umumnya akan mereda dalam dua minggu pertama.

Namun demikian, bila perubahan suasana hati berlangsung dalam waktu yang lama, lebih intens, serta berdampak pada kemampuan ibu dalam merawat bayi dan dirinya sendiri, kondisi ini bisa berkembang menjadi depresi pasca persalinan (postpartum depression). Depresi pasca persalinan merupakan gangguan psikologis yang lebih serius, dengan gejala seperti rasa sedih yang berkepanjangan, kehilangan minat terhadap aktivitas yang biasanya dinikmati, perasaan tidak berharga atau bersalah secara berlebihan, serta pikiran negatif bahkan keinginan untuk menyakiti diri sendiri maupun bayinya. Kondisi ini memerlukan perhatian khusus serta intervensi profesional untuk mencegah dampak yang lebih serius pada ibu, bayi, dan keluarga secara keseluruhan.

Dalam banyak kasus, ibu pasca persalinan juga mengalami perasaan terisolasi atau kesepian, terutama jika mereka tidak mendapatkan dukungan sosial dan emosional yang cukup dari pasangan, keluarga, atau lingkungan sosialnya. Banyak ibu merasa bahwa mereka menghadapi tantangan besar dalam perannya sebagai ibu tanpa memiliki tempat untuk berbagi perasaan dan kekhawatiran mereka. Rasa terisolasi ini semakin diperparah jika pasangan atau keluarga kurang memberikan dukungan emosional, tidak memahami perubahan emosional yang dialami ibu, atau memberikan tekanan dalam bentuk tuntutan yang tidak realistis terhadap peran barunya sebagai ibu.

C. Baby Blues: Gejala, Penyebab, dan Dampaknya

Baby blues merupakan fenomena psikologis yang sangat umum dialami oleh ibu pasca persalinan, biasanya muncul dalam beberapa hari pertama setelah melahirkan dan umumnya berlangsung hingga dua minggu setelah persalinan. Meskipun kondisi ini seringkali dianggap ringan dan bersifat sementara, namun penting untuk memahami baby blues secara mendalam karena fenomena ini bisa berdampak pada kondisi emosional ibu, hubungan ibu dengan bayi, serta kondisi keluarga secara keseluruhan.

Gejala-gejala baby blues cukup khas dan biasanya muncul antara hari ketiga hingga hari kelima setelah melahirkan, ketika perubahan hormon dalam tubuh ibu sangat signifikan. Gejala ini ditandai oleh fluktuasi perasaan yang cepat dan tidak menentu, seperti munculnya perasaan sedih yang mendalam tanpa alasan yang jelas, menangis secara tiba-tiba, mudah tersinggung, merasa kewalahan dengan tanggung jawab baru, dan perasaan tidak percaya diri dalam merawat bayi. Ibu juga

sering merasa cemas, gelisah, atau mengalami kebingungan dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi sehari-hari pasca persalinan. Selain itu, ibu yang mengalami baby blues kerap merasa sangat kelelahan, baik secara fisik maupun emosional, sulit untuk berkonsentrasi, serta kesulitan untuk mendapatkan istirahat yang berkualitas walaupun memiliki kesempatan untuk tidur. Kondisi ini menyebabkan perasaan tidak nyaman yang cukup intens bagi ibu, meskipun secara umum masih mampu menjalankan aktivitas sehari-hari dan merawat bayinya dengan baik.

Ada beberapa faktor penyebab atau pemicu utama munculnya baby blues pada ibu setelah melahirkan. Faktor biologis adalah salah satu pemicu yang paling utama. Setelah melahirkan, kadar hormon estrogen dan progesteron mengalami penurunan drastis, yang mengakibatkan ketidakseimbangan hormonal. Penurunan hormon ini secara langsung mempengaruhi kerja neurotransmitter di otak, khususnya serotonin dan dopamin, yang bertanggung jawab terhadap regulasi suasana hati dan perasaan nyaman. Perubahan hormonal ini diyakini sebagai penyebab utama perubahan suasana hati yang drastis pada ibu setelah melahirkan.

Selain faktor hormonal, ada pula faktor psikologis yang berkontribusi terhadap munculnya baby blues. Setelah melahirkan, ibu dihadapkan pada perubahan peran dan identitas, dari seorang perempuan atau pasangan menjadi seorang ibu. Penyesuaian terhadap peran baru ini sering kali diiringi oleh rasa kehilangan kebebasan atau perubahan signifikan dalam rutinitas hidup, yang menyebabkan stres emosional. Perasaan kewalahan dalam menghadapi tanggung jawab baru, kurangnya pengalaman atau rasa percaya diri dalam merawat bayi, serta tekanan psikologis dari harapan diri sendiri maupun keluarga juga dapat meningkatkan risiko terjadinya baby blues.

Di samping faktor biologis dan psikologis, faktor lingkungan sosial juga memiliki peran penting dalam munculnya fenomena baby blues. Kurangnya dukungan emosional maupun sosial dari pasangan, keluarga, atau komunitas sekitar bisa memperburuk gejala baby blues yang dialami ibu. Misalnya, ibu yang merasa kurang didukung atau merasa diabaikan oleh pasangan atau keluarga dalam proses merawat bayi cenderung mengalami perasaan isolasi sosial, yang pada akhirnya memperparah kondisi emosional yang sedang rentan. Sebaliknya, ibu yang mendapat dukungan kuat dari lingkungan terdekatnya biasanya lebih mudah melewati fase baby blues ini tanpa berkembang menjadi kondisi yang lebih serius.

Meskipun baby blues dianggap sebagai kondisi ringan yang biasanya akan hilang sendiri dalam dua minggu pertama setelah persalinan, namun dampaknya terhadap ibu dan interaksi ibu-anak tidak bisa dianggap remeh. Baby blues yang tidak dikenali atau tidak didukung dengan baik berpotensi menyebabkan gangguan

emosional jangka pendek yang memengaruhi kualitas hubungan ibu dengan bayinya. Misalnya, ibu mungkin mengalami kesulitan untuk berinteraksi secara emosional dengan bayinya, seperti kesulitan merespons tangisan bayi dengan cepat atau tidak mampu memberikan perhatian dan kasih sayang secara optimal karena kondisi emosionalnya yang terganggu.

Dalam kondisi seperti ini, bayi bisa merasakan ketidakstabilan emosional ibunya, yang dapat menyebabkan bayi menjadi lebih gelisah, mudah menangis, atau sulit untuk ditenangkan. Interaksi emosional yang kurang optimal pada tahap awal kehidupan bayi bisa berdampak pada pembentukan ikatan emosional (bonding) antara ibu dan bayi, meskipun secara umum dampak ini bersifat sementara jika ibu segera mendapatkan dukungan yang tepat.

Selain itu, baby blues yang tidak tertangani dengan baik juga berisiko berkembang menjadi kondisi yang lebih serius, seperti depresi pasca persalinan atau postpartum depression. Jika gejala baby blues berlangsung lebih dari dua minggu dan semakin memburuk, hal ini merupakan tanda bahwa kondisi psikologis ibu mungkin telah berkembang menjadi depresi pasca persalinan, yang memerlukan perhatian dan intervensi profesional segera.

D. Depresi Pasca Persalinan (Postpartum Depression)

Depresi pasca persalinan atau yang dikenal secara internasional dengan istilah postpartum depression (PPD), merupakan kondisi gangguan suasana hati serius yang dialami oleh sebagian perempuan setelah melahirkan. Kondisi ini berbeda secara signifikan dari baby blues, karena gejalanya lebih berat, bertahan dalam jangka waktu yang lebih lama, dan memerlukan intervensi medis maupun psikologis yang lebih intensif. Jika baby blues umumnya berlangsung hanya dalam beberapa hari hingga dua minggu setelah persalinan, maka depresi pasca persalinan dapat bertahan selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan jika tidak segera diidentifikasi dan ditangani dengan tepat.

Secara klinis, depresi pasca persalinan ditandai oleh berbagai gejala yang lebih serius dibandingkan baby blues. Gejala yang sering muncul antara lain perasaan sedih yang mendalam, menangis secara terus-menerus tanpa alasan yang jelas, kehilangan minat terhadap berbagai aktivitas yang sebelumnya menyenangkan, serta adanya perasaan bersalah atau tidak berharga yang sulit untuk diatasi. Ibu yang mengalami depresi pasca persalinan juga sering merasa putus asa dan tidak mampu menjalankan perannya sebagai seorang ibu dengan baik. Mereka mungkin mengalami perasaan cemas yang berlebihan tentang kondisi bayi atau kemampuan mereka dalam mengasuh anak, sehingga merasa takut atau tidak percaya diri dalam

melakukan aktivitas sederhana seperti menyusui, memandikan, atau menggendong bayi.

Selain itu, depresi pasca persalinan juga ditandai oleh perubahan fisik yang signifikan, seperti gangguan tidur yang serius (baik insomnia maupun tidur yang berlebihan), gangguan pola makan (hilangnya nafsu makan atau makan secara berlebihan), serta kelelahan fisik yang berat, meskipun ibu memiliki waktu istirahat yang cukup. Dalam beberapa kasus yang berat, ibu bisa mengalami gangguan konsentrasi yang parah, sulit dalam mengambil keputusan sehari-hari, serta munculnya pikiran-pikiran negatif tentang diri sendiri atau bayinya. Bahkan dalam kasus tertentu yang paling serius, ibu bisa mengalami pikiran tentang menyakiti diri sendiri atau bayinya, yang merupakan tanda kondisi darurat medis dan memerlukan perhatian segera dari tenaga profesional kesehatan.

Faktor risiko terjadinya depresi pasca persalinan sangat beragam dan kompleks, melibatkan aspek biologis, psikologis, serta lingkungan sosial. Secara biologis, perubahan hormonal yang drastis setelah melahirkan dipercaya sebagai pemicu utama depresi pasca persalinan. Penurunan hormon estrogen, progesteron, dan perubahan kadar hormon tiroid secara tajam dapat mengganggu regulasi neurotransmitter di otak, yang secara langsung mempengaruhi suasana hati dan kestabilan emosional ibu.

Selain faktor biologis, ada pula faktor psikologis yang signifikan dalam meningkatkan risiko terjadinya depresi pasca persalinan. Faktor psikologis tersebut meliputi riwayat gangguan mental sebelumnya, khususnya gangguan suasana hati seperti depresi atau gangguan kecemasan selama kehamilan, serta adanya stres berat atau trauma emosional yang dialami selama proses kehamilan atau persalinan. Tekanan psikologis terkait harapan diri sendiri atau lingkungan sosial tentang peran baru sebagai seorang ibu juga bisa memicu atau memperparah kondisi ini. Ibu yang memiliki harga diri yang rendah, perfeksionisme yang tinggi, atau memiliki kepribadian yang rentan terhadap stres, juga lebih berisiko mengalami depresi pasca persalinan.

Faktor sosial juga memiliki peran besar dalam terjadinya depresi pasca persalinan. Kurangnya dukungan emosional dan praktis dari pasangan, keluarga, dan komunitas merupakan salah satu faktor risiko penting. Ibu yang tidak memiliki dukungan yang memadai cenderung merasa terisolasi dan tidak memiliki tempat untuk berbagi beban emosionalnya, sehingga semakin memperparah kondisi depresinya. Faktor lain seperti konflik rumah tangga, kesulitan ekonomi, atau kurangnya akses terhadap layanan kesehatan yang baik juga turut meningkatkan risiko depresi pasca persalinan.

Konsekuensi dari depresi pasca persalinan sangat serius, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, dan berdampak tidak hanya pada ibu tetapi juga pada bayi dan keluarga secara keseluruhan. Dalam jangka pendek, depresi ini secara langsung mempengaruhi kualitas hidup ibu, yang ditandai dengan penurunan fungsi sehari-hari, ketidakmampuan menjalankan peran ibu secara optimal, serta kesulitan dalam membangun ikatan emosional yang kuat dengan bayinya. Ibu yang mengalami depresi pasca persalinan cenderung memiliki interaksi emosional yang minim atau kurang responsif terhadap kebutuhan bayi, yang pada akhirnya dapat mengganggu proses pembentukan bonding (ikatan batin) antara ibu dan bayi. Akibatnya, bayi bisa mengalami gangguan perkembangan emosional dan sosial, seperti menjadi mudah rewel, mengalami kesulitan tidur, atau bahkan mengalami hambatan dalam perkembangan sosial-emosional mereka.

Dalam jangka panjang, konsekuensi dari depresi pasca persalinan bisa lebih serius lagi. Depresi yang tidak ditangani dengan baik memiliki risiko tinggi untuk berkembang menjadi kondisi kronis yang lebih sulit diatasi. Pada ibu, kondisi ini bisa mengarah pada depresi jangka panjang yang mempengaruhi hubungan dengan pasangan, keluarga, atau lingkungan sosialnya. Risiko gangguan mental lain seperti gangguan kecemasan atau gangguan panik juga meningkat secara signifikan pada ibu yang mengalami depresi pasca persalinan. Selain itu, ibu dengan depresi pasca persalinan juga memiliki risiko tinggi mengalami depresi berulang pada kehamilan atau persalinan berikutnya.

Dampak jangka panjang terhadap anak juga tidak boleh diabaikan. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang ibunya mengalami depresi pasca persalinan yang tidak tertangani dengan baik memiliki risiko yang lebih tinggi mengalami gangguan emosional, sosial, bahkan gangguan kognitif di kemudian hari. Mereka mungkin mengalami keterlambatan dalam perkembangan bahasa dan kemampuan kognitif, memiliki masalah perilaku seperti sulit menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, serta lebih rentan mengalami gangguan kecemasan atau depresi di kemudian hari.

Mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan oleh depresi pasca persalinan, sangat penting bagi tenaga kesehatan, keluarga, dan komunitas untuk mengenali gejala-gejala awal dari kondisi ini dan segera memberikan intervensi yang tepat. Deteksi dini melalui skrining rutin pasca persalinan, pemberian edukasi kesehatan mental pada ibu dan keluarga, serta tersedianya dukungan emosional yang kuat dari lingkungan sekitar sangatlah krusial untuk mencegah terjadinya depresi pasca persalinan yang berat. Jika depresi pasca persalinan telah terjadi, intervensi seperti terapi psikologis (terutama cognitive-behavioral therapy atau CBT), konseling dukungan kelompok, serta pengobatan farmakologis dengan antidepresan dalam

pengawasan ketat tenaga kesehatan, terbukti efektif dalam mempercepat pemulihan ibu dan meminimalkan dampak negatif jangka panjang dari kondisi ini. Dukungan holistik yang tepat waktu dan tepat sasaran akan membantu ibu untuk pulih secara optimal, memperbaiki hubungan dengan bayinya, serta meningkatkan kualitas hidup seluruh keluarga secara signifikan.

E. Gangguan Kecemasan Pasca Persalinan (Postpartum Anxiety)

Gangguan kecemasan pasca persalinan atau yang secara luas dikenal dengan istilah Postpartum Anxiety merupakan salah satu kondisi psikologis serius yang dialami oleh sebagian perempuan setelah melahirkan, ditandai dengan munculnya rasa cemas yang intens, berlebihan, serta sulit dikendalikan. Kondisi ini berbeda dari rasa khawatir atau kecemasan umum yang mungkin dialami oleh sebagian besar ibu baru. Postpartum anxiety memiliki intensitas dan frekuensi yang jauh lebih tinggi, bahkan dapat mengganggu kehidupan sehari-hari ibu secara signifikan, mengurangi kemampuannya dalam mengasuh bayi, serta berinteraksi secara positif dengan lingkungan sosialnya.

Secara umum, postpartum anxiety ditandai oleh berbagai gejala psikologis maupun fisik yang sangat nyata. Gejala psikologis yang sering dialami oleh ibu dengan kondisi ini mencakup rasa khawatir berlebihan tentang kesehatan atau keselamatan bayinya, ketakutan yang tidak realistis terkait kemampuan diri dalam mengurus anak, serta pikiran-pikiran negatif yang sulit dihentikan. Ibu yang mengalami gangguan kecemasan pasca persalinan sering merasa tidak tenang, waspada berlebihan terhadap kemungkinan hal buruk yang bisa menimpa bayi atau dirinya sendiri, bahkan untuk hal-hal kecil yang seharusnya tidak menimbulkan kecemasan besar. Rasa takut ini bisa sangat mengganggu sehingga membuat ibu mengalami kesulitan tidur, karena pikirannya terus dipenuhi oleh berbagai skenario negatif yang sulit dikendalikan.

Selain itu, postpartum anxiety juga bisa memunculkan serangan panik atau panic attack, yakni kondisi tiba-tiba munculnya rasa takut yang amat intens tanpa penyebab yang jelas, disertai gejala fisik yang mencolok seperti jantung berdebar kencang, nyeri dada, sesak napas, pusing, keringat dingin, hingga rasa seperti kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Serangan panik ini biasanya berlangsung beberapa menit, namun bagi ibu yang mengalaminya, durasi tersebut terasa jauh lebih lama karena intensitas ketakutannya. Pengalaman serangan panik yang berulang dapat membuat ibu semakin merasa takut, bahkan untuk melakukan aktivitas sehari-hari yang normal sekalipun, karena khawatir serangan tersebut muncul kembali.

Postpartum anxiety tidak hanya mempengaruhi kesehatan mental ibu, tetapi juga secara nyata berdampak terhadap fungsi kesehariannya dalam berbagai aspek kehidupan. Kecemasan yang intens dan serangan panik dapat membuat ibu merasa tidak mampu menjalankan aktivitas sederhana, seperti merawat bayi, menyusui, mengganti popok, atau bahkan meninggalkan rumah untuk sekadar berbelanja kebutuhan sehari-hari. Ibu mungkin akan menghindari situasi atau tempat yang dianggap dapat memicu kecemasan, sehingga menjadi semakin terisolasi dari kehidupan sosial. Dampaknya tidak hanya pada ibu, tetapi juga pada bayi dan keluarga, karena ibu mungkin tidak mampu memenuhi kebutuhan emosional bayinya secara optimal akibat kecemasan yang terus-menerus dirasakan.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan gangguan kecemasan pasca persalinan sangat bervariasi dan kompleks. Secara biologis, kondisi ini sangat terkait erat dengan fluktuasi hormonal setelah persalinan, terutama penurunan tajam hormon estrogen dan progesteron yang berperan dalam pengaturan suasana hati dan emosi. Selain faktor biologis, faktor psikologis juga memegang peran penting dalam kemunculan postpartum anxiety. Perempuan yang memiliki riwayat kecemasan atau gangguan mental lainnya, mengalami stres tinggi selama kehamilan, atau menghadapi komplikasi persalinan yang berat, lebih rentan mengalami gangguan ini. Demikian pula perempuan dengan kepribadian perfeksionis atau yang memiliki ekspektasi yang sangat tinggi terhadap dirinya sendiri sebagai ibu baru, juga cenderung mengalami tekanan psikologis yang besar, meningkatkan risiko munculnya kecemasan pasca persalinan.

Lebih jauh, faktor sosial dan lingkungan memiliki pengaruh yang tidak kalah besar. Kurangnya dukungan emosional dan sosial dari pasangan, keluarga, atau komunitas di sekitarnya menjadi salah satu pemicu utama munculnya gangguan kecemasan pasca persalinan. Ketika ibu merasa harus menghadapi segala tanggung jawab mengasuh anak sendirian tanpa dukungan memadai, tekanan emosional yang muncul semakin besar, memicu kecemasan yang berlebih. Kondisi finansial yang tidak stabil atau adanya konflik rumah tangga juga memperparah kondisi ini, karena menambah beban pikiran yang dirasakan ibu.

Dampak dari gangguan kecemasan pasca persalinan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga dapat berlanjut menjadi kondisi kronis jika tidak mendapatkan perhatian atau penanganan yang tepat. Dalam jangka pendek, ibu yang mengalami postpartum anxiety biasanya akan mengalami penurunan kualitas hidup yang drastis, kehilangan kepercayaan diri sebagai seorang ibu, serta merasa tidak mampu menjalin hubungan yang dekat secara emosional dengan bayinya. Interaksi ibu-anak dapat terganggu karena ibu sulit menikmati waktu bersama bayinya, lebih sering merasa tertekan dan khawatir daripada merasa bahagia dan

tenang. Hal ini dapat menghambat proses terbentuknya bonding yang kuat antara ibu dan bayi, yang sangat penting dalam tahap awal perkembangan anak.

Dalam jangka panjang, postpartum anxiety yang tidak ditangani dengan tepat berisiko berkembang menjadi gangguan kecemasan kronis, bahkan bisa menjadi pemicu munculnya gangguan mental lainnya seperti depresi pasca persalinan yang lebih berat. Risiko gangguan kecemasan berulang juga meningkat pada kehamilan atau persalinan berikutnya, sehingga memperpanjang dampak negatif yang dirasakan oleh ibu. Anak-anak yang ibunya mengalami gangguan kecemasan yang berat dan berkepanjangan juga berisiko mengalami hambatan dalam perkembangan sosial dan emosional mereka, termasuk menjadi lebih mudah mengalami kecemasan di kemudian hari.

Oleh karena itu, sangat penting bagi tenaga kesehatan, pasangan, keluarga, serta komunitas di sekitar ibu untuk mengenali secara dini tanda-tanda gangguan kecemasan pasca persalinan. Pemeriksaan atau skrining rutin oleh tenaga kesehatan pada kunjungan kontrol setelah persalinan sangat dianjurkan untuk mengidentifikasi gejala-gejala awal postpartum anxiety, sehingga intervensi bisa segera diberikan sebelum kondisi semakin parah. Pendekatan yang efektif dalam menangani gangguan kecemasan ini biasanya mencakup intervensi psikologis, seperti terapi kognitif-perilaku (CBT), konseling, serta dukungan psikososial yang kuat dari pasangan, keluarga, maupun komunitas. Dalam beberapa kasus, penggunaan terapi farmakologis seperti obat anti-kecemasan di bawah pengawasan tenaga medis juga dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari strategi pengobatan.

Dengan intervensi yang tepat, ibu yang mengalami gangguan kecemasan pasca persalinan bisa pulih sepenuhnya, menjalani perannya sebagai seorang ibu dengan lebih tenang dan percaya diri, serta membangun hubungan emosional yang sehat dan positif dengan bayinya. Dukungan holistik dan komprehensif dari lingkungan sekitar memainkan peran krusial dalam proses pemulihan ini, membantu ibu melewati masa transisi yang penuh tantangan dengan lebih nyaman, kuat, dan optimis.

F. Gangguan Psikosis Pasca Persalinan (Postpartum Psychosis)

Gangguan psikosis pasca persalinan, atau dikenal dalam istilah medis sebagai Postpartum Psychosis, merupakan suatu kondisi kesehatan mental yang sangat serius dan berat, meskipun angka kejadiannya relatif jarang dibandingkan dengan baby blues atau depresi pasca persalinan. Kondisi ini umumnya muncul secara mendadak, biasanya dalam beberapa hari hingga minggu pertama setelah

persalinan, dan membutuhkan penanganan medis segera karena memiliki potensi bahaya bagi ibu maupun bayinya.

Postpartum psychosis ditandai oleh munculnya berbagai gangguan berat pada persepsi, pemikiran, serta emosi ibu yang mengalami kondisi ini. Gejala-gejala yang muncul sering kali intens, dramatis, dan dapat membuat ibu kehilangan kontak dengan realitas atau lingkungan sekitar. Salah satu gejala utama adalah munculnya delusi, yaitu keyakinan atau pemikiran yang keliru, tidak realistis, namun diyakini sepenuhnya oleh ibu. Contoh delusi yang umum terjadi antara lain ibu merasa dirinya atau bayinya sedang dalam bahaya besar yang tidak nyata, atau ibu meyakini bahwa dirinya memiliki kekuatan khusus yang berhubungan dengan bayinya.

Selain delusi, halusinasi juga merupakan salah satu gejala khas dari psikosis postpartum. Halusinasi bisa terjadi dalam berbagai bentuk, misalnya mendengar suara-suara yang tidak nyata (halusinasi pendengaran), melihat gambaran atau sosok yang tidak ada (halusinasi penglihatan), atau bahkan merasakan sensasi fisik tertentu tanpa adanya rangsangan nyata. Kondisi ini sangat membingungkan dan menakutkan bagi ibu yang mengalaminya, karena pengalaman tersebut terasa sangat nyata, jelas, dan tidak bisa dibedakan dari realitas sehari-hari.

Gangguan ini juga ditandai oleh perubahan suasana hati yang sangat ekstrem, cepat, dan tidak stabil. Ibu bisa mengalami perubahan mood yang mendadak dari perasaan bahagia berlebihan menjadi sangat sedih, marah, gelisah, atau cemas dalam waktu singkat tanpa pemicu jelas. Dalam beberapa kasus, kondisi ini juga dapat menyebabkan agitasi ekstrem atau sebaliknya, ibu menjadi sangat lesu, tidak responsif, dan menarik diri sepenuhnya dari lingkungan sekitar. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada kondisi psikologis ibu, tetapi juga membuatnya sangat sulit menjalankan peran dan tugas sehari-hari, termasuk merawat bayi atau berinteraksi dengan keluarganya secara normal.

Secara umum, postpartum psychosis sering kali muncul tiba-tiba tanpa gejala pendahuluan yang jelas. Akan tetapi, beberapa faktor risiko diketahui dapat meningkatkan kemungkinan seorang perempuan mengalami kondisi ini. Salah satu faktor yang paling signifikan adalah riwayat gangguan bipolar atau skizofrenia sebelumnya, serta riwayat psikosis pada kehamilan atau persalinan sebelumnya. Selain itu, riwayat keluarga yang memiliki gangguan kesehatan mental serius juga meningkatkan risiko psikosis postpartum. Faktor biologis juga berperan penting dalam memicu kondisi ini, terutama fluktuasi ekstrem hormon setelah persalinan yang secara signifikan mempengaruhi fungsi otak dan neurotransmitter yang bertanggung jawab atas regulasi suasana hati, emosi, dan persepsi.

Faktor lain yang berperan adalah stres psikologis ekstrem selama kehamilan atau setelah melahirkan, termasuk komplikasi medis selama persalinan, kelahiran

bayi prematur, trauma emosional akibat proses persalinan, serta kurangnya dukungan sosial dan emosional dari lingkungan sekitar. Kondisi kelelahan fisik berat yang dialami ibu baru setelah persalinan, terutama jika disertai kurang tidur kronis, juga dapat memperburuk risiko munculnya psikosis postpartum.

Postpartum psychosis merupakan kondisi kegawatdaruratan medis yang harus segera ditangani dengan serius karena memiliki implikasi yang sangat berbahaya bagi ibu dan bayi. Jika tidak segera mendapatkan penanganan yang tepat, ibu berisiko tinggi mengalami perilaku yang berbahaya, termasuk menyakiti diri sendiri atau bayinya. Dalam beberapa kasus yang ekstrem, ibu dapat mengalami pikiran atau dorongan untuk melakukan tindakan kekerasan yang membahayakan keselamatan dirinya atau bayinya akibat halusinasi atau delusi yang dialami. Oleh karena itu, begitu tanda-tanda awal psikosis postpartum terdeteksi, ibu harus segera mendapatkan bantuan medis di fasilitas kesehatan terdekat.

Penanganan gangguan psikosis pasca persalinan umumnya melibatkan pendekatan multidisiplin yang komprehensif, melibatkan psikiater, psikolog klinis, dokter kandungan, serta perawat dan bidan yang berpengalaman dalam kesehatan mental ibu. Pada tahap awal, ibu mungkin membutuhkan rawat inap di rumah sakit untuk memastikan keselamatan dirinya dan bayinya. Terapi farmakologis, seperti penggunaan antipsikotik, penstabil mood, atau obat-obatan lain yang tepat, biasanya diberikan untuk membantu mengendalikan gejala psikosis secara cepat dan efektif. Selain itu, terapi elektrokonvulsif (ECT) dalam kondisi tertentu juga bisa dipertimbangkan, terutama jika respons terhadap pengobatan farmakologis tidak optimal.

Setelah kondisi akut teratasi, terapi psikologis intensif berupa psikoterapi individu maupun terapi kelompok sangat dianjurkan untuk membantu ibu memahami apa yang dialaminya, mengembangkan strategi koping yang lebih sehat, serta memperkuat dukungan sosial yang dibutuhkan dalam proses pemulihan. Dukungan keluarga dalam bentuk edukasi dan konseling juga sangat krusial agar keluarga dapat memahami kondisi ibu dengan baik dan memberikan bantuan yang efektif selama masa pemulihan.

Dalam jangka panjang, ibu yang pernah mengalami psikosis postpartum harus mendapatkan pemantauan yang ketat dari tenaga kesehatan karena risiko kambuh cukup tinggi pada kehamilan atau persalinan berikutnya. Dengan dukungan medis, psikologis, dan sosial yang optimal, perempuan yang mengalami kondisi ini umumnya bisa pulih sepenuhnya dan kembali menjalani kehidupan normal, termasuk menjalankan perannya sebagai ibu dengan sehat dan stabil secara emosional.

Kesadaran dan edukasi mengenai psikosis postpartum harus ditingkatkan di masyarakat, tenaga kesehatan, dan keluarga, agar gejala-gejala awal dapat segera dikenali dan ditangani. Upaya preventif juga perlu dilakukan melalui pemeriksaan dan evaluasi kesehatan mental secara rutin selama kehamilan, terutama pada perempuan yang memiliki faktor risiko tinggi, sehingga risiko terjadinya gangguan ini dapat diminimalkan, dan ibu bisa menjalani masa pasca persalinan dengan lebih aman, sehat, dan bahagia.

G. Faktor Risiko yang Meningkatkan Tantangan Kesehatan Mental Pasca Persalinan

Kesehatan mental pasca persalinan merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan seorang ibu, karena kondisi mental yang kurang baik tidak hanya berdampak terhadap dirinya sendiri, tetapi juga terhadap bayi dan keluarganya secara keseluruhan. Dalam konteks ini, penting untuk memahami berbagai faktor risiko yang berkontribusi dalam meningkatkan kemungkinan terjadinya gangguan mental pasca persalinan. Identifikasi dini terhadap faktor risiko ini sangat esensial untuk melakukan pencegahan maupun intervensi yang tepat, sehingga dampak negatif yang ditimbulkan dapat diminimalisasi atau bahkan dicegah sepenuhnya.

Salah satu faktor risiko yang memiliki kontribusi signifikan terhadap munculnya gangguan mental pasca persalinan adalah riwayat gangguan mental sebelumnya. Seorang ibu yang pernah mengalami depresi, kecemasan, atau gangguan psikologis lainnya sebelum atau selama kehamilan memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami masalah mental setelah melahirkan. Riwayat gangguan bipolar, depresi mayor, kecemasan berat, atau gangguan obsesif-kompulsif adalah kondisi yang sering kali berulang atau semakin memburuk selama masa-masa rentan seperti pasca persalinan. Kondisi-kondisi tersebut bisa muncul kembali atau bahkan meningkat intensitasnya, terutama akibat fluktuasi hormon secara dramatis setelah melahirkan, yang secara signifikan mempengaruhi suasana hati, emosi, dan kestabilan psikologis ibu.

Selain riwayat pribadi gangguan mental, faktor genetik dan riwayat keluarga dengan gangguan mental juga meningkatkan risiko gangguan kesehatan mental setelah persalinan. Jika ada anggota keluarga dekat seperti ibu kandung, saudara kandung, atau kerabat dekat lainnya yang pernah mengalami gangguan mental pasca persalinan, maka risiko ibu untuk mengalami kondisi serupa meningkat secara substansial. Hal ini disebabkan oleh kombinasi antara faktor biologis, yaitu kecenderungan genetik terhadap gangguan suasana hati, dengan faktor lingkungan yang mungkin juga kurang suportif dalam membantu ibu menjalani periode adaptasi setelah melahirkan.

Faktor penting lainnya yang memperbesar risiko gangguan mental pasca persalinan adalah kurangnya dukungan sosial yang efektif dari lingkungan terdekat ibu, terutama dari pasangan, keluarga, serta komunitas sosial di sekitarnya. Dukungan sosial yang lemah dapat memperparah rasa isolasi, kesepian, serta kelelahan emosional yang umumnya dialami oleh ibu baru. Kondisi ini seringkali muncul akibat kurangnya bantuan praktis dalam perawatan bayi, minimnya dukungan emosional seperti perhatian, empati, validasi, serta komunikasi yang positif dari orang-orang terdekat. Tanpa dukungan sosial yang memadai, ibu baru cenderung merasa sendirian dalam menghadapi tekanan serta perubahan drastis dalam hidupnya, sehingga lebih rentan terhadap gangguan emosional seperti kecemasan, depresi, bahkan gangguan yang lebih serius seperti psikosis postpartum.

Kondisi ekonomi yang sulit juga merupakan faktor risiko yang signifikan dalam memperbesar tantangan kesehatan mental ibu pasca persalinan. Kesulitan ekonomi dapat menciptakan stres tambahan yang sangat besar bagi seorang ibu yang baru saja melahirkan. Keterbatasan finansial membuat ibu sering kali merasa khawatir tentang kemampuan memenuhi kebutuhan dasar bayi seperti makanan, pakaian, pengobatan, serta kebutuhan rumah tangga lainnya. Rasa khawatir yang berlebihan terkait kondisi finansial yang tidak stabil ini secara signifikan meningkatkan beban emosional dan psikologis yang dialami ibu, yang pada akhirnya dapat memicu atau memperburuk berbagai kondisi gangguan mental, khususnya kecemasan dan depresi pasca persalinan. Stres akibat masalah ekonomi juga memperbesar risiko munculnya konflik interpersonal dalam keluarga, yang selanjutnya memperparah kondisi emosional ibu yang sedang rentan.

Lebih jauh lagi, hubungan keluarga yang kurang harmonis atau mengalami konflik yang terus-menerus selama masa kehamilan atau setelah melahirkan juga menjadi faktor risiko serius. Ketidakstabilan hubungan pasangan, misalnya adanya perselisihan terus-menerus, kurangnya komunikasi positif, atau bahkan kekerasan dalam rumah tangga, secara nyata meningkatkan tekanan psikologis ibu. Kondisi seperti ini dapat menyebabkan ibu mengalami stres kronis, rasa tidak aman, serta ketakutan yang signifikan, yang pada akhirnya berdampak langsung terhadap kestabilan mental pasca persalinan. Situasi konflik keluarga juga memengaruhi kemampuan ibu dalam membangun hubungan positif dengan bayi, yang pada akhirnya bisa berdampak buruk pada kualitas interaksi ibu-anak dan perkembangan psikososial anak dalam jangka panjang.

Di samping itu, kondisi fisik selama atau setelah persalinan juga berkontribusi sebagai faktor risiko yang memperburuk tantangan kesehatan mental. Komplikasi medis selama proses persalinan seperti pendarahan berat, operasi caesar darurat,

atau kondisi bayi yang membutuhkan perawatan intensif dapat menyebabkan trauma emosional yang signifikan bagi ibu. Selain itu, kondisi fisik pasca melahirkan yang menyakitkan, seperti kesulitan pemulihan, nyeri kronis, atau masalah kesehatan lainnya, dapat memperburuk stres emosional serta meningkatkan risiko munculnya depresi atau kecemasan yang parah.

Terakhir, harapan sosial yang tidak realistis terkait peran ibu baru juga dapat menjadi faktor risiko tambahan yang memperberat tantangan kesehatan mental pasca persalinan. Ekspektasi masyarakat yang tinggi terhadap ibu untuk selalu mampu, bahagia, dan sempurna dalam menjalankan peran barunya dapat membuat ibu merasa tidak cukup baik atau gagal, yang selanjutnya memperburuk perasaan cemas, rendah diri, dan depresi. Kurangnya edukasi tentang realitas kehidupan pasca melahirkan juga menyebabkan banyak ibu merasa tidak siap menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi.

Memahami berbagai faktor risiko ini menjadi langkah awal yang sangat penting dalam upaya mengurangi dampak negatif terhadap kesehatan mental ibu pasca persalinan. Deteksi dini, intervensi yang tepat, serta pemberian dukungan sosial dan psikologis secara menyeluruh dari keluarga, tenaga kesehatan, maupun komunitas, akan sangat efektif dalam membantu ibu melewati masa transisi ini dengan lebih sehat, nyaman, serta stabil secara emosional.

H. Strategi Pencegahan dan Deteksi Dini Gangguan Kesehatan Mental Pasca Persalinan

Gangguan kesehatan mental pasca persalinan merupakan tantangan serius yang memerlukan perhatian khusus sejak awal, karena dampaknya tidak hanya memengaruhi kondisi psikologis ibu, tetapi juga memiliki konsekuensi luas terhadap perkembangan bayi dan dinamika keluarga secara keseluruhan. Oleh karena itu, sangat penting untuk menempatkan fokus pada strategi pencegahan serta deteksi dini sebagai bagian integral dari asuhan kebidanan dan pelayanan kesehatan ibu pasca persalinan. Upaya ini bertujuan untuk mengurangi risiko berkembangnya gangguan mental yang serius, serta memudahkan intervensi dini guna mencegah komplikasi lebih lanjut.

Salah satu strategi utama dalam pencegahan gangguan mental pasca persalinan adalah melalui skrining rutin yang terintegrasi ke dalam layanan antenatal maupun postnatal. Proses skrining secara rutin bertujuan untuk mengidentifikasi ibu yang memiliki faktor risiko tertentu atau sudah mulai menunjukkan tanda-tanda awal gangguan mental seperti baby blues, depresi postpartum, gangguan kecemasan, maupun gejala psikosis yang lebih serius. Idealnya, skrining kesehatan mental ibu dilakukan sejak masa kehamilan secara periodik, dilanjutkan segera

setelah persalinan, serta diikuti oleh pemeriksaan berkala selama beberapa bulan setelah ibu melahirkan.

Dalam praktiknya, alat skrining yang sering digunakan antara lain Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS), yang efektif dalam mengidentifikasi tingkat risiko depresi postpartum. Penggunaan EPDS secara rutin memungkinkan tenaga kesehatan untuk mendeteksi gejala depresi sejak dini, sehingga dapat dengan cepat merujuk ibu kepada profesional kesehatan mental yang lebih spesifik seperti psikolog atau psikiater. Dengan skrining yang dilakukan secara proaktif, ibu yang berisiko tinggi dapat segera mendapatkan intervensi yang diperlukan, sehingga potensi gangguan mental yang lebih berat bisa diminimalkan.

Selain skrining rutin, edukasi keluarga juga merupakan komponen penting dalam strategi pencegahan gangguan mental pasca persalinan. Edukasi yang diberikan kepada pasangan, keluarga dekat, maupun komunitas sekitar mengenai tantangan psikologis yang mungkin dialami ibu setelah melahirkan akan meningkatkan pemahaman dan kesadaran mereka terhadap kondisi ini. Edukasi tersebut mencakup pengetahuan tentang gejala-gejala umum gangguan mental pasca persalinan, pentingnya memberikan dukungan emosional dan praktis, serta langkah-langkah yang harus diambil jika tanda-tanda gangguan mental mulai terlihat. Keluarga yang memahami kondisi tersebut akan lebih siap dan efektif dalam memberikan dukungan yang dibutuhkan oleh ibu baru, sehingga tekanan psikologis yang dialami ibu dapat dikelola dengan lebih baik.

Lebih lanjut, peningkatan kesadaran tenaga kesehatan juga memainkan peran yang sangat vital dalam strategi pencegahan serta deteksi dini gangguan mental pasca persalinan. Tenaga kesehatan yang terlibat langsung dalam perawatan ibu—termasuk dokter, bidan, perawat, maupun konselor kesehatan mental—perlu diberikan pelatihan khusus untuk mengenali tanda-tanda awal gangguan mental yang mungkin muncul setelah ibu melahirkan. Pengetahuan ini meliputi pemahaman mengenai gejala emosional seperti perubahan suasana hati yang ekstrem, kecemasan berlebih, penurunan minat terhadap aktivitas sehari-hari, hingga perilaku yang tidak biasa atau sulit dikendalikan oleh ibu. Dengan demikian, tenaga kesehatan mampu merespons secara cepat dan tepat, memberikan dukungan awal yang diperlukan, serta merujuk ibu ke layanan spesialis jika diperlukan.

Selain upaya edukasi dan skrining, pendekatan preventif juga bisa dilakukan melalui peningkatan kualitas interaksi antara tenaga kesehatan dengan ibu dan keluarganya sejak masa kehamilan. Membangun hubungan kepercayaan serta komunikasi terbuka akan menciptakan ruang yang nyaman bagi ibu untuk berbicara secara jujur tentang kondisi emosional yang mereka alami. Dengan interaksi yang

positif, tenaga kesehatan dapat lebih mudah mengidentifikasi tanda-tanda awal gangguan mental, sekaligus memberikan dukungan psikologis secara konsisten dan komprehensif selama masa-masa krusial pasca persalinan.

Strategi pencegahan juga mencakup penguatan jaringan sosial dan komunitas yang mendukung. Ibu baru seringkali mengalami isolasi sosial yang dapat memperburuk kondisi mentalnya. Oleh karena itu, membangun komunitas pendukung atau kelompok ibu baru yang menyediakan tempat berbagi pengalaman, tantangan, serta strategi koping yang efektif dapat membantu mengurangi perasaan isolasi, sekaligus memperkuat rasa percaya diri ibu dalam menjalani peran barunya. Kelompok dukungan ini dapat berperan sebagai wadah untuk berbagi informasi mengenai gejala-gejala kesehatan mental, sehingga ibu dapat secara mandiri mengenali perubahan emosional yang mereka alami dan tidak segan mencari bantuan.

Lebih jauh lagi, perhatian terhadap kondisi fisik ibu setelah melahirkan juga tidak kalah pentingnya sebagai bagian dari strategi preventif. Kondisi fisik yang optimal, termasuk pemulihan luka persalinan, pengelolaan rasa sakit, serta nutrisi yang cukup, secara langsung berkontribusi terhadap kestabilan emosional ibu. Oleh sebab itu, tenaga kesehatan harus memastikan bahwa kebutuhan dasar fisik ibu terpenuhi, yang secara signifikan dapat mengurangi stres psikologis pasca persalinan.

I. Pendekatan dan Terapi untuk Mengatasi Tantangan Kesehatan Mental Pasca Persalinan

Mengatasi tantangan kesehatan mental pasca persalinan memerlukan pendekatan intervensi yang menyeluruh dan beragam, karena kondisi ini tidak hanya melibatkan aspek emosional atau psikologis, tetapi juga faktor sosial, keluarga, serta terkadang membutuhkan intervensi farmakologis. Intervensi yang tepat dan komprehensif sangat penting untuk membantu ibu melewati masa sulit ini, serta mengurangi dampak jangka panjang terhadap ibu, bayi, dan keluarga secara keseluruhan. Beberapa pendekatan intervensi yang terbukti efektif dalam mengelola gangguan kesehatan mental pasca persalinan antara lain konseling psikologis, terapi perilaku kognitif atau Cognitive Behavioral Therapy (CBT), mindfulness, dukungan keluarga dan komunitas, serta terapi farmakologis.

Salah satu pendekatan utama yang sangat direkomendasikan adalah konseling psikologis. Konseling ini memberikan ruang aman bagi ibu untuk mengungkapkan perasaan, pikiran, dan kekhawatiran yang dirasakan setelah persalinan. Dalam konseling psikologis, ibu didorong untuk mengenali, mengungkapkan, serta

mengeksplorasi perasaan dan pemikiran negatif yang mungkin memperburuk kondisi emosionalnya. Konselor atau psikolog berperan sebagai pendengar empatik yang dapat membantu ibu dalam mengidentifikasi akar permasalahan emosional, serta mendampingi dalam menemukan strategi koping yang efektif. Proses ini memungkinkan ibu untuk merasa didengar, dimengerti, dan tidak lagi merasa terisolasi dalam menghadapi tantangan psikologis yang dialami.

Selanjutnya, terapi perilaku kognitif atau Cognitive Behavioral Therapy (CBT) merupakan pendekatan psikoterapi yang telah banyak diteliti dan terbukti efektif dalam menangani gangguan seperti depresi, kecemasan, dan gangguan emosional pasca persalinan lainnya. CBT berfokus pada identifikasi pola pikir negatif yang tidak realistis, serta perilaku maladaptif yang berkontribusi pada kondisi mental yang dialami oleh ibu. Dalam proses terapi CBT, ibu diajarkan cara mengenali pola pikir negatif seperti perasaan tidak mampu merawat bayi, ketakutan berlebihan terhadap kegagalan menjadi ibu, serta pemikiran bahwa dirinya tidak berharga. Melalui proses terapeutik ini, ibu kemudian dibimbing untuk mengganti pola pikir negatif tersebut dengan pemikiran yang lebih realistis, positif, serta konstruktif. Selain itu, CBT juga melatih ibu dalam teknik pengelolaan stres, keterampilan menyelesaikan masalah, serta penguatan perilaku yang mendukung kesejahteraan mental dan emosionalnya. Dengan CBT, ibu tidak hanya dapat mengurangi gejala depresi dan kecemasan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri dalam menjalani perannya sebagai ibu baru.

Pendekatan mindfulness atau meditasi berbasis kesadaran juga menjadi salah satu intervensi yang sangat efektif dalam mengelola tantangan kesehatan mental pasca persalinan. Mindfulness merupakan latihan kesadaran yang melibatkan pengamatan secara penuh terhadap pengalaman emosional maupun fisik yang dialami, tanpa penilaian negatif atau usaha untuk menekan perasaan tersebut. Dalam konteks pasca persalinan, mindfulness mengajarkan ibu untuk menerima berbagai perubahan emosional dan fisik yang terjadi sebagai bagian dari proses alami, sehingga membantu mengurangi rasa takut, panik, atau kewalahan yang sering muncul akibat gejala seperti kecemasan atau depresi. Latihan mindfulness yang teratur terbukti efektif mengurangi stres, memperbaiki kualitas tidur, serta meningkatkan ketahanan emosional ibu dalam menghadapi tantangan kesehariannya. Dengan mindfulness, ibu dapat belajar untuk merespons situasi emosional yang sulit secara lebih tenang, terkendali, dan penuh penerimaan.

Selain pendekatan psikologis, dukungan keluarga dan komunitas memiliki peranan penting dalam proses pemulihan ibu dari gangguan mental pasca persalinan. Keluarga yang suportif dapat memberikan bantuan emosional, praktis, dan sosial yang sangat dibutuhkan ibu dalam masa adaptasi dengan peran barunya. Dukungan keluarga meliputi pemberian kasih sayang, empati, validasi terhadap perasaan ibu, serta bantuan praktis dalam merawat bayi dan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dengan adanya dukungan keluarga, ibu merasa tidak sendirian dalam menghadapi tantangan, yang secara signifikan membantu mengurangi tekanan psikologis serta mempercepat proses pemulihan emosionalnya. Di samping itu, keterlibatan dalam komunitas atau kelompok ibu baru yang saling mendukung juga memberikan manfaat besar. Kelompok ini menawarkan wadah bagi ibu untuk berbagi pengalaman, mendiskusikan perasaan, dan mendapatkan perspektif positif dari ibu-ibu lain yang mengalami situasi serupa. Interaksi sosial ini sangat penting dalam mengurangi perasaan isolasi, meningkatkan rasa percaya diri, serta membangun rasa solidaritas antar ibu.

Dalam beberapa situasi, pendekatan farmakologis atau penggunaan obat-obatan juga diperlukan sebagai bagian dari strategi penanganan yang komprehensif. Terapi farmakologis biasanya dipertimbangkan apabila gangguan mental pasca persalinan, seperti depresi berat atau gangguan kecemasan yang parah, tidak cukup merespons terhadap pendekatan non-farmakologis atau psikologis saja. Penggunaan obat-obatan seperti antidepresan atau antiansietas mungkin diperlukan dengan pengawasan ketat dari tenaga kesehatan, terutama dokter spesialis psikiatri. Dalam penerapan terapi farmakologis, perlu diperhatikan dengan seksama kondisi ibu yang sedang menyusui agar pemilihan obat aman untuk ibu dan bayi. Dosis obat biasanya dimulai dari dosis minimal efektif, kemudian disesuaikan berdasarkan respons klinis serta kondisi individual ibu.

Pendekatan farmakologis sebaiknya tidak berdiri sendiri, tetapi dikombinasikan dengan intervensi psikologis, dukungan keluarga, serta strategi koping mandiri seperti olahraga ringan, istirahat yang cukup, serta nutrisi yang baik. Pendekatan terpadu ini memungkinkan ibu mendapatkan manfaat maksimal, sehingga proses pemulihan kondisi mentalnya berjalan optimal dengan risiko efek samping minimal.

J. Peran Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Kesehatan Mental Pasca Persalinan

Tenaga kesehatan memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam mendukung ibu menghadapi tantangan kesehatan mental pasca persalinan. Masa setelah melahirkan merupakan periode sensitif, yang tak hanya melibatkan perubahan fisik tetapi juga menuntut adaptasi psikologis dan emosional yang signifikan. Oleh karena itu, dukungan dari berbagai tenaga kesehatan seperti dokter, bidan, perawat, psikolog, dan pekerja sosial sangat dibutuhkan secara terpadu dan terintegrasi. Mereka tidak hanya membantu ibu dari sisi medis, tetapi juga memberikan pendampingan psikologis, edukasi, serta dukungan sosial yang diperlukan agar ibu dapat melalui masa pasca persalinan dengan optimal.

Dokter, khususnya dokter spesialis kandungan dan kebidanan (SpOG), memainkan peran sentral dalam mengidentifikasi secara dini risiko serta gejala gangguan mental pasca persalinan. Dokter bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi fisik maupun psikologis ibu. Evaluasi ini biasanya mencakup wawancara mendalam, pemeriksaan fisik, serta menggunakan berbagai alat skrining yang valid untuk mendeteksi kondisi seperti baby blues, depresi postpartum, kecemasan, hingga psikosis postpartum. Dokter juga bertanggung jawab dalam menentukan intervensi medis yang tepat, termasuk merujuk ibu kepada spesialis kesehatan mental bila diperlukan. Di samping itu, dokter juga memberikan edukasi tentang pentingnya kesehatan mental, tanda-tanda peringatan yang perlu diperhatikan, serta langkah-langkah yang harus diambil jika ibu merasakan gejala-gejala tertentu. Dengan pendekatan yang sensitif, empatik, serta komunikasi yang efektif, dokter dapat membangun rasa percaya ibu sehingga ibu merasa nyaman dan terbuka untuk berdiskusi mengenai perasaan serta kekhawatirannya.

Bidan memiliki peranan penting dalam memberikan pendampingan yang bersifat kontinu selama periode pasca persalinan, terutama dalam layanan kesehatan primer atau komunitas. Peran bidan tidak terbatas pada pemeriksaan fisik ibu dan bayi saja, tetapi juga mencakup edukasi kesehatan mental, konseling sederhana, serta skrining rutin untuk mendeteksi dini berbagai gangguan emosional yang mungkin muncul pasca persalinan. Dengan pendekatan yang humanis, empati, dan penuh perhatian, bidan dapat menciptakan hubungan yang hangat dengan ibu, sehingga ibu merasa didukung secara emosional. Bidan juga berperan sebagai penghubung antara ibu dengan layanan kesehatan lainnya, seperti psikolog atau konselor kesehatan mental, jika ditemukan indikasi perlunya intervensi psikologis lebih lanjut. Pendampingan emosional yang diberikan oleh bidan juga sangat

membantu dalam mengurangi kecemasan ibu, meningkatkan rasa percaya diri, serta memperkuat ikatan emosional antara ibu dan bayinya.

Perawat berperan vital dalam perawatan sehari-hari dan monitoring rutin terhadap kondisi ibu selama masa pasca persalinan. Dalam konteks dukungan kesehatan mental, perawat terlibat langsung dalam mengamati perubahan suasana hati, tanda-tanda kecemasan, depresi, atau gangguan mental lainnya secara intensif. Dengan melakukan pemantauan rutin, perawat dapat secara cepat mengidentifikasi gejala awal yang mungkin tidak disadari oleh ibu maupun keluarga. Perawat juga memberikan edukasi praktis kepada ibu dan keluarganya mengenai perawatan bayi, teknik relaksasi, pentingnya istirahat yang cukup, serta dukungan praktis lainnya yang dapat mengurangi stres dan kelelahan ibu. Melalui interaksi sehari-hari yang penuh perhatian dan empati, perawat dapat memberikan dukungan emosional secara langsung, yang sangat penting dalam membantu ibu melewati masa transisi yang penuh tantangan ini.

Psikolog memiliki peran khusus yang sangat penting dalam mendukung kesehatan mental ibu setelah persalinan. Psikolog terlibat secara aktif dalam memberikan intervensi psikologis seperti konseling individu maupun kelompok, terapi kognitif perilaku (CBT), serta pendekatan mindfulness yang terbukti efektif dalam mengatasi berbagai gangguan mental pasca persalinan seperti depresi atau kecemasan. Melalui sesi terapi, psikolog membantu ibu untuk memahami perasaan, mengidentifikasi pola pikir negatif, dan mengembangkan strategi koping yang adaptif serta positif. Psikolog juga berperan dalam mendidik keluarga tentang cara memberikan dukungan yang tepat kepada ibu, sehingga lingkungan keluarga menjadi lebih suportif, kondusif, dan mampu mempercepat proses pemulihan emosional ibu. Dalam kondisi tertentu, psikolog juga bertugas memberikan rekomendasi kepada dokter mengenai kebutuhan intervensi farmakologis, serta memantau perkembangan psikologis ibu selama proses terapi berlangsung.

Pekerja sosial juga merupakan bagian integral dari tim tenaga kesehatan yang mendukung kesehatan mental ibu pasca persalinan, terutama dalam hal dukungan sosial, ekonomi, dan lingkungan keluarga. Pekerja sosial bertugas melakukan asesmen mendalam mengenai kondisi sosial-ekonomi ibu, jaringan dukungan sosial, serta dinamika keluarga yang mungkin mempengaruhi kesehatan mental ibu. Mereka membantu ibu dan keluarganya untuk mengakses berbagai sumber daya yang tersedia, seperti bantuan finansial, program dukungan komunitas, atau layanan konseling sosial yang diperlukan. Selain itu, pekerja sosial juga dapat membantu

mediasi dalam konflik keluarga, memperkuat komunikasi antar anggota keluarga, serta mengadvokasi kebutuhan ibu dalam memperoleh dukungan yang layak dari lingkungan sekitarnya. Dukungan ini sangat krusial, terutama bagi ibu yang tinggal dalam kondisi sosial ekonomi yang sulit atau menghadapi konflik keluarga yang signifikan, karena kondisi ini berkontribusi besar terhadap munculnya gangguan mental pasca persalinan.

Kolaborasi antar berbagai tenaga kesehatan—dokter, bidan, perawat, psikolog, dan pekerja sosial—merupakan pendekatan terbaik untuk memberikan dukungan holistik yang diperlukan ibu selama periode pasca persalinan. Melalui kerja sama interprofesional yang terintegrasi ini, ibu mendapatkan dukungan dari berbagai sisi secara simultan: medis, emosional, psikologis, sosial, dan bahkan ekonomi. Pendekatan ini memastikan bahwa ibu tidak hanya mampu pulih secara fisik tetapi juga mampu menjaga keseimbangan mental dan emosional yang optimal, sehingga kualitas hidup ibu dan keluarga meningkat secara signifikan. Dengan dukungan yang holistik dari tenaga kesehatan ini, ibu memiliki peluang terbaik untuk menjalani masa pasca persalinan yang sehat, bahagia, dan penuh makna.

K. Simpulan

Tantangan kesehatan mental pasca persalinan merupakan aspek penting yang memerlukan perhatian serius dan intervensi yang terintegrasi, karena berdampak langsung terhadap kualitas hidup ibu, tumbuh kembang bayi, serta keharmonisan keluarga secara keseluruhan. Masa pasca persalinan tidak hanya ditandai oleh pemulihan fisik setelah melahirkan, tetapi juga oleh perubahan psikologis dan emosional yang kompleks, yang jika tidak dikelola dengan baik dapat berkembang menjadi kondisi serius seperti baby blues, depresi postpartum, gangguan kecemasan, bahkan psikosis postpartum yang mengancam keselamatan ibu maupun bayi.

Berbagai faktor risiko, seperti riwayat gangguan mental sebelumnya, kurangnya dukungan sosial dan emosional, tekanan ekonomi, serta konflik dalam hubungan keluarga, terbukti meningkatkan kerentanan ibu terhadap gangguan mental pasca persalinan. Oleh karena itu, strategi pencegahan yang mencakup skrining rutin sejak masa kehamilan hingga periode setelah melahirkan, edukasi bagi keluarga dan tenaga kesehatan, serta peningkatan kesadaran masyarakat sangat diperlukan untuk mendeteksi secara dini gejala-gejala gangguan mental sehingga intervensi cepat dapat dilakukan.

Pendekatan yang efektif dalam mengatasi tantangan kesehatan mental ini harus bersifat holistik dan komprehensif, melibatkan intervensi psikologis seperti konseling, terapi perilaku kognitif (CBT), pendekatan mindfulness, serta dukungan sosial dan keluarga yang kuat. Dalam beberapa kasus, pendekatan farmakologis juga diperlukan sebagai pelengkap untuk mengatasi kondisi yang lebih berat.

Peran tenaga kesehatan, baik dokter spesialis kebidanan, bidan, perawat, psikolog, maupun pekerja sosial, sangat krusial dalam memberikan pendampingan terpadu. Kolaborasi interprofesional di antara tenaga kesehatan ini memastikan bahwa ibu mendapatkan dukungan yang optimal secara medis, psikologis, emosional, dan sosial selama masa transisi yang rentan tersebut. Dukungan yang terintegrasi dan kontinu ini memungkinkan ibu pulih secara menyeluruh, menjaga keseimbangan emosionalnya, memperkuat hubungan emosional dengan bayi, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

Dengan pendekatan yang proaktif, komprehensif, dan kolaboratif dalam mengelola tantangan kesehatan mental pasca persalinan, diharapkan setiap ibu mampu melewati masa kritis ini dengan baik, sehingga tercipta keluarga yang harmonis, bayi yang tumbuh sehat, serta masyarakat yang lebih peka dan responsif terhadap pentingnya kesehatan mental ibu.

L. Referensi

- American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed.). Washington, DC: American Psychiatric Publishing.
- Dennis, C. L., Falah-Hassani, K., & Shiri, R. (2017). Prevalence of antenatal and postnatal anxiety: systematic review and meta-analysis. *The British Journal of Psychiatry*, 210(5), 315–323.
- Fisher, J., Mello, M. C. de, Patel, V., Rahman, A., Tran, T., Holton, S., & Holmes, W. (2012). Prevalence and determinants of common perinatal mental disorders in women in low- and lower-middle-income countries: a systematic review. *Bulletin of the World Health Organization*, 90(2), 139G–149G.
- Howard, L. M., Molyneaux, E., Dennis, C.-L., Rochat, T., Stein, A., & Milgrom, J. (2014). Non-psychotic mental disorders in the perinatal period. *The Lancet*, 384(9956), 1775–1788.

- Leigh, B., & Milgrom, J. (2008). Risk factors for antenatal depression, postnatal depression, and parenting stress. *BMC Psychiatry*, 8(1), 24–35.
- O'Hara, M. W., & McCabe, J. E. (2013). Postpartum depression: current status and future directions. *Annual Review of Clinical Psychology*, 9(1), 379–407.
- Ross, L. E., & McLean, L. M. (2006). Anxiety disorders during pregnancy and the postpartum period: a systematic review. *Journal of Clinical Psychiatry*, 67(8), 1285–1298.
- Stewart, D. E., & Vigod, S. N. (2016). Psychosis after childbirth: the postpartum psychosis. *The American Journal of Psychiatry*, 173(2), 109–117.
- Wisner, K. L., Sit, D. K., McShea, M. C., Rizzo, D. M., Zoretich, R. A., Hughes, C. L., Eng, H. F., Luther, J. F., Wisniewski, S. R., Costantino, M. L., Confer, A. L., Moses-Kolko, E. L., Famy, C. S., & Hanusa, B. H. (2013). Onset timing, thoughts of self-harm, and diagnoses in postpartum women with screen-positive depression findings. *JAMA Psychiatry*, 70(5), 490–498.
- World Health Organization. (2018). WHO recommendations on maternal mental health. Geneva: World Health Organization.
- Yonkers, K. A., Vigod, S., & Ross, L. E. (2011). Diagnosis, pathophysiology, and management of mood disorders in pregnant and postpartum women. *Obstetrics & Gynecology*, 117(4), 961–977.

M. Glosarium

1. **Baby Blues**

Kondisi psikologis ringan yang umum dialami oleh ibu baru, biasanya muncul pada minggu pertama setelah persalinan, ditandai dengan perasaan sedih, cemas, gelisah, mudah menangis, dan perubahan suasana hati yang cepat. Umumnya berlangsung singkat (kurang dari dua minggu).

2. **Depresi Pasca Persalinan (Postpartum Depression)**

Gangguan suasana hati serius yang muncul setelah melahirkan, ditandai dengan kesedihan mendalam, hilangnya minat terhadap aktivitas sehari-hari, perasaan bersalah yang berlebihan, kelelahan ekstrem, serta gangguan dalam merawat diri maupun bayi, yang bisa bertahan berminggu-minggu hingga berbulan-bulan.

3. **Gangguan Kecemasan Pasca Persalinan (Postpartum Anxiety)**

Kondisi psikologis pasca persalinan yang ditandai dengan kecemasan berlebihan, rasa takut yang sulit dikendalikan, pikiran negatif terus-menerus tentang keselamatan bayi, serta gejala fisik seperti jantung berdebar, sulit tidur, dan serangan panik yang mengganggu aktivitas sehari-hari.

4. **Psikosis Pasca Persalinan (Postpartum Psychosis)**

Gangguan mental berat yang jarang terjadi tetapi serius, ditandai dengan hilangnya kontak dengan realitas, munculnya halusinasi, delusi, perubahan suasana hati yang ekstrem, perilaku tidak biasa, dan memerlukan penanganan medis segera karena berpotensi membahayakan ibu dan bayi.

5. **Bonding**

Ikatan emosional antara ibu dan bayi yang terbentuk sejak awal kehidupan bayi, yang melibatkan respons kasih sayang, interaksi emosional positif, dan memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan sosial dan emosional bayi.

6. **Skrining Kesehatan Mental**

Proses pemeriksaan rutin menggunakan alat-alat tertentu, seperti Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS), yang bertujuan mengidentifikasi secara dini gejala gangguan mental pasca persalinan agar intervensi tepat waktu dapat diberikan.

7. **Cognitive Behavioral Therapy (CBT)**

Jenis terapi psikologis yang berfokus pada pengenalan dan perubahan pola pikir negatif serta perilaku maladaptif, yang terbukti efektif dalam menangani gangguan kecemasan, depresi, serta masalah kesehatan mental pasca persalinan.

8. **Mindfulness**

Pendekatan terapeutik berupa latihan meditasi yang mengajarkan ibu untuk menyadari dan menerima pengalaman emosional maupun fisik secara penuh, tanpa penilaian negatif, untuk mengurangi stres dan meningkatkan kestabilan emosional setelah melahirkan.

9. Dukungan Sosial

Bantuan emosional, praktis, dan psikologis yang diberikan oleh pasangan, keluarga, teman, atau komunitas, yang sangat penting untuk mengurangi tekanan mental serta mempercepat proses pemulihan kesehatan mental ibu pasca persalinan.

10. Intervensi Farmakologis

Penggunaan obat-obatan seperti antidepresan atau antiansietas di bawah pengawasan tenaga medis untuk mengatasi gangguan mental pasca persalinan yang parah atau tidak cukup merespons intervensi psikologis saja.

CHAPTER 3

KESEHATAN MENTAL PEREMPUAN DEWASA

Deny Eka Widyastuti, SST., M.Kes., M.Keb.

A. Pendahuluan/Prolog

Kesehatan mental perempuan dewasa adalah fondasi yang menopang kualitas hidup individu, keluarga, dan masyarakat. Pada fase dewasa, perempuan menjalankan peran yang sering tumpang tindih, pekerja, pasangan, pengasuh, anggota komunitas, yang masing-masing membawa tuntutan emosional, kognitif, dan sosial. Di saat yang sama, tubuh perempuan mengalami dinamika biologis yang khas sepanjang siklus kehidupan reproduksi, mulai dari fluktuasi hormon siklik, kehamilan dan masa nifas, hingga perimenopause dan menopause. Interaksi antara tuntutan sosial dan dinamika biologis ini menjadikan kesehatan mental bukan sekadar isu personal, melainkan persoalan kesehatan publik yang membutuhkan perhatian lintas disiplin.

Latar belakang kesehatan mental pada perempuan dewasa tidak bisa dilepaskan dari determinan biologis, psikologis, dan sosial yang saling berkelindan. Dari sisi biologis, perubahan kadar estrogen dan progesteron memengaruhi neurotransmitter seperti serotonin, dopamin, dan GABA, yang berperan pada regulasi suasana hati, tidur, nafsu makan, dan respons stres. Fase pra-menstruasi, masa perinatal, dan transisi menopause merupakan "jendela kerentanan" ketika gejala mood dan kecemasan dapat menguat. Dari sisi psikologis, pengalaman masa kanak-kanak, pola kelekatan, gaya coping, dan resiliensi memengaruhi kerentanan maupun proteksi terhadap gangguan mental. Sementara itu, determinan sosial, seperti beban kerja domestik yang tidak dibayar, ketidaksetaraan kesempatan karier, kekerasan berbasis gender, stigma, dan akses layanan, menciptakan konteks yang dapat memperparah atau meringankan gejala.

Dalam lintasan kehidupan, signifikansi isu kesehatan mental perempuan tampak pada dampaknya yang luas terhadap kesejahteraan reproduksi, pengasuhan, produktivitas, serta partisipasi sosial. Perempuan sering menjadi pengasuh utama dalam keluarga; ketika depresi, kecemasan, atau stres kronis tidak tertangani, kualitas relasi, sensitivitas pengasuhan, dan stabilitas rumah tangga ikut terdampak. Pada periode perinatal, misalnya, depresi dapat mengganggu ikatan ibu anak, menyulitkan pemberian ASI, dan menurunkan kepatuhan terhadap perawatan kesehatan. Di tempat kerja, gejala seperti sulit konsentrasi, kelelahan, dan gangguan

tidur bisa menurunkan performa dan peluang kemajuan karier. Secara makro, akumulasi dampak ini berkontribusi pada beban penyakit nasional, biaya ekonomi, dan disparitas kesehatan antar kelompok sosial.

Isu ini juga penting karena kesehatan mental perempuan dewasa memiliki karakter intergenerasional. Kondisi mental ibu selama kehamilan dan setelah melahirkan berkaitan dengan pertumbuhan, perkembangan kognitif, serta regulasi emosi anak. Stres psikososial kronis, kekurangan dukungan, dan malnutrisi dapat memperburuk hasil kehamilan dan kesehatan anak, membentuk siklus kerentanan yang berlanjut hingga remaja. Dengan demikian, intervensi yang menjaga kesehatan mental perempuan dewasa bukan hanya memulihkan individu, tetapi juga memutus mata rantai kerugian antargenerasi.

Di Indonesia, konteks budaya, nilai keluarga, dan jaringan sosial memiliki peran ambivalen: dapat menjadi sumber daya pemulihan, tetapi juga menjadi sumber tekanan. Norma gender yang membatasi pengambilan keputusan, stigma terhadap konsultasi psikologis, serta kesenjangan layanan di daerah terpencil memperkuat hambatan akses. Di sisi lain, komunitas yang kuat, kelompok keagamaan, dan kader kesehatan menawarkan kanal dukungan yang strategis bila diberdayakan. Kebijakan publik yang semakin menempatkan kesehatan jiwa dalam agenda prioritas membuka peluang integrasi layanan, namun implementasi lapangan masih menghadapi tantangan sumber daya, literasi kesehatan, dan kesinambungan program.

Bertolak dari latar tersebut, tujuan bab pengantar ini adalah meletakkan kerangka konseptual yang jelas mengenai kesehatan mental perempuan dewasa, dengan menautkan aspek biologis, psikologis, dan sosial ke dalam satu peta pemahaman yang koheren. Bab ini berupaya menjelaskan mengapa perempuan pada fase dewasa memiliki periode kerentanan tertentu, bagaimana tuntutan peran memodulasi gejala, dan sejauh mana dukungan sosial serta layanan kesehatan mampu menjadi faktor protektif. Dengan kerangka itu, pembaca diharapkan memiliki pijakan untuk menilai risiko, mengenali tanda awal, dan memahami rasional intervensi berbasis bukti.

Ruang lingkup pembahasan mencakup spektrum penuh dari promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif. Di ranah promotif, fokus diarahkan pada peningkatan literasi kesehatan mental, penguatan resiliensi, strategi manajemen stres, dan pengurangan stigma. Pada aspek preventif, penekanan diberikan pada deteksi dini di layanan primer, skrining pada periode rentan, pra-menstruasi, perinatal, perimenopause, serta penanganan faktor risiko seperti kekerasan berbasis gender, konflik rumah tangga, dan kelelahan kerja. Ranah kuratif mencakup pendekatan psikoterapi, farmakoterapi yang sensitif terhadap fase reproduksi, dan

kolaborasi interprofesional. Sementara itu, ranah rehabilitatif menekankan pemulihan fungsi sosial, reintegrasi kerja, dan dukungan berkelanjutan bagi perempuan dengan kondisi kronis atau berulang.

Pendekatan yang dipilih bersifat holistik integratif. Artinya, pembahasan tidak memisahkan tubuh dan pikiran, melainkan memandang kesehatan mental sebagai hasil interaksi sistem saraf, endokrin, imun, mikrobiota, psikologi, dan lingkungan sosial. Bab-bab selanjutnya akan menurunkan kerangka ini menjadi strategi praktis yang kontekstual: bagaimana skrining dan konseling dilakukan di layanan kebidanan dan keperawatan, bagaimana jejaring komunitas dimobilisasi, dan bagaimana kebijakan institusional dapat mengikis hambatan akses. Penekanan khusus juga diberikan pada sensitivitas budaya dan keberpihakan pada perempuan yang menghadapi multipel kerentanan, seperti kemiskinan, disabilitas, atau tinggal di wilayah dengan fasilitas terbatas.

Dengan menyajikan pendahuluan yang komprehensif, naskah ini menyiapkan pembaca, mahasiswa, dosen, praktisi, dan pembuat kebijakan, untuk memasuki diskusi yang lebih spesifik pada bab-bab berikutnya. Harapannya, pemahaman konseptual yang kuat akan mendorong praktik yang lebih berbelas rasa, berbasis bukti, dan efektif, sehingga kesehatan mental perempuan dewasa tidak lagi berada di pinggir wacana, melainkan menjadi prioritas dalam ekosistem layanan kesehatan dan kebijakan sosial.

B. Konsep Dasar Kesehatan Mental pada Perempuan Dewasa

Kesehatan mental pada perempuan dewasa dapat dipahami secara utuh ketika didekati dari definisi yang berwibawa sekaligus peka konteks. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, kesehatan mental bukan sekadar ketiadaan gangguan, melainkan keadaan sejahtera ketika seseorang menyadari potensinya, mampu mengelola stres kehidupan yang wajar, bekerja secara produktif, serta berkontribusi pada komunitasnya. Definisi ini menempatkan kesehatan mental sebagai kapasitas fungsional dan relasional yang hidup dalam keseharian, bukan label klinis yang statis. Dalam perspektif lokal Indonesia yang berakar pada nilai kekeluargaan, gotong royong, dan spiritualitas, kesehatan mental juga dimaknai sebagai harmoni antara pikiran, perasaan, dan laku dalam relasi dengan Tuhan, sesama, dan alam. Artinya, seorang perempuan yang sehat mental bukan hanya bebas dari gejala depresi atau cemas, tetapi juga merasa bermakna dalam perannya, diterima komunitasnya, dan memiliki arah hidup yang selaras dengan nilai-nilai yang ia anut. Ketika definisi global dan lokal ini dipertemukan, kita memperoleh pemahaman yang lebih kaya: kesehatan mental perempuan dewasa adalah kapasitas untuk

berdaya di tengah dinamika peran dan perubahan biologis, sekaligus kemampuan untuk merawat hubungan dan makna hidup sesuai budaya setempat.

Pengaruh terhadap kesehatan mental perempuan dewasa lahir dari pertemuan faktor biologis, psikologis, dan sosial yang bekerja secara bersamaan. Dari sisi biologis, tubuh perempuan mengalami fluktuasi hormon estrogen dan progesteron yang memodulasi sistem neurotransmiter seperti serotonin, dopamin, dan GABA. Perubahan ini membantu menjelaskan mengapa periode pra-menstruasi, kehamilan, masa nifas, dan perimenopause sering menjadi jendela kerentanan emosional. Selain hormon, kondisi medis tertentu, status gizi, kualitas tidur, penyakit kronis, dan nyeri berulang turut memengaruhi stabilitas suasana hati dan kecemasan. Dari sisi psikologis, pengalaman masa kecil, pola kelekatan, kepercayaan diri, gaya berpikir, serta strategi koping menentukan bagaimana perempuan memaknai dan merespons tekanan. Resiliensi dapat tumbuh dari dukungan emosional yang hangat dan pengalaman keberhasilan, sementara perfeksionisme kaku atau keyakinan negatif tentang diri sendiri dapat memperpanjang distress. Sisi sosial menambahkan lapisan kompleks: norma gender, beban kerja domestik yang tidak dibayar, peran ganda sebagai pekerja dan pengasuh, paparan kekerasan berbasis gender, ketidaksetaraan ekonomi, serta akses layanan kesehatan yang tidak merata. Kekuatan jejaring sosial (keluarga, teman, komunitas, kelompok keagamaan) dapat menjadi penyangga yang besar, namun stigma terhadap berbagai masalah kepada profesional atau tabu membicarakan masalah rumah tangga kerap menghambat pencarian pertolongan. Ketika ketiga ranah ini saling memperkuat secara positif, perempuan cenderung memiliki kesejahteraan mental yang terjaga; sebaliknya, ketika biologis rentan, psikologis kewalahan, dan sosial menekan, risiko gangguan meningkat tajam.

Perbedaan gender dalam kerentanan gangguan mental tampak konsisten di berbagai kajian. Secara epidemiologis, perempuan lebih sering mengalami depresi mayor dan gangguan kecemasan, sedangkan laki-laki relatif lebih tinggi pada perilaku adiktif dan beberapa bentuk gangguan kepribadian antisosial. Pada perempuan, kerentanan ini beririsan dengan faktor biologis seperti fluktuasi hormon dan proses reproduksi, tetapi tidak berhenti di sana. Pola sosialisasi yang mendorong empati tinggi dan orientasi relasional membawa kekuatan dalam membangun dukungan sosial, namun dapat pula meningkatkan beban emosional ketika mengutamakan kebutuhan orang lain sambil mengabaikan diri sendiri. Norma budaya yang menilai perempuan sebagai penjaga harmoni dapat menciptakan tekanan untuk selalu tampak kuat dan baik-baik saja, sehingga gejala tersamar di balik kesibukan dan keramahan. Perbedaan akses dan pengalaman di tempat kerja (mulai dari kesenjangan upah, glass ceiling, hingga pelecehan)

menambah risiko stres kronis. Dalam rumah tangga, ketimpangan pembagian kerja domestik dan pengasuhan dapat menumpuk kelelahan mental, terlebih ketika dukungan pasangan dan keluarga besar minim. Singkatnya, gender tidak menentukan takdir, tetapi menjadi lensa yang memperbesar atau mengecilkan paparan risiko dan peluang proteksi.

Memahami konsep dasar ini membawa implikasi praktis yang luas. Layanan kesehatan perlu mengintegrasikan skrining sensitif gender pada periode rentan reproduksi dan saat perubahan peran keluarga atau kerja terjadi. Edukasi kesehatan mental sebaiknya menggabungkan sains tentang hormon dan otak dengan kearifan lokal tentang relasi, makna, dan spiritualitas, sehingga pesan menjadi relevan dan dapat diterima. Intervensi yang efektif bukan hanya terapi individu, melainkan juga upaya memperkuat dukungan sosial, mengurangi stigma, dan mendorong kebijakan yang lebih adil di tempat kerja serta layanan publik. Pada tingkat individu, perempuan diuntungkan ketika mendapatkan ruang aman untuk menamai emosi, membangun koping yang fleksibel, dan mengakses bantuan profesional tanpa rasa bersalah. Pada tingkat komunitas dan kebijakan, masyarakat diuntungkan ketika ekosistem mendukung keseimbangan peran, mencegah kekerasan berbasis gender, dan memastikan layanan kesehatan jiwa yang terjangkau, berkesinambungan, dan ramah budaya. Dengan kerangka ini, kesehatan mental perempuan dewasa dipahami bukan sebagai masalah pribadi yang terpisah, melainkan sebagai agenda sosial yang memerlukan jawaban ilmiah, empatik, dan sistemik.

C. Faktor Risiko dan Determinan Kesehatan Mental

Kesehatan mental perempuan dewasa dibentuk oleh jaringan faktor yang saling berinteraksi, mulai dari biologi reproduksi hingga struktur sosial yang mengatur peran dan kesempatan. Memahami determinan ini menolong kita melihat bahwa gejala psikologis bukanlah kelemahan personal, melainkan luaran dari proses yang kompleks, berlapis, dan sering kali dapat dimodifikasi melalui intervensi klinis dan kebijakan.

Perubahan hormonal sepanjang siklus reproduksi memberi kontribusi besar pada kerentanan emosional. Fluktuasi estrogen dan progesteron pada fase pra-menstruasi dapat memengaruhi sistem neurotransmiter seperti serotonin, dopamin, dan GABA, sehingga sebagian perempuan mengalami iritabilitas, kecemasan, gangguan tidur, atau penurunan energi menjelang haid. Pada sebagian kecil, gejala ini mencapai tingkat yang mengganggu fungsi harian, misalnya pada gangguan disforik pra-menstruasi. Kehamilan menghadirkan dinamika yang berbeda, di mana lonjakan hormon, perubahan tubuh, harapan sosial, serta antisipasi peran pengasuhan berkelindan dengan faktor medis seperti anemia, hipotiroid, dan

hiperemesis. Masa nifas adalah periode risiko tinggi untuk depresi dan kecemasan, terutama bila diwarnai komplikasi obstetri, nyeri, kurang tidur, beban pengasuhan, serta keterbatasan dukungan pasangan atau keluarga. Memasuki perimenopause dan menopause, penurunan bertahap estrogen berkaitan dengan gejala vasomotor, gangguan tidur, kabut kognitif, dan perubahan suasana hati. Kondisi klinis seperti sindrom ovarium polikistik, endometriosis, atau nyeri panggul kronis juga dapat meningkatkan risiko depresi dan kecemasan melalui mekanisme nyeri berulang, peradangan, serta dampak pada kesuburan dan citra tubuh. Bahkan intervensi medis, termasuk kontrasepsi hormonal atau terapi fertilitas, dapat memodulasi mood pada sebagian perempuan, sehingga penilaian individual dan komunikasi yang sensitif menjadi kunci.

Di luar biologi, tuntutan peran ganda memegang peranan sentral. Banyak perempuan menanggung pekerjaan formal sekaligus kerja domestik yang tidak dibayar, seperti pengasuhan anak, perawatan lansia, dan tugas rumah tangga. Ketika ekspektasi profesional yang tinggi bertemu dengan standar sosial untuk menjadi pengasuh ideal, muncullah konflik kerja-keluarga yang memicu kelelahan emosi, rasa bersalah, dan penurunan kepuasan diri. Kondisi kerja yang tidak fleksibel, lembur berkepanjangan, atau kerja shift yang mengganggu ritme sirkadian akan memperburuk gangguan tidur dan reaktivitas stres. Di ranah sosial, tekanan untuk tampil selalu kuat dan rapi, serta budaya yang menilai pengorbanan sebagai ukuran keberhasilan perempuan, dapat membuat kebutuhan pribadi terabaikan. Beban mental, yaitu tugas tak terlihat untuk merencanakan, mengingat, dan mengoordinasikan urusan rumah tangga, sering melekat pada perempuan dan jarang diakui. Pada era digital, arus informasi yang tak berhenti, pesan kerja di luar jam kantor, dan perbandingan di media sosial menambah lapisan stres yang subtil namun persisten. Semua ini bukan sekadar cerita tentang manajemen waktu, melainkan tentang arsitektur sosial yang belum seimbang membagi tanggung jawab dan kuasa pengambilan keputusan.

Kekerasan berbasis gender, diskriminasi, dan stigma sosial merupakan determinan yang sangat kuat dan sering tersembunyi. Kekerasan dalam pacaran, kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual di tempat kerja, kontrol ekonomi oleh pasangan, atau perundungan berbasis gender meninggalkan jejak psikologis berupa kecemasan, depresi, gangguan stres pascatrauma, serta rasa malu dan menyalahkan diri sendiri. Ketika sistem sosial meremehkan laporan kekerasan atau menyalahkan korban, trauma menjadi berlapis. Diskriminasi gender di lingkungan kerja, seperti kesenjangan upah, peluang promosi yang lebih sempit, dan komentar merendahkan, menambah paparan stres kronis. Stigma terhadap kesehatan mental sendiri menahan perempuan untuk mencari bantuan, apalagi bila ia khawatir dicap

lemah, tidak profesional, atau tidak mampu mengasuh anak. Stigma ganda dapat terjadi pada perempuan dari kelompok rentan, misalnya penyandang disabilitas, kelompok minoritas, atau yang hidup dalam kemiskinan, sehingga hambatan akses layanan menjadi berlipat. Menghadapi determinan ini, intervensi tidak cukup berhenti pada terapi individual; diperlukan perubahan norma, mekanisme pelaporan yang aman, dan penegakan hukum yang tegas agar lingkungan menjadi lebih protektif.

Faktor genetik, riwayat keluarga, dan lingkungan turut menyiapkan panggung kerentanan atau ketahanan. Riwayat keluarga dengan depresi, gangguan bipolar, kecemasan, atau penyalahgunaan zat menunjukkan adanya komponen hereditas yang meningkatkan peluang munculnya gejala pada keturunan. Namun genetika bekerja bersama lingkungan, bukan menentukan nasib secara tunggal. Paparan stres masa kanak-kanak, kekerasan, penelantaran, atau kehilangan orang tua dapat meninggalkan bekas epigenetik yang memengaruhi respons stres di kemudian hari. Pada masa dewasa, lingkungan yang miskin dukungan, padat konflik, atau tidak aman akan mempertajam respons ancaman, sementara lingkungan yang suportif dapat memperkuat resiliensi. Determinan sosial lain seperti kemiskinan, ketidakamanan pangan, hunian yang tidak layak, polusi, dan bencana alam berpengaruh melalui jalur stres kronis, peradangan, dan hambatan akses layanan. Status gizi, kualitas tidur, aktivitas fisik, dan paparan zat pengganggu endokrin dari lingkungan juga ikut membentuk kestabilan mood. Hubungan usus otak melalui mikrobiota semakin diakui perannya, sehingga pola makan yang beragam dan kaya serat memberi manfaat tidak hanya untuk fisik, tetapi juga kestabilan emosi. Dengan kata lain, keturunan memberi kerangka, sementara pengalaman hidup, relasi, dan kebiasaan sehari-hari mengisi detail lukisan kesehatan mental.

D. Gangguan Kesehatan Mental yang Umum pada Perempuan Dewasa

Pada perempuan dewasa, gangguan kesehatan mental muncul dari pertemuan antara dinamika biologis reproduksi, pengalaman psikologis, dan konteks sosial budaya. Gambaran klinis sering tumpang tindih sehingga satu individu dapat menunjukkan gejala dari beberapa spektrum sekaligus. Pemahaman yang peka terhadap fase kehidupan, peran sosial, serta riwayat kekerasan atau trauma sangat penting agar penilaian dan penanganan tidak sekadar berfokus pada gejala, melainkan menyoroti akar masalah dan faktor pemelihara.

Depresi pada perempuan dewasa ditandai suasana hati murung yang menetap, hilangnya minat dan kegembiraan, kelelahan, gangguan tidur atau nafsu makan, perasaan bersalah dan tidak berharga, penurunan konsentrasi, hingga munculnya pikiran tentang kematian. Pada sebagian perempuan, depresi berkaitan

dengan fase reproduksi seperti pra-menstruasi, kehamilan, masa nifas, atau perimenopause. Depresi pascapersalinan merupakan bentuk yang sangat relevan, ditandai perasaan sedih yang mendalam, cemas berlebihan terhadap bayi, sulit tidur meski ada kesempatan, dan kadang muncul pikiran menyakiti diri atau bayinya. Kondisi ini perlu dibedakan dari baby blues yang bersifat sementara dan ringan. Faktor risikonya meliputi riwayat depresi, kurangnya dukungan pasangan, persalinan traumatis, masalah laktasi, dan stres ekonomi. Penatalaksanaan depresi menggabungkan psikoterapi seperti terapi kognitif perilaku dan terapi interpersonal, intervensi gaya hidup, serta farmakoterapi bila diperlukan dengan pertimbangan keamanan pada kehamilan dan menyusui. Red flags yang menuntut penanganan segera adalah pikiran bunuh diri, niat atau rencana melukai diri atau bayi, gejala psikotik, dan hambatan berat pada perawatan bayi.

Gangguan kecemasan memiliki spektrum yang luas dan sering menyertai depresi. Gangguan kecemasan menyeluruh ditandai kekhawatiran yang menetap dan sulit dikendalikan tentang berbagai hal, disertai gejala fisik seperti tegang otot, gelisah, mudah lelah, gangguan tidur, dan sulit konsentrasi. Gangguan panik tampil dengan serangan kecemasan mendadak yang intens disertai gejala fisik seperti jantung berdebar, sesak, pusing, rasa tidak nyata, dan takut mati yang memuncak dalam menit. Ketakutan akan serangan berikutnya dapat memicu penghindaran aktivitas atau tempat tertentu. Fobia spesifik melibatkan ketakutan irasional terhadap objek atau situasi tertentu, sedangkan fobia sosial berkaitan dengan ketakutan dinilai negatif oleh orang lain yang dapat menghambat kinerja kerja dan relasi. Pada perempuan dewasa, kecemasan sering diperberat oleh beban peran ganda, kurang tidur, dan peristiwa kehidupan yang penuh ketidakpastian. Terapi paparan bertahap, teknik regulasi napas, restrukturisasi kognitif, serta farmakoterapi yang dipilih dengan hati hati dapat membantu. Intervensi gaya hidup seperti kebugaran aerobik teratur, perbaikan kebersihan tidur, dan pengurangan kafeina memberi manfaat tambahan.

Gangguan stres pascatrauma merupakan konsekuensi psikologis dari paparan peristiwa yang mengancam nyawa atau integritas diri, termasuk kekerasan berbasis gender, kekerasan pasangan intim, pelecehan seksual, bencana, atau kehilangan mendadak. Gejala utama mencakup intrusi kenangan traumatis, mimpi buruk, kilas balik, penghindaran pemicu, perubahan negatif dalam suasana hati dan keyakinan tentang diri atau dunia, serta hiperwaspada dan gangguan tidur. Pada perempuan, trauma relasional yang berulang seperti kekerasan domestik sering menghasilkan gejala kompleks yang melibatkan disosiasi, rasa malu mendalam, dan kesulitan mempercayai orang lain. Pendekatan yang efektif bersifat trauma informed yang mengutamakan rasa aman, pilihan, dan kolaborasi, serta menghormati kecepatan

pemulihan klien. Terapi berfokus trauma seperti terapi pemrosesan kognitif, terapi pemaparan berkepanjangan, dan terapi desensitisasi dan pemrosesan ulang melalui gerakan mata memiliki bukti kuat. Dukungan hukum dan sosial diperlukan ketika kekerasan masih berlangsung, serta koordinasi lintas layanan agar keselamatan menjadi prioritas. Bila terdapat komorbiditas seperti penyalahgunaan zat, gangguan tidur berat, atau depresi, rencana terapi disusun berjenjang dengan target yang realistis.

Gangguan makan pada perempuan dewasa sering terkait dengan citra tubuh, standar kecantikan, dan regulasi emosi. Anoreksia nervosa ditandai pembatasan asupan energi yang menyebabkan berat badan sangat rendah, ketakutan intens terhadap kenaikan berat badan, dan distorsi citra tubuh. Bulimia nervosa melibatkan episode makan dalam jumlah besar yang disertai rasa kehilangan kendali diikuti perilaku kompensasi seperti memuntahkan makanan, penggunaan laksatif, atau olahraga berlebihan. Binge eating disorder memiliki episode makan berlebihan dengan rasa kehilangan kendali tetapi tanpa perilaku kompensasi teratur. Dampak medisnya serius: gangguan elektrolit, aritmia, kerusakan gigi dan esofagus, gangguan gastrointestinal, gangguan endokrin, penurunan kepadatan tulang, dan infertilitas. Faktor risikonya mencakup perfeksionisme kaku, pengalaman perundungan terkait tubuh, trauma, dan tekanan sosial. Penanganan memadukan terapi nutrisi, pemantauan medis, dan psikoterapi berbasis bukti seperti terapi kognitif perilaku format khusus gangguan makan, terapi berbasis keluarga untuk pasien yang lebih muda, serta terapi dialektik perilaku untuk regulasi emosi dan impuls. Keterlibatan keluarga dan pasangan sering menjadi kunci agar lingkungan mendukung pemulihan, sementara target klinis meliputi pemulihan pola makan, stabilisasi medis, dan rekonstruksi citra tubuh yang lebih realistis.

Gangguan tidur terkait stres dan kecemasan merupakan keluhan yang sangat umum pada perempuan dewasa dan sering menjadi faktor pemelihara gejala pada spektrum lain. Insomnia dapat muncul sebagai kesulitan memulai tidur, sering terbangun malam, atau bangun terlalu dini, disertai rasa tidak segar saat bangun. Pada perempuan, insomnia sering dipicu atau diperburuk oleh fluktuasi hormon pada fase pra-menstruasi, kehamilan, masa nifas, dan perimenopause. Hot flushes, nokturia, dan nyeri muskuloskeletal menambah gangguan kontinuitas tidur. Insomnia kronis meningkatkan risiko depresi, kecemasan, penyakit kardiometabolik, dan penurunan kinerja kognitif. Intervensi lini pertama adalah terapi kognitif perilaku untuk insomnia yang meliputi restriksi tidur, kontrol stimulus, restrukturisasi kognitif, dan perbaikan kebersihan tidur. Relaksasi berbasis napas, mindfulness, dan manajemen cahaya siang dapat membantu menstabilkan ritme sirkadian. Bila diperlukan, farmakoterapi digunakan jangka pendek dengan evaluasi manfaat dan

risiko yang cermat, terutama pada kehamilan dan menyusui. Mengatasi faktor pemicu seperti nyeri, apnea tidur, atau gangguan mood yang menyertai merupakan bagian integral dari rencana terapi.

Komorbiditas merupakan aturan yang sering terjadi, bukan pengecualian. Perempuan dengan depresi kerap memiliki kecemasan yang signifikan, individu dengan gangguan makan sering mengalami insomnia dan gejala trauma, dan penyintas kekerasan dapat menghadirkan kombinasi depresi, kecemasan, serta gangguan stres pascatrauma. Pendekatan klinis yang efektif memetakan hirarki masalah, menentukan target yang paling mendesak, dan menyusun intervensi berurutan yang memperhitungkan kesiapan perubahan. Skrining sistematis pada layanan primer dan kebidanan membantu mendeteksi dini, namun harus diikuti alur rujukan yang jelas dan layanan yang ramah budaya. Dukungan sosial yang konkret seperti kelompok sebaya, pendidikan keluarga, serta kebijakan tempat kerja yang fleksibel mempercepat pemulihan dan mencegah kekambuhan.

E. Dampak Kesehatan Mental terhadap Kehidupan Perempuan Dewasa

Kesehatan mental berhubungan erat dengan hampir semua sisi kehidupan perempuan dewasa. Ia memengaruhi cara tubuh merespons stres, menentukan kualitas relasi interpersonal, dan membentuk pengalaman bekerja serta menikmati hidup. Ketika kesehatan mental terganggu, yang berubah bukan hanya suasana hati, melainkan juga pola tidur, nafsu makan, tingkat energi, cara mengambil keputusan, serta kemampuan menikmati peran sebagai pasangan, orang tua, pekerja, dan anggota komunitas. Dampak ini bersifat timbal balik. Gejala psikologis dapat memperburuk kondisi fisik dan sosial, sedangkan tekanan fisik dan sosial yang berkepanjangan dapat mempertajam gejala psikologis. Memahami keterkaitan ini penting agar pendekatan penanganan tidak semata mengandalkan obat atau sesi konseling, tetapi juga menata kembali ritme hidup, dukungan sosial, dan lingkungan kerja.

Dari sisi kesehatan fisik, gangguan mental sering menampilkan diri sebagai keluhan psikosomatis. Respons stres kronis mengaktifkan aksis hipotalamus hipofisis adrenal dan sistem saraf otonom. Peningkatan kortisol yang berulang serta ketidakseimbangan simpatik parasimpatik memengaruhi tekanan darah, frekuensi nadi, regulasi gula darah, dan proses peradangan tingkat rendah. Di tingkat gejala, hal ini dapat muncul sebagai sakit kepala tegang, nyeri otot, keluhan pencernaan seperti kembung, diare, konstipasi, atau sindrom iritasi usus besar, rasa sesak yang tidak disertai temuan paru yang jelas, atau keluhan kulit yang memburuk saat cemas. Pada sebagian perempuan, stres berkepanjangan berasosiasi dengan migrain, gangguan menstruasi seperti siklus tidak teratur atau nyeri haid yang memburuk,

penurunan gairah seksual, dan gangguan tidur. Jika proses ini berlangsung lama, risiko penyakit kronis meningkat. Pola makan emosional, kelelahan, dan inaktivitas fisik memudahkan kenaikan berat badan dan sindrom metabolik. Hipertensi, diabetes tipe 2, dan penyakit kardiovaskular lebih mudah muncul atau sulit dikendalikan bila depresi dan kecemasan tidak ditangani. Nyeri kronis seperti fibromialgia sering berkelindan dengan gangguan mood dan tidur. Sebaliknya, penyakit kronis yang membutuhkan pengelolaan jangka panjang akan menjadi sumber stres yang mempertahankan gejala psikologis. Lingkaran ini menjelaskan mengapa pendekatan biopsikososial yang menggabungkan manajemen gejala, modifikasi gaya hidup, dan intervensi psikologis memberikan hasil yang lebih baik daripada fokus tunggal pada salah satu aspek.

Dampak terhadap hubungan interpersonal dan keluarga tidak kalah besar. Perubahan emosi dan energi memengaruhi cara berkomunikasi, merundingkan kebutuhan, serta mengekspresikan kehangatan. Depresi dapat membuat seseorang menarik diri, lebih sensitif terhadap kritik, dan merasa tidak layak dicintai. Kecemasan menimbulkan kewaspadaan berlebih, pikiran khawatir yang berulang, dan pola kontrol yang menyulitkan keintiman. Ketika dua orang pasangan saling berinteraksi dalam kondisi seperti ini, konflik lebih mudah menyala dan sulit dipadamkan. Percakapan strategis berubah menjadi perdebatan, masalah kecil terasa membesar, dan kesalahpahaman menjadi lebih sering. Pada relasi orang tua dan anak, gangguan mood dapat menurunkan sensitivitas pengasuhan. Orang tua yang sangat lelah atau cemas cenderung kurang responsif, kurang konsisten, atau cepat marah. Anak merespons dengan menjadi lebih rewel, menuntut, atau menyendiri, yang kemudian menambah beban emosional orang tua. Siklus ini dapat diurai dengan dukungan yang tepat, tetapi selama tidak dikenali, ia merusak rasa saling percaya dan melemahkan jaringan pengaman keluarga. Di keluarga besar dan komunitas, stigma terhadap kesehatan mental dapat memperparah isolasi sosial. Perempuan yang sedang berjuang justru diminta untuk lebih kuat, lebih sabar, atau lebih bersyukur, padahal ia membutuhkan validasi dan bantuan konkret. Ketika lingkungan berubah menjadi pendukung yang aktif, misalnya dengan berbagi tugas rumah tangga, menyediakan waktu istirahat, atau menemani ke layanan profesional, kualitas relasi membaik dan pemulihan menjadi lebih cepat.

Dampak pada produktivitas dan kualitas hidup terasa jelas di ruang kerja dan aktivitas sehari-hari. Gangguan konsentrasi, pelupa, kesulitan mengambil keputusan, serta rasa lelah yang mengambang sepanjang hari menurunkan performa tugas kognitif maupun manual. Orang mungkin hadir secara fisik di kantor tetapi tidak benar-benar mampu berkinerja optimal. Fenomena ini disebut *presenteeism* dan sering menimbulkan kerugian yang lebih besar daripada ketidakhadiran yang jelas.

Kesalahan kecil menjadi lebih sering, tenggat molor, dan kerja tim terganggu karena komunikasi yang tidak efektif. Dalam jangka panjang, peluang promosi dan perkembangan karier terhambat. Di sektor informal, produktivitas yang menurun berarti pendapatan yang berkurang dan keamanan finansial yang melemah, yang pada gilirannya memperkuat stres psikososial. Kualitas hidup pun terkena imbas. Aktivitas yang dulu menyenangkan terasa hambar, pertemuan sosial dihindari, hobi ditinggalkan, dan hari hari diisi oleh usaha untuk bertahan, bukan untuk tumbuh. Perempuan sering memikul rasa bersalah karena merasa tidak memenuhi standar sebagai pekerja, pasangan, atau orang tua. Rasa bersalah yang dibiarkan akan memakan ruang mental, memperkuat pikiran negatif tentang diri, dan menunda pencarian pertolongan. Di titik ini, intervensi yang menggabungkan perawatan klinis, penyesuaian beban kerja, dan dukungan sosial dapat memutus pola yang merugikan.

Semua dampak di atas saling memengaruhi dan membentuk rangkaian sebab akibat yang kompleks. Gangguan tidur memperburuk mood dan kecemasan, mood yang memburuk mengurangi motivasi beraktivitas fisik, kurangnya aktivitas menurunkan kualitas tidur, dan seterusnya. Konflik keluarga menambah tekanan psikologis, tekanan psikologis menurunkan kesabaran dan empati, lalu konflik kembali meningkat. Di tempat kerja, performa yang menurun memicu kritik atau sanksi, yang memperdalam rasa tidak mampu dan kecemasan anticipatory. Memahami dinamika ini membantu klinisi, keluarga, dan penyintas melihat bahwa perbaikan kecil yang konsisten pada satu simpul dapat menghasilkan dampak perbaikan berantai di simpul yang lain. Memperbaiki kebersihan tidur, misalnya, sering memberi ruang bagi energi dan kejernihan berpikir untuk kembali. Mengurangi beban kerja atau menata ulang jadwal memungkinkan penanganan klinis berjalan lebih efektif. Membuka kanal dukungan sosial mengurangi rasa terasing, yang pada gilirannya mengurangi gejala.

F. Strategi Promosi dan Pencegahan Kesehatan Mental

Promosi dan pencegahan kesehatan mental pada perempuan dewasa bekerja paling efektif ketika dipahami sebagai gerak bersama yang menyentuh tiga lapis sekaligus, yaitu penguatan individu, pengaktifan dukungan sosial, dan penataan ekosistem layanan. Pendekatan ini melihat perempuan dalam lintasan hidup yang dinamis, dari masa produktif hingga transisi perimenopause dan menopause, serta mengakui peran ganda yang kerap melelahkan. Tujuan akhirnya adalah membangun kemampuan mengenali gejala sejak dini, mengelola stres dengan keterampilan yang terukur, mencari bantuan tanpa stigma, dan mengakses layanan yang ramah budaya serta berkesinambungan.

Edukasi kesehatan mental merupakan batu pijakan pertama. Edukasi yang efektif tidak berhenti pada slogan, tetapi menyajikan pengetahuan yang dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang disampaikan sebaiknya menjelaskan cara kerja stres pada tubuh, hubungan antara hormon, tidur, nutrisi, dan suasana hati, serta perbedaan antara rasa sedih yang wajar dengan depresi yang membutuhkan pertolongan profesional. Bahasa yang digunakan perlu sederhana, contoh diarahkan pada situasi nyata perempuan di rumah, di tempat kerja, dan di komunitas. Edukasi menjadi lebih bermakna bila ditempatkan pada momen layanan yang sudah akrab, seperti kelas ibu hamil, kunjungan nifas, posyandu, penyuluhan di tempat kerja, pengajian, dan pertemuan kelompok perempuan. Di sana, tenaga kesehatan dapat memperkenalkan alat skrining sederhana seperti kuesioner suasana hati dan kecemasan, mengajarkan teknik pernapasan singkat yang dapat dilakukan kapan saja, serta menormalisasi pengalaman mencari bantuan. Pelibatan pasangan dan keluarga besar dalam edukasi akan memperluas jangkauan dampak, sebab dukungan terdekat sering menjadi penentu keberhasilan upaya pemulihan.

Di atas fondasi edukasi, pemberdayaan perempuan dalam manajemen stres menjadi kunci untuk pencegahan primer dan sekunder. Pemberdayaan berarti memberikan keterampilan, ruang, dan legitimasi bagi perempuan untuk merawat dirinya sendiri tanpa rasa bersalah. Keterampilan inti yang perlu dilatih meliputi pengaturan napas yang menenangkan sistem saraf otonom, relaksasi otot progresif untuk menurunkan ketegangan fisik, dan latihan kesadaran penuh untuk membantu mengenali pikiran otomatis yang memicu kekhawatiran berulang. Strategi perilaku seperti aktivasi kegiatan yang memberi rasa bermakna dan gembira membantu melawan penarikan diri akibat mood rendah. Keterampilan kognitif untuk menantang pikiran bencana, teknik pemecahan masalah langkah demi langkah, serta latihan komunikasi asertif berperan menjaga batas pribadi agar tuntutan eksternal tidak terus menerus melampaui kapasitas. Pemberdayaan juga menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar yang sering diabaikan, seperti tidur yang cukup, pola makan seimbang, dan gerak tubuh teratur. Ketika perempuan memiliki alat praktis untuk menstabilkan diri, ia lebih siap menghadapi fluktuasi siklus reproduksi, konflik peran, dan kejutan peristiwa hidup. Dalam konteks kekerasan berbasis gender, pemberdayaan berarti pula menyusun rencana keselamatan, mengenali tanda-tanda kontrol dan manipulasi, serta memahami jalur bantuan hukum dan sosial yang tersedia.

Intervensi berbasis komunitas dan dukungan sosial memperluas jangkauan dari ranah individu ke ranah kolektif. Komunitas adalah cermin dan sekaligus wadah pemulihan. Kelompok sebaya yang dipandu tenaga terlatih, baik di puskesmas, tempat ibadah, kantor, maupun organisasi masyarakat, memberikan ruang aman

untuk berbagi pengalaman tanpa dihakimi. Di sana, perempuan saling menguatkan, belajar dari strategi satu sama lain, dan mendapatkan validasi bahwa gejala yang mereka alami bukan tanda kelemahan. Kader kesehatan, bidan, perawat, dan tokoh masyarakat dapat dilatih sebagai penolong pertama kesehatan jiwa, yang mampu mengenali tanda bahaya, memberikan pertolongan awal yang empatik, dan mengarahkan pada rujukan yang tepat. Jaringan rujukan yang jelas antara komunitas, layanan primer, dan layanan rujukan spesialis menghindarkan perempuan dari kebingungan birokrasi yang menguras energi. Di lingkungan kerja, program dukungan karyawan, penjadwalan fleksibel, fasilitas laktasi, serta kebijakan anti kekerasan dan pelecehan adalah bentuk intervensi komunitas yang berdampak langsung. Di lingkungan keluarga, pembagian beban kerja domestik yang adil, waktu istirahat yang dihormati, dan keterlibatan pasangan dalam pengasuhan menurunkan beban mental yang selama ini tersembunyi.

Peran media dan teknologi kesehatan digital membuka peluang skalabilitas dan kontinuitas dukungan. Media memiliki daya untuk mengubah norma, karena itu pesan yang disebarkan perlu akurat, empatik, dan tidak sensasional. Kisah pemulihan yang dituturkan dengan aman dapat mengikis stigma dan mengundang orang lain untuk mencari bantuan lebih dini. Platform digital memungkinkan penyampaian modul mikro pembelajaran, latihan manajemen stres singkat, jadwal pengingat tidur dan minum obat, serta pemantauan suasana hati yang dapat dibagikan kepada tenaga kesehatan bila pengguna mengizinkan. Layanan konseling jarak jauh mengatasi hambatan geografis dan waktu, terutama bagi perempuan yang sulit meninggalkan rumah atau memiliki jadwal kerja bergilir. Namun pemanfaatan teknologi harus peka terhadap kesenjangan akses dan literasi digital. Aplikasi sebaiknya ringan, hemat data, tersedia dalam bahasa setempat, dan menjunjung tinggi kerahasiaan serta persetujuan informasi. Etika digital menuntut transparansi tentang tujuan pengumpulan data, pilihan untuk menolak, dan kanal komplain yang mudah dijangkau. Kolaborasi antara penyedia layanan digital dengan fasilitas kesehatan setempat memudahkan integrasi rujukan, sehingga pengguna tidak terputus di dunia maya tanpa pegangan nyata.

Strategi promosi dan pencegahan yang utuh selalu diikuti pengukuran dan pembelajaran berkelanjutan. Program yang baik menetapkan indikator yang jelas, misalnya peningkatan literasi kesehatan jiwa, penurunan stigma yang terukur, peningkatan deteksi dini, dan perbaikan fungsi harian. Umpan balik dari peserta, tenaga pelaksana, dan pemangku kepentingan digunakan untuk menyempurnakan materi, metode, serta cara rekrutmen. Pendekatan yang peka kesetaraan memastikan perempuan dari kelompok rentan tidak tertinggal, termasuk yang tinggal di wilayah terpencil, bekerja di sektor informal, atau memiliki disabilitas.

Pendanaan yang berkelanjutan, penguatan kapasitas tenaga di lapangan, serta kepemimpinan lokal yang konsisten menjamin program tidak berhenti di tengah jalan.

G. Peran Tenaga Kesehatan dalam Menangani Kesehatan Mental Perempuan

Peran tenaga kesehatan dalam kesehatan mental perempuan dewasa dimulai jauh sebelum diagnosis ditegakkan dan berlanjut hingga fase pemulihan jangka panjang. Pendekatan yang efektif menempatkan perempuan sebagai subjek yang berdaya, mengakui dinamika biologis reproduksi, serta memadukan intervensi klinis dengan dukungan keluarga dan komunitas. Fokusnya bukan hanya meredakan gejala, tetapi juga memulihkan fungsi, memperkuat ketahanan, dan mencegah kekambuhan.

Pengkajian dan deteksi dini menjadi pintu masuk yang menentukan kualitas penanganan selanjutnya. Proses ini idealnya berlangsung dalam suasana yang aman, empatik, dan rahasia, sehingga perempuan merasa cukup nyaman untuk menceritakan keluhan emosional, beban peran, dan pengalaman yang sensitif seperti kekerasan atau kehilangan. Tenaga kesehatan memulai dengan anamnesis biopsikososial yang komprehensif, meliputi riwayat gejala psikologis, durasi dan derajat gangguan fungsi, pola tidur dan nafsu makan, konsumsi kafeina atau alkohol, penyakit fisik penyerta, obat dan kontrasepsi yang digunakan, serta fase reproduksi yang sedang dialami seperti pramenstruasi, kehamilan, masa nifas, atau perimenopause. Pemeriksaan keadaan mental membantu memetakan suasana hati, alur pikir, persepsi, konsentrasi, dan risiko diri. Alat skrining terstandar seperti kuesioner depresi, kecemasan, gejala perinatal, trauma, dan insomnia dapat digunakan sebagai penguat temuan klinis, bukan sebagai pengganti penilaian profesional. Penilaian risiko bunuh diri atau melukai diri harus dilakukan secara sistematis, termasuk eksplorasi pikiran, rencana, sarana, dan protektor seperti dukungan keluarga atau keyakinan spiritual. Red flags seperti gejala psikotik perinatal, niat menyakiti diri atau bayi, delirium, atau hambatan berat dalam merawat bayi membutuhkan penatalaksanaan segera. Pada saat yang sama, tenaga kesehatan mempertimbangkan kemungkinan kondisi medis yang meniru atau memperberat gejala psikologis, misalnya gangguan tiroid, anemia, nyeri kronis, atau efek obat, sehingga pemeriksaan fisik dan penunjang selektif sering dibutuhkan. Dokumentasi yang jelas, sensitif, dan aman sangat penting, termasuk rencana keselamatan bila ada risiko akut.

Setelah masalah teridentifikasi, konseling, terapi psikologis, dan pendekatan farmakologis disusun dalam kerangka perawatan bertahap. Edukasi adalah langkah awal yang tidak boleh dilewatkan. Dengan bahasa sederhana dan contoh yang

relevan, tenaga kesehatan menjelaskan apa yang sedang terjadi pada tubuh dan pikiran, mengapa gejala muncul dan berulang, serta apa yang dapat diharapkan dari proses terapi. Keterampilan manajemen stres diperkenalkan sejak awal, termasuk regulasi napas, relaksasi otot progresif, mindfulness untuk mengenali pikiran otomatis, kebersihan tidur, dan aktivasi perilaku yang mengembalikan minat terhadap kegiatan bermakna. Terapi psikologis dipilih berdasarkan profil gejala dan preferensi pasien. Terapi kognitif perilaku membantu menata ulang pola pikir bencana dan mengembangkan kebiasaan sehat. Terapi interpersonal bermanfaat pada depresi, terutama ketika isu relasi, duka, atau perubahan peran menjadi pemicu utama. Pada trauma, terapi berfokus trauma seperti pemrosesan kognitif atau paparan berkepanjangan dapat mengurangi intrusi dan penghindaran, asalkan rasa aman terjaga. Untuk masalah regulasi emosi dan impuls, keterampilan dari terapi dialektik perilaku memberi kerangka praktis. Konseling pasangan atau keluarga dipertimbangkan bila dinamika relasi memperkuat gejala atau menghambat pemulihan.

Pendekatan farmakologis diberikan bila gejala sedang hingga berat, menghambat fungsi, tidak respon terhadap intervensi psikologis, atau ketika terdapat risiko yang menuntut perbaikan lebih cepat. Pemilihan obat mempertimbangkan efektivitas, profil efek samping, fase reproduksi, dan preferensi pasien. Prinsipnya adalah memulai dengan dosis rendah dan menaikkan secara bertahap sambil memantau respons dan tolerabilitas. Pada kehamilan dan menyusui, keputusan dibuat melalui pengambilan keputusan bersama, menimbang risiko tidak diobati terhadap ibu dan bayi, serta bukti keamanan obat tertentu. Penggunaan obat penenang jangka pendek hanya dipertimbangkan secara hati-hati pada kondisi akut, dengan rencana penghentian yang jelas. Intervensi non farmakologis seperti olahraga aerobik teratur, nutrisi seimbang, paparan cahaya pagi, dan manajemen nyeri komorbid meningkatkan peluang keberhasilan. Pada kondisi tertentu yang berat dan refrakter, terapi somatik seperti stimulasi otak atau terapi elektrokonvulsif di pusat berpengalaman dapat menjadi opsi yang aman dan efektif, terutama bila nyawa terancam atau terdapat gejala psikotik yang tidak terkendali. Semua intervensi memerlukan pemantauan terukur, misalnya penilaian gejala berkala, pemantauan efek samping, dan evaluasi fungsi sosial serta kualitas hidup.

Kolaborasi interprofesional memastikan masalah kompleks ditangani dari berbagai sisi sekaligus. Dokter layanan primer berperan sebagai koordinator perawatan, melakukan skrining, memulai intervensi dasar, dan menata rujukan bila perlu. Perawat memegang peran sentral dalam pemantauan harian, edukasi, penguatan keterampilan coping, dan deteksi dini perubahan kondisi. Bidan sangat

strategis pada periode prakonsepsi, kehamilan, dan masa nifas dengan integrasi skrining perinatal, konseling laktasi, serta identifikasi dini depresi atau kecemasan pascapersalinan. Psikolog klinis memberikan terapi berbasis bukti yang terstruktur dan terukur kemajuannya. Pekerja sosial menghubungkan pasien dengan sumber daya komunitas, bantuan hukum pada kasus kekerasan, dukungan finansial, dan program rehabilitasi kerja. Ahli gizi, dokter spesialis kebidanan atau penyakit dalam, serta psikiater terlibat sesuai kebutuhan klinis, misalnya pada komorbiditas medis, perencanaan kehamilan dengan riwayat gangguan mental, atau kasus berat yang memerlukan tata laksana spesialis. Pertemuan tim secara berkala, rencana perawatan bersama yang terdokumentasi, dan saluran komunikasi yang jelas meminimalkan duplikasi layanan, mencegah kesenjangan perawatan, dan menjaga konsistensi pesan kepada pasien serta keluarga. Semua kolaborasi dilakukan dengan menjaga kerahasiaan, persetujuan yang diinformasikan, dan sensitivitas budaya.

Rujukan dan akses layanan adalah jembatan antara deteksi dan pemulihan. Sistem perawatan yang baik menyediakan jalur rujukan bertingkat yang mudah dipahami, mulai dari layanan primer menuju psikolog atau psikiater, hingga perawatan intensif bila risiko tinggi. Tenaga kesehatan membantu pasien menavigasi pilihan layanan yang tersedia, termasuk konsultasi tatap muka dan telekonseling, kelompok dukungan sebaya, serta layanan krisis. Pada kasus kekerasan berbasis gender, rujukan mencakup fasilitas yang menjamin keselamatan, pendampingan hukum, dan layanan trauma informed. Hambatan umum seperti biaya, jarak, jam layanan, pengasuhan anak, atau kekhawatiran stigma diatasi melalui solusi praktis, misalnya jadwal fleksibel, lokasi ramah perempuan, integrasi layanan di posyandu atau puskesmas, serta edukasi kepada keluarga agar mendukung kunjungan. Tindak lanjut terjadwal sejak awal mengurangi kehilangan jejak dan memberikan kesempatan mengevaluasi kepatuhan, efek samping obat, serta hambatan baru yang muncul. Rencana keselamatan dan pencegahan kekambuhan disusun bersama, meliputi tanda peringatan dini, strategi koping yang efektif, kontak darurat, serta kesepakatan untuk mengaktifkan bantuan bila gejala kembali meningkat. Setelah gejala stabil, transisi ke pemeliharaan dilakukan secara bertahap dengan frekuensi kontrol yang menurun tetapi tetap terencana, agar keberlanjutan dukungan terjaga.

H. Studi Kasus dan Praktik Baik

Kisah berikut disusun sebagai vignette edukatif yang menggabungkan pengalaman klinis yang umum ditemui pada layanan kesehatan. Tujuannya adalah membantu pembaca memahami alur penilaian, penanganan, dan pembelajaran praktis tanpa mengungkap identitas siapa pun.

Kasus pertama menggambarkan depresi pada perempuan pekerja. Seorang perempuan dewasa awal bekerja di bidang layanan pelanggan dengan jadwal bergilir yang sering melampaui jam normal. Ia juga menanggung sebagian besar kerja domestik di rumah serta merawat orang tua yang mulai rentan. Dalam beberapa bulan terakhir ia merasa bangun tanpa rasa segar, kehilangan minat pada hal yang dulunya menyenangkan, dan mulai melakukan kesalahan kecil di tempat kerja. Ia mengeluhkan sulit tidur karena pikiran yang berputar dan bangun lebih pagi dari biasanya dengan rasa cemas yang tidak jelas sumbernya. Ia menilai dirinya gagal sebagai pekerja dan anggota keluarga karena kerap menunda tugas dan mudah tersulut emosi pada anak. Di layanan primer, tenaga kesehatan melakukan anamnesis biopsikososial yang cermat, memeriksa keadaan mental, menilai risiko, serta menyingkirkan komorbid fisik seperti anemia atau gangguan tiroid melalui pemeriksaan selektif. Edukasi menjadi langkah pertama, menjelaskan bahwa gejala yang dialami merupakan pola depresi yang dapat ditangani. Rencana penanganan disusun bertahap. Terapi kognitif perilaku difokuskan pada restrukturisasi pikiran otomatis yang menurunkan harga diri dan latihan aktivasi perilaku untuk memulihkan ritme kegiatan yang memberi rasa bermakna. Kebersihan tidur diperbaiki melalui jadwal bangun konsisten, pembatasan layar sebelum tidur, dan manajemen kafeina. Di tempat kerja, atasan diajak berdialog untuk menata beban tugas dan rotasi shift yang lebih ramah kesehatan. Pasangan dan anggota keluarga lain dilibatkan untuk berbagi tugas rumah tangga agar beban mental tidak menumpuk. Setelah beberapa minggu, muncul perbaikan bertahap pada energi dan fokus, konflik rumah tangga mereda, dan kinerja kerja kembali stabil. Penguatan dilakukan melalui rencana pencegahan kekambuhan yang menandai tanda peringatan dini serta strategi koping yang efektif.

Kasus kedua menyoroti gangguan kecemasan pada fase pascamenopause. Seorang perempuan paruh baya yang telah berhenti menstruasi selama lebih dari setahun datang dengan keluhan berdebar, sensasi panas, sulit tidur, dan kekhawatiran berlebihan terhadap kesehatan dirinya. Ia mulai menghindari perjalanan jauh, enggan menghadiri pertemuan sosial, serta cenderung memantau gejala tubuh secara berulang. Riwayat keluarga menunjukkan ibu dengan gangguan kecemasan, dan beberapa tahun terakhir ia mengalami kehilangan orang terdekat serta perubahan peran di rumah. Tenaga kesehatan menjelaskan keterkaitan perubahan hormonal, gangguan tidur, dan sensitivitas terhadap gejala tubuh yang dapat memicu siklus panik dan penghindaran. Pendekatan psikoterapi berfokus pada psikoedukasi tentang respon cemas, latihan pernapasan pelan untuk menstabilkan sistem saraf otonom, serta terapi paparan bertahap terhadap situasi yang dihindari agar keyakinan bencana dapat dilunakkan oleh pengalaman aman.

Konsultasi dengan layanan kebidanan kandungan dilakukan untuk menilai kelayakan terapi non farmakologis tambahan dan menimbang pilihan tata laksana vasomotor yang aman sesuai profil risiko. Perbaikan tidur dikerjakan melalui rutinitas relaksasi malam, paparan cahaya pagi, dan aktivitas fisik teratur di siang hari. Dukungan pasangan dikerahkan agar beban rumah tangga dibagi lebih adil, memberikan ruang bagi latihan dan pemulihan. Dalam beberapa bulan, intensitas serangan cemas berkurang, partisipasi sosial meningkat kembali, dan kualitas tidur membaik. Pasien melaporkan merasa lebih percaya diri karena memahami pola gejalanya dan memiliki keterampilan yang dapat diterapkan ketika cemas muncul.

Praktik baik berbasis komunitas memperlihatkan bagaimana dukungan sosial mempercepat pemulihan dan mencegah kekambuhan. Sebuah puskesmas di wilayah padat penduduk membangun kemitraan dengan kader, tokoh masyarakat, dan kelompok perempuan setempat. Di posyandu dan pertemuan warga, tenaga kesehatan menyisipkan sesi singkat tentang kesehatan mental, teknik pernapasan, dan cara mengenali tanda bahaya. Kader dilatih sebagai penolong pertama kesehatan jiwa yang mampu mendengar secara empatik, menjaga kerahasiaan, dan membantu rujukan bila gejala mengganggu fungsi sehari-hari atau ada risiko keselamatan. Kelompok sebaya dibentuk dengan pertemuan mingguan yang dipandu fasilitator terlatih. Di ruang itu, perempuan berbagi strategi menghadapi kelelahan, mengelola konflik rumah tangga tanpa kekerasan, dan menata ulang prioritas agar kebutuhan diri tidak selalu dikesampingkan. Jalur rujukan dirancang sederhana, mulai dari layanan primer ke psikolog klinis atau psikiater, dengan opsi konseling jarak jauh bagi yang memiliki kendala mobilitas. Lingkungan kerja sekitar puskesmas diajak menyediakan kebijakan yang ramah kesehatan mental seperti penjadwalan fleksibel, fasilitas laktasi, dan mekanisme pelaporan pelecehan yang aman. Rumah ibadah setempat menambahkan pesan penerimaan dan dukungan dalam kegiatan rutin agar stigma berkurang. Dalam satu tahun, lebih banyak perempuan datang lebih dini untuk berkonsultasi, kehadiran kelompok sebaya stabil, dan tenaga kesehatan melaporkan penurunan kunjungan berulang karena keluhan psikosomatis yang tidak terjelaskan. Yang paling penting, para peserta menyebutkan bahwa mereka merasa didengar, memiliki bahasa untuk menamai pengalaman emosional, dan tahu harus mencari bantuan ke mana ketika gejala meningkat.

I. Tantangan dan Hambatan dalam Penanganan Kesehatan Mental Perempuan Dewasa

Penanganan kesehatan mental perempuan dewasa berada pada persimpangan faktor budaya, struktur layanan, kapasitas tenaga profesional, dan kebijakan pembiayaan. Di satu sisi ada kebutuhan klinis yang jelas, di sisi lain ada dinding tak kasatmata yang membuat perjalanan menuju pertolongan terasa jauh. Tantangan yang dihadapi bukan tunggal, melainkan saling terkait sehingga hambatan di satu titik sering memicu hambatan di titik lain. Memahami lanskap ini membantu kita merancang respons yang tidak hanya klinis, tetapi juga sosial dan kebijakan.

Stigma sosial dan budaya menjadi penghalang pertama yang paling sering ditemui. Banyak perempuan tumbuh dalam norma yang menilai ketangguhan sebagai kebajikan utama, sehingga mengungkapkan kelelahan emosional atau kecemasan kerap dianggap kelemahan karakter. Keluhan depresi mudah disalahartikan sebagai kurang iman, kurang bersyukur, atau kurang kuat menghadapi masalah. Pada periode perinatal, gejala depresi atau kecemasan pascapersalinan bisa dipandang sebagai kegagalan menjadi ibu yang baik, bukan sebagai kondisi klinis yang membutuhkan pertolongan. Stigma ini tidak hanya datang dari lingkungan, tetapi dapat berputar menjadi stigma yang diinternalisasi. Perempuan mulai mengkritik diri sendiri, merasa bersalah, dan menunda mencari bantuan karena takut dicap berlebihan atau tidak kompeten di hadapan keluarga dan rekan kerja. Dalam komunitas kecil, kekhawatiran terhadap privasi menambah beban, sebab mengakses layanan yang terlihat publik bisa memicu gosip. Di tempat kerja, banyak yang khawatir pengakuan atas masalah mental akan menghambat promosi atau menempelkan label tidak dapat diandalkan. Semua dinamika ini membentuk senyap yang panjang, membuat gejala kian dalam sebelum akhirnya mendapat perhatian profesional.

Keterbatasan akses layanan kesehatan mental kemudian mempertebal hambatan. Layanan yang tersedia sering terkonsentrasi di kota besar, sementara perempuan di wilayah pinggiran perlu menempuh jarak jauh untuk bertemu profesional. Biaya transportasi, biaya konsultasi, dan kehilangan penghasilan karena harus meninggalkan pekerjaan menjadi pertimbangan nyata. Bagi yang memiliki anak kecil, ketiadaan pengasuh membuat kunjungan ke layanan menjadi urusan rumit yang menuntut koordinasi banyak pihak. Jam praktik yang tidak fleksibel, antrean panjang, atau prosedur administrasi yang berbelit menguras energi yang seharusnya disimpan untuk proses pemulihan. Konseling jarak jauh memang membuka peluang, tetapi tidak semua memiliki perangkat, koneksi internet, atau ruang privat yang aman untuk berbicara. Perempuan penyintas kekerasan

menghadapi hambatan tambahan berupa kontrol pasangan atas mobilitas, keuangan, serta akses telepon. Hambatan bahasa dan literasi kesehatan juga memainkan peran penting. Penjelasan medis yang teknis sulit dicerna, sementara materi edukasi yang tidak peka budaya membuat pesan tidak benar benar sampai. Di titik ini, akses tidak hanya berarti keberadaan layanan, tetapi juga keterjangkauan, keterterimaan, dan rasa aman saat menggunakannya.

Kesenjangan tenaga profesional dan fasilitas melukiskan sisi struktural dari persoalan. Rasio psikolog, psikiater, dan konselor terlatih terhadap jumlah penduduk masih rendah di banyak daerah, sehingga waktu tunggu panjang dan sesi tindak lanjut sulit dijadwalkan secara konsisten. Layanan primer belum selalu memiliki tenaga yang percaya diri melakukan skrining, konseling dasar, dan penanganan awal, terutama untuk isu yang sensitif seperti kekerasan berbasis gender atau depresi perinatal. Pelatihan tentang pendekatan peka trauma dan kesehatan mental periode reproduksi belum merata, akibatnya pengalaman klinis pasien terasa acak tergantung siapa yang mereka temui. Dari sisi fasilitas, ruang konsultasi yang sempit dan kurang privat dapat menghambat percakapan mendalam. Ketersediaan obat psikiatri generik umumnya lebih baik daripada ketersediaan layanan psikoterapi terstruktur, sehingga perawatan sering condong pada farmakoterapi meskipun banyak kasus membutuhkan kombinasi psikoterapi. Dukungan rehabilitasi sosial, reintegrasi kerja, dan kelompok sebaya juga belum menjadi bagian rutin dari paket layanan. Ketika tenaga kesehatan sendiri mengalami beban kerja tinggi dan kelelahan emosional, kualitas relasi terapeutik ikut terdampak, padahal kepercayaan pasien sangat bergantung pada kehadiran yang empatik dan stabil.

Isu kebijakan dan pembiayaan kesehatan melatarbelakangi hampir semua kendala di atas. Alokasi anggaran untuk kesehatan jiwa relatif kecil jika dibandingkan beban masalahnya, sehingga program promosi dan pencegahan sering tersisih oleh layanan kuratif yang mendesak. Skema pembiayaan jarang memberikan nilai yang memadai untuk sesi psikoterapi, kunjungan tindak lanjut, dan kerja tim lintas profesi, padahal komponen inilah yang menentukan keberlanjutan pemulihan. Standar nasional mengenai skrining kesehatan mental di layanan kebidanan, keperawatan, dan layanan primer belum selalu dipraktikkan konsisten, baik karena keterbatasan sumber daya maupun belum jelasnya indikator kinerja yang mendorong implementasi. Fragmentasi antar sektor membuat jalur rujukan menjadi berliku, misalnya antara layanan kesehatan, perlindungan sosial, dan penegakan hukum pada kasus kekerasan. Pengelolaan data sering terpecah di banyak sistem, menyulitkan pemantauan hasil, evaluasi program, dan perencanaan berbasis bukti. Di tempat kerja, regulasi yang melindungi kesehatan mental karyawan dan

mencegah pelecehan belum terimplementasi seragam, sehingga beban perubahan sering jatuh pada individu, bukan pada sistem.

Keempat kelompok hambatan ini saling mengunci. Stigma membuat perempuan menunda akses, saat akses dicoba hambatan biaya dan jarak menghadang, ketika berhasil bertemu tenaga kesehatan terbentur keterbatasan waktu dan kapasitas, dan setelah itu tindak lanjut tersendat oleh skema pembiayaan yang tidak mendorong perawatan jangka menengah. Lingkaran ini dapat diputus, tetapi membutuhkan langkah yang sejajar di banyak lini. Perubahan norma memerlukan narasi publik yang empatik dan teladan dari tokoh yang dipercaya, sehingga mengungkapkan gejala dipandang sebagai langkah berani merawat diri. Akses perlu dipermudah melalui integrasi skrining di layanan primer, jam praktik yang lebih fleksibel, dukungan pengasuhan anak saat kunjungan, serta opsi konseling jarak jauh yang aman. Kapasitas tenaga kesehatan dapat ditingkatkan melalui pelatihan berjenjang, supervisi klinis yang rutin, serta protokol rujukan yang sederhana dan mudah diikuti. Dari sisi kebijakan, insentif pembiayaan untuk psikoterapi, kolaborasi tim, dan program komunitas akan menggeser fokus dari krisis sesaat menuju pemulihan berkelanjutan. Perempuan penyintas kekerasan membutuhkan koridor aman yang nyata, mulai dari layanan kesehatan yang peka trauma hingga jalur hukum yang melindungi tanpa reviktimisasi.

J. Simpulan

Bab ini menegaskan bahwa kesehatan mental perempuan dewasa adalah pilar yang menopang kualitas hidup individu, keluarga, dan masyarakat. Kesehatan jiwa perempuan dibentuk oleh pertemuan faktor biologis, psikologis, dan sosial yang saling memengaruhi sepanjang lintasan kehidupan reproduksi, mulai dari pra-menstruasi, kehamilan, masa nifas, hingga perimenopause dan menopause. Kerentanan tidak semata ditentukan oleh fluktuasi hormon, tetapi juga oleh pengalaman hidup, strategi koping, dukungan sosial, dan struktur kesempatan di rumah, tempat kerja, serta komunitas.

Spektrum gangguan yang paling sering muncul pada perempuan dewasa mencakup depresi, termasuk depresi pascapersalinan, gangguan kecemasan, gangguan stres pascatrauma, gangguan makan, dan gangguan tidur terkait stres. Gejala sering tumpang tindih dan hadir bersama, sehingga penilaian yang peka fase kehidupan dan riwayat kekerasan atau trauma menjadi kunci. Tanpa deteksi dan penanganan yang memadai, gangguan ini berdampak luas terhadap kesehatan fisik melalui jalur psikosomatik dan peradangan tingkat rendah, mengganggu hubungan interpersonal dan pengasuhan, menurunkan produktivitas, serta mereduksi kualitas

hidup. Dampak tersebut bersifat antargenerasi, karena kondisi mental ibu memengaruhi tumbuh kembang, regulasi emosi, dan kesehatan anak.

Jawaban atas tantangan tersebut tidak dapat bertumpu pada satu intervensi tunggal. Pendekatan yang diperlukan bersifat holistik dan integratif, mencakup upaya promotif untuk meningkatkan literasi kesehatan mental dan menurunkan stigma, langkah preventif melalui skrining pada periode rentan dan penguatan keterampilan manajemen stres, layanan kuratif yang menggabungkan psikoterapi berbasis bukti dan farmakoterapi yang aman sesuai fase reproduksi, serta dukungan rehabilitatif untuk memulihkan fungsi sosial dan mencegah kekambuhan. Seluruh upaya ini perlu berlandaskan prinsip peka gender dan peka trauma agar perempuan merasa aman, dihormati, dan berdaya dalam proses pemulihan.

Tenaga kesehatan berperan sebagai penghubung utama antara gejala dan pemulihan. Anamnesis biopsikososial yang komprehensif, penggunaan alat skrining sebagai penunjang, edukasi yang jelas, serta perawatan bertahap yang terukur merupakan fondasi tata laksana. Kolaborasi interprofesional antara dokter layanan primer, perawat, bidan, psikolog, pekerja sosial, ahli gizi, psikiater, dan disiplin terkait memastikan masalah kompleks ditangani dari berbagai sisi dengan rujukan yang jelas, tindak lanjut yang terjadwal, dan rencana keselamatan ketika risiko meningkat.

Di luar klinik, lingkungan sosial menentukan keberhasilan jangka panjang. Keluarga yang berbagi beban kerja domestik, kelompok sebaya yang aman, tempat kerja yang ramah kesehatan mental dan bebas kekerasan, serta pemanfaatan layanan digital yang etis dan terjangkau, akan mempercepat akses, memperkuat keterlibatan, dan mencegah isolasi. Program komunitas yang sederhana, konsisten, dan diukur kemajuannya mampu menutup kesenjangan akses, terutama bagi perempuan yang tinggal jauh dari pusat layanan atau menghadapi hambatan mobilitas.

Perubahan yang bermakna memerlukan dukungan kebijakan dan pembiayaan yang memadai. Standar skrining yang diintegrasikan ke layanan primer, insentif untuk psikoterapi dan kerja tim, jalur rujukan yang sederhana antar sektor kesehatan, sosial, dan hukum, serta perlindungan bagi penyintas kekerasan akan memutus lingkaran hambatan yang selama ini mengunci perempuan pada gejala. Penguatan data dan evaluasi rutin memastikan program berjalan berdasarkan bukti dan menjangkau kelompok paling rentan.

K. Referensi

American College of Obstetricians and Gynecologists. (2023a). Screening and diagnosis of mental health conditions during pregnancy and postpartum (Clinical Practice Guideline No. 4). *Obstetrics & Gynecology*, 141(6), 1232–1261.

- American College of Obstetricians and Gynecologists. (2023b). Treatment and management of mental health conditions during pregnancy and postpartum (Clinical Practice Guideline No. 5). *Obstetrics & Gynecology*, 141(6), 1262–1288.
- American Psychiatric Association. (2022). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed., text rev.). American Psychiatric Publishing.
- American Psychological Association. (2017). *Clinical practice guideline for the treatment of posttraumatic stress disorder*. American Psychological Association.
- Department of Veterans Affairs, & Department of Defense. (2023). VA/DoD clinical practice guideline for the management of posttraumatic stress disorder and acute stress disorder: Provider summary (Version 4.0). VA/DoD.
- Edinger, J. D., Arnedt, J. T., Bertisch, S. M., Carney, C. E., Harrington, J. J., Lichstein, K. L., ... Zee, P. C. (2021). Behavioral and psychological treatments for chronic insomnia disorder in adults: An American Academy of Sleep Medicine clinical practice guideline. *Journal of Clinical Sleep Medicine*, 17(2), 255–262.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama*. Kementerian Kesehatan RI.
- National Institute for Health and Care Excellence. (2017). *Eating disorders: Recognition and treatment* (NICE Guideline NG69). NICE.
- National Institute for Health and Care Excellence. (2018). *Post-traumatic stress disorder* (NICE Guideline NG116). NICE.
- National Institute for Health and Care Excellence. (2022). *Depression in adults: Treatment and management* (NICE Guideline NG222). NICE.
- North American Menopause Society. (2023). The 2023 nonhormone therapy position statement of The North American Menopause Society. *Menopause*, 30(6), 573–590.
- O'Connor, E., Senger, C. A., Henninger, M. L., Coppola, E., & Gaynes, B. N. (2019). Interventions to prevent perinatal depression: Evidence report and systematic review for the U.S. Preventive Services Task Force. *JAMA*, 321(6), 588–601.
- Philippe, T. J., Sikder, N., Jackson, A., Koblanski, M. E., Vieira, L., Wang, J., & Lipson, S. K. (2022). Digital health interventions for delivery of mental health care. *JMIR Mental Health*, 9(5), e35159.
- Qaseem, A., Kansagara, D., Forciea, M. A., Cooke, M., & Denberg, T. D. (2016). Management of chronic insomnia disorder in adults: A clinical practice guideline from the American College of Physicians. *Annals of Internal Medicine*, 165(2), 125–133.
- Santomauro, D. F., Herrera, A. M. M., Shadid, J., Zheng, P., Ashbaugh, C., Pigott, D.

- M.,... Ferrari, A. J. (2021). Global prevalence and burden of depressive and anxiety disorders in 2020 due to the COVID-19 pandemic. *The Lancet*, 398(10312), 1700–1712.
- Sateia, M. J., Buysse, D. J., Krystal, A. D., Neubauer, D. N., & Heald, J. L. (2017). Clinical practice guideline for the pharmacologic treatment of chronic insomnia in adults: An American Academy of Sleep Medicine guideline. *Journal of Clinical Sleep Medicine*, 13(2), 307–349.
- U.S. Preventive Services Task Force. (2019). Interventions to prevent perinatal depression: U.S. Preventive Services Task Force recommendation statement. *JAMA*, 321(6), 580–587.
- World Health Organization, & International Labour Organization. (2022). Mental health at work: Policy brief. World Health Organization.
- World Health Organization. (2019). WHO guideline: Recommendations on digital interventions for health system strengthening. World Health Organization.
- World Health Organization. (2021). Violence against women prevalence estimates, 2018. World Health Organization.
- World Health Organization. (2022). International classification of diseases, 11th revision (ICD-11). World Health Organization.
- World Health Organization. (2022). World mental health report: Transforming mental health for all. World Health Organization.
- World Health Organization. (2022, June 17). Mental health: Strengthening our response. World Health Organization.
- World Health Organization. (2023). Mental Health Gap Action Programme (mhGAP) guideline for mental, neurological and substance use disorders (3rd ed.). World Health Organization.
- World Health Organization. (2024). Clinical descriptions and diagnostic requirements for ICD-11 mental, behavioural and neurodevelopmental disorders (CDDR). World Health Organization.

L. Glosarium

Kesehatan mental: Keadaan sejahtera ketika seseorang menyadari potensinya, mampu mengelola stres yang wajar, bekerja secara produktif, dan berkontribusi pada komunitas. Pada perempuan dewasa, konsep ini mencakup kapasitas berdaya di tengah dinamika peran dan perubahan biologis, serta kemampuan merawat relasi dan makna hidup.

Pendekatan biopsikososial: Kerangka memahami kesehatan yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologis, dan sosial. Digunakan untuk menilai

dan menangani masalah kesehatan mental perempuan secara utuh, bukan hanya dari sisi gejala klinis.

Jendela kerentanan reproduksi: Periode dalam siklus kehidupan perempuan ketika risiko gangguan mood dan kecemasan meningkat akibat perubahan hormon, misalnya pra-menstruasi, perinatal, dan perimenopause. Fluktuasi estrogen dan progesteron pada fase ini memengaruhi neurotransmitter yang mengatur suasana hati dan tidur.

Perimenopause: Fase transisi menuju menopause yang ditandai fluktuasi hormon, gejala vasomotor, dan gangguan tidur. Perubahan fisiologis ini dapat meningkatkan kepekaan terhadap kecemasan, iritabilitas, dan perubahan mood.

Depresi pascapersalinan: Episode depresi yang terjadi setelah melahirkan dengan gejala sedih mendalam, rasa bersalah, gangguan tidur, dan kecemasan terhadap bayi. Berbeda dari baby blues yang ringan dan singkat, kondisi ini mengganggu fungsi sehari-hari dan memerlukan penanganan profesional.

Gangguan kecemasan menyeluruh (Generalized Anxiety Disorder/GAD): Kekhawatiran berlebihan dan menetap terhadap berbagai aspek kehidupan, sulit dikendalikan, disertai gejala fisik seperti tegang otot, mudah lelah, gangguan tidur, dan sulit konsentrasi. Sering memperburuk kualitas kerja dan relasi.

Gangguan panik: Kondisi dengan serangan panik berulang yang muncul tiba-tiba, ditandai jantung berdebar, sesak, pusing, rasa tidak nyata, dan takut mati. Antisipasi serangan berikutnya dapat memicu penghindaran aktivitas atau situasi tertentu.

Gangguan stres pascatrauma (Post-Traumatic Stress Disorder/PTSD): Kumpulan gejala setelah paparan peristiwa traumatis, berupa intrusi kenangan, mimpi buruk, kilas balik, penghindaran, perubahan kognisi dan suasana hati, serta hiperwaspada. Pada penyintas kekerasan berbasis gender, gejala kerap kompleks dan berlapis.

Gangguan makan: Kelompok kondisi yang mencakup anoreksia nervosa, bulimia nervosa, dan binge eating disorder, ditandai gangguan pola makan, citra tubuh, dan regulasi emosi. Dampaknya bisa serius pada status gizi, fungsi endokrin, kesehatan tulang, dan kesuburan.

Insomnia kronis: Kesulitan memulai tidur, mempertahankan tidur, atau bangun terlalu dini selama minimal tiga bulan dengan gangguan fungsi siang hari. Terkait erat dengan stres, kecemasan, perimenopause, dan ditangani efektif dengan terapi kognitif perilaku untuk insomnia.

Beban mental (mental load): Tugas kognitif tak terlihat untuk merencanakan, mengingat, dan mengoordinasikan pekerjaan rumah tangga serta pengasuhan. Ketimpangan beban mental berkontribusi pada kelelahan emosional dan stres berkepanjangan pada perempuan.

Presenteeism: Kondisi hadir di tempat kerja tetapi tidak berkinerja optimal akibat masalah kesehatan, termasuk gangguan mental. Dampaknya sering lebih besar daripada ketidakhadiran karena menurunkan produktivitas dan kualitas kolaborasi.

Pendekatan peka trauma (trauma-informed care): Cara pelayanan yang mengutamakan rasa aman, kepercayaan, pilihan, kolaborasi, dan pemberdayaan. Tujuannya menghindari pemicu ulang trauma serta menyesuaikan intervensi dengan pengalaman penyintas.

Aktivasi perilaku (behavioral activation): Strategi terapi yang memulihkan rutinitas dan meningkatkan keterlibatan pada aktivitas yang bermakna dan memberi rasa mampu. Efektif mengatasi penarikan diri dan anhedonia pada depresi.

Perawatan bertahap (stepped care): Model layanan yang memulai intervensi dengan intensitas paling sederhana dan efektif, lalu dinaikkan sesuai respons klinis. Bertujuan memperluas akses, efisiensi sumber daya, dan kesinambungan

CHAPTER 4

KESEHATAN MENTAL PEREMPUAN LANSIA

Dr. Subang Aini Nasution, M.Kes.

A. Pendahuluan/Prolog

Kesehatan mental perempuan lansia adalah tema yang semakin strategis seiring pergeseran demografi menuju masyarakat yang menua. Pada fase ini, kesehatan jiwa tidak bisa dipisahkan dari kualitas hidup, kemandirian, dan partisipasi sosial. Perempuan yang memasuki usia lanjut membawa sejarah kehidupan panjang, termasuk pengalaman biologis, peran sosial, dan peristiwa psikologis yang membentuk cara pandang diri, relasi, dan makna hidup. Jika aspek mental terabaikan, konsekuensinya meluas pada fungsi sehari-hari, kepatuhan terhadap terapi penyakit kronis, risiko jatuh, status gizi, hingga beban perawatan keluarga. Karena itu, memahami lanskap kesehatan mental perempuan lansia bukan sekadar isu klinis, melainkan kebutuhan masyarakat untuk memastikan penuaan yang sehat, bermartabat, dan inklusif.

Dari sisi biologis, penuaan membawa perubahan bertahap pada sistem saraf, endokrin, kardiovaskular, muskuloskeletal, dan imun. Pada perempuan, transisi pascamenopause ditandai penurunan estrogen yang berdampak pada kestabilan suasana hati, kualitas tidur, termoregulasi, dan persepsi nyeri. Penyakit kronis yang lebih sering muncul pada usia lanjut, seperti hipertensi, diabetes melitus, penyakit jantung, osteoarthritis, dan osteoporosis, dapat memperburuk ketidaknyamanan fisik dan menjadi pemicu gejala depresi atau kecemasan. Gangguan tidur, nyeri menetap, polifarmasi, serta penurunan penglihatan dan pendengaran ikut memengaruhi regulasi emosi dan kapasitas kognitif. Rangkaian perubahan ini menunjukkan keterhubungan erat tubuh dan pikiran, sehingga pendekatan terhadap kesehatan mental perlu menyertakan pengelolaan komorbid, optimasi tidur, manajemen nyeri, dan tinjauan obat yang aman bagi lansia.

Dari aspek psikologis, perempuan lansia sering berhadapan dengan perubahan identitas dan peran. Pensiun dari pekerjaan, berkurangnya peran pengasuhan ketika anak telah mandiri, serta kemungkinan kehilangan pasangan hidup dapat menimbulkan rasa kesepian, duka berkepanjangan, dan pertanyaan eksistensial mengenai makna hidup. Pengalaman masa lalu seperti kekerasan berbasis gender, kehilangan berulang, atau keterbatasan akses pendidikan dapat meninggalkan jejak psikologis yang baru tampak pada usia lanjut. Di sisi lain, banyak

perempuan lansia memiliki daya lenting yang kuat, kebijaksanaan, dan spiritualitas yang menjadi sumber coping positif. Dukungan untuk mengekspresikan duka secara sehat, memperkuat harga diri, dan menjaga kemandirian sehari-hari menjadi kunci pencegahan masalah mental yang lebih berat.

Dimensi sosial menambah kompleksitas. Perubahan struktur keluarga, urbanisasi, dan migrasi membuat sebagian perempuan lansia tinggal terpisah dari jejaring dukungan tradisional. Stigma usia, diskriminasi, dan anggapan bahwa keluhan emosional hanyalah "bagian normal dari tua" sering menunda pencarian pertolongan. Ketergantungan ekonomi, peran ganda sebagai pengasuh pasangan atau anggota keluarga lain, serta keterbatasan mobilitas mempersempit partisipasi sosial. Isolasi sosial yang berkepanjangan berhubungan dengan peningkatan risiko depresi, kecemasan, penurunan kognitif, bahkan mortalitas. Dalam konteks Indonesia, kekuatan nilai kebersamaan, komunitas keagamaan, posyandu lansia, dan kelompok senam atau arisan sebenarnya merupakan aset sosial penting yang bila diaktifkan dengan baik dapat menjadi pelindung kuat bagi kesehatan mental.

Akses terhadap layanan juga menjadi penentu. Tidak semua fasilitas kesehatan ramah lansia dan sensitif gender. Layanan kesehatan mental masih menghadapi hambatan stigma, kurangnya tenaga terlatih geriatri, serta rujukan yang belum terintegrasi dengan layanan penyakit kronis. Kesenjangan digital membuat sebagian perempuan lansia sulit memanfaatkan telekonsultasi atau aplikasi kesehatan, padahal teknologi dapat membantu skrining dini, pemantauan suasana hati, dan keterhubungan sosial. Intervensi yang efektif perlu menggabungkan pendekatan klinis, dukungan keluarga, serta komunitas, dengan bahasa yang mudah dipahami, waktu konsultasi yang cukup, dan lingkungan yang menghargai martabat lansia.

Pendekatan biopsikososial menjadi kerangka yang relevan untuk membaca keseluruhan persoalan. Komponen biologis mengarahkan pada pengendalian penyakit kronis, nutrisi seimbang, aktivitas fisik yang aman, dan kebersihan tidur. Komponen psikologis menekankan konseling, strategi coping, stimulasi kognitif, serta pemaknaan spiritual sesuai keyakinan individu. Komponen sosial mendorong penguatan jejaring, kegiatan intergenerasional, akses pada kegiatan komunitas, dan perlindungan dari kekerasan atau penelantaran. Ketiga komponen ini saling menguatkan jika dirancang secara terintegrasi, berkelanjutan, dan diukur dengan indikator yang jelas.

pentingnya kesehatan mental perempuan lansia terletak pada dampaknya yang luas terhadap keluarga dan masyarakat. Perempuan lansia yang sejahtera secara mental cenderung lebih aktif, lebih patuh pada pengobatan, dan lebih mampu menjadi sumber kebijaksanaan bagi generasi di bawahnya. Pendahuluan ini menegaskan bahwa perubahan biologis, psikologis, dan sosial pada usia lanjut harus

dipahami bukan sebagai ketidakberdayaan, melainkan sebagai fase kehidupan yang memerlukan penyesuaian, dukungan, dan kesempatan baru untuk tumbuh. Dengan komitmen lintas sektor, layanan yang ramah lansia, dan pemberdayaan komunitas, kesehatan mental perempuan lansia dapat dijaga sehingga mereka dapat menjalani hari tua dengan rasa aman, berarti, dan bermartabat.

B. Konsep Dasar Kesehatan Mental pada Lansia

Kesehatan mental pada lansia dipahami sebagai kondisi kesejahteraan dinamis ketika seseorang mampu mengenali potensi diri, mengelola tekanan hidup yang wajar, bekerja atau beraktivitas secara produktif sesuai kapasitasnya, serta berkontribusi bagi keluarga dan komunitas. Pada usia lanjut, definisi ini memerlukan penekanan khusus pada otonomi, martabat, makna hidup, kapasitas mengambil keputusan, dan keterhubungan sosial yang aman. Dengan kata lain, sehat secara mental pada lansia bukan semata tidak adanya gangguan jiwa, melainkan hadirnya kualitas emosi yang stabil, fungsi kognitif yang memadai untuk menjalani peran sehari-hari, hubungan yang suportif, serta rasa tujuan yang masih dirasakan relevan. Kerangka ini sejalan dengan pendekatan biopsikososial yang melihat pikiran, tubuh, dan lingkungan sebagai satu kesatuan yang saling memengaruhi sepanjang penuaan.

Indikator kesehatan jiwa pada lansia meliputi kombinasi tanda subjektif dan objektif. Indikator subjektif mencakup suasana hati yang relatif stabil, perasaan bermakna, optimisme realistis, rasa syukur, dan kemampuan menikmati kegiatan sederhana. Kualitas tidur yang baik, nafsu makan yang terjaga, kemampuan mengelola rasa sakit, serta pengalaman emosi positif yang lebih sering daripada emosi negatif menjadi penanda penting lainnya. Indikator objektif tampak pada fungsi kognitif dasar dan eksekutif yang sesuai dengan rentang normal penuaan, misalnya atensi, memori kerja, kelancaran berbahasa, fleksibilitas berpikir, dan kecepatan memproses informasi. Kemandirian dalam aktivitas harian seperti mandi, berpakaian, makan, berpindah, serta aktivitas instrumental seperti mengelola keuangan, menggunakan telepon, berbelanja, dan mengatur obat, juga merupakan indikator yang kuat. Partisipasi sosial yang memadai, kepatuhan terhadap pengobatan penyakit kronis, serta kemampuan meminta bantuan saat perlu, memperlihatkan kesehatan mental yang adaptif. Dalam praktik, indikator ini dapat dibantu pemantauannya melalui wawancara klinis, observasi keluarga, dan penggunaan alat skrining yang ramah lansia untuk gejala depresi, kecemasan, dan fungsi kognitif, selalu dengan mempertimbangkan konteks budaya dan bahasa.

Kondisi mental lansia berbeda dari kelompok usia lebih muda karena karakteristik penuaan biologis, paparan penyakit kronis, pengalaman kehilangan,

dan perubahan peran sosial. Pada lansia, keluhan emosional kerap hadir dalam bentuk somatik seperti nyeri, lelah berkepanjangan, sesak, atau gangguan tidur, sehingga depresi dan kecemasan sering tidak terdeteksi jika klinisi hanya mencari gejala emosi yang eksplisit. Penurunan fungsi kognitif ringan dapat terjadi sebagai bagian dari penuaan normal, misalnya pelupa ringan yang tidak mengganggu kemandirian, dan ini perlu dibedakan dari demensia yang progresif serta dari depresi yang dapat menyerupai gangguan kognitif. Polifarmasi dan interaksi obat lebih sering pada lansia sehingga efek samping psikotropika, antikolinergik, atau obat kardiometabolik dapat memengaruhi suasana hati, kejernihan pikir, dan tingkat kewaspadaan. Di sisi psikologis, lansia menghadapi tugas perkembangan yang khas seperti proses menerima kehilangan pasangan atau teman sebaya, menata ulang identitas pascapensiun, dan menegosiasikan makna hidup yang mungkin bergeser dari produktivitas ekonomi menuju kontribusi sosial dan spiritual. Secara sosial, isolasi dan kesepian dapat meningkat karena mobilitas yang berkurang atau anak bermigrasi, sementara pada banyak perempuan lansia terdapat risiko tambahan berupa kerentanan ekonomi, riwayat beban peran pengasuhan, dan usia harapan hidup yang lebih panjang sehingga lebih sering menjadi janda. Meskipun demikian, banyak lansia memiliki regulasi emosi yang lebih matang, fokus pada hubungan yang bermakna, dan kebijaksanaan yang menjadi modal penting bagi ketahanan mental. Memahami perbedaan ini membantu tenaga kesehatan, keluarga, dan komunitas menyusun strategi pencegahan, deteksi dini, dan intervensi yang lebih tepat sasaran, manusiawi, dan sensitif terhadap gender serta budaya.

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesehatan Mental Perempuan Lansia

Kesehatan mental perempuan lansia dibentuk oleh pertemuan berbagai faktor yang saling berkelindan. Pada tahap hidup ini, perubahan biologis, pengalaman psikologis, dinamika sosial, serta nilai budaya tidak hadir sebagai unsur yang berdiri sendiri, melainkan saling memengaruhi dan memperkuat. Pemahaman yang komprehensif perlu melihat bagaimana tubuh yang menua, peran sosial yang bergeser, dan makna hidup yang terus ditafsirkan ulang akan menentukan cara perempuan lansia merasakan emosi, berpikir, membuat keputusan, serta berelasi dengan orang lain. Dengan sudut pandang ini, setiap gejala emosional tidak cukup dijelaskan oleh satu penyebab, melainkan harus dibaca dalam konteks jaringan faktor yang kompleks.

Dari sisi biologis, transisi menuju dan setelah menopause membawa perubahan hormonal yang signifikan, terutama penurunan estrogen yang memengaruhi sistem pengatur emosi di otak. Fluktuasi ini berkaitan dengan perubahan suasana hati, iritabilitas, gangguan tidur, berdebar, dan sensasi panas

yang mengganggu kenyamanan harian. Gangguan tidur yang berulang menurunkan energi, memperburuk konsentrasi, dan membuat perempuan lansia lebih rentan terhadap kecemasan dan depresi. Perubahan pada fungsi seksual, misalnya kekeringan pada vagina dan nyeri saat berhubungan, dapat memengaruhi citra tubuh dan kedekatan emosional dengan pasangan. Di luar itu, proses penuaan membawa penurunan fungsi sensorik, berkurangnya massa otot, dan meningkatnya kepekaan terhadap nyeri, yang seluruhnya menambah beban stres fisiologis dan memengaruhi kestabilan emosi.

Penyakit kronis merupakan faktor biologis lain yang sangat menentukan. Hipertensi, diabetes melitus, penyakit jantung, penyakit sendi, gangguan pernapasan, hingga gangguan tiroid adalah kondisi yang sering menyertai usia lanjut. Nyeri yang menetap, pembatasan gerak, kelelahan berkepanjangan, dan kunjungan medis yang berulang menciptakan tekanan psikologis yang tidak kecil. Polifarmasi meningkatkan kemungkinan efek samping obat terhadap suasana hati, kejernihan pikir, dan kualitas tidur. Penurunan penglihatan atau pendengaran dapat menghadirkan rasa terputus dari lingkungan, sementara inkontinensia dan kekhawatiran akan jatuh menurunkan kepercayaan diri dan dorongan untuk bersosialisasi. Kombinasi penyakit kronis, efek samping obat, dan keterbatasan fisik ini berkontribusi pada gejala emosional yang kerap tersamarkan sebagai keluhan somatik.

Pada ranah psikologis, perempuan lansia menghadapi spektrum stres yang khas. Perubahan peran setelah pensiun, berkurangnya tanggung jawab pengasuhan langsung, atau justru bertambahnya peran sebagai pengasuh pasangan sakit dan cucu, dapat memunculkan kelelahan emosional. Kehilangan pasangan hidup atau teman sebaya menuntut proses berduka yang tidak selalu mudah, terutama bila duka berkepanjangan tidak memperoleh ruang ekspresi yang aman. Gaya pikir yang cenderung meremehkan diri, kebiasaan mengkhawatirkan masa depan, atau kecenderungan merenung terus menerus menjadi tanah subur bagi kecemasan dan depresi. Di sisi lain, modal psikologis seperti kemampuan menerima kondisi, rasa syukur, humor, dan spiritualitas menjadi sumber ketahanan yang membantu mengubah pengalaman sulit menjadi peluang untuk menemukan makna baru.

Kecemasan dan depresi pada perempuan lansia sering tampil dalam rupa yang berbeda dibanding kelompok usia lebih muda. Keluhan dapat didominasi oleh gangguan tidur, nyeri tanpa sebab yang jelas, kelesuan, atau penurunan nafsu makan, sementara ekspresi sedih yang gamblang justru tidak menonjol. Bentuk presentasi seperti ini berisiko tidak dikenali, terutama bila keluarga dan tenaga kesehatan menganggapnya bagian wajar dari penuaan. Padahal, deteksi dini dan dukungan psikologis yang tepat dapat mencegah penurunan fungsi lebih jauh,

memperbaiki kepatuhan terhadap pengobatan penyakit kronis, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

Dimensi sosial memegang peran besar sebagai pelindung atau justru pencetus masalah. Dukungan keluarga yang hangat, komunikasi yang menghargai otonomi lansia, serta kesempatan untuk tetap berperan dalam keluarga dan komunitas terbukti memperkuat kesehatan mental. Namun dukungan yang lemah, konflik antargenerasi, dan keterasingan dapat menimbulkan kesepian yang berlarut. Kesepian bukan sekadar ketiadaan orang di sekitar, melainkan perasaan tidak terhubung secara emosional, yang berdampak pada peningkatan gejala depresi, kecemasan, dan penurunan fungsi kognitif. Hambatan mobilitas, transportasi umum yang kurang ramah, dan lingkungan fisik yang tidak mendukung membuat lansia enggan keluar rumah, mempersempit jejaring sosial dan menambah risiko isolasi.

Kondisi ekonomi dan jaring pengaman sosial memperkuat atau melemahkan daya tahan mental. Keterbatasan pendapatan, bergantung pada keluarga, atau tidak adanya jaminan kesehatan yang memadai bisa menimbulkan rasa tidak aman dan menggerus harga diri. Perempuan lansia yang tinggal sendiri berisiko lebih tinggi mengalami kesepian, sementara yang tinggal bersama keluarga belum tentu terlindungi bila suaranya tidak didengar dalam pengambilan keputusan. Akses pada kegiatan komunitas seperti posyandu lansia, kelompok olahraga ringan, pengajian, atau arisan dapat mengembalikan rasa memiliki dan tujuan hidup, asalkan kegiatan itu dirancang inklusif, aman, dan memberi ruang kontribusi.

Budaya membentuk cara perempuan lansia memahami tubuh, emosi, dan pencarian pertolongan. Norma yang menilai keluhan emosional sebagai tanda kelemahan dapat menahan mereka untuk bercerita, sehingga gejala lebih sering diungkap melalui keluhan fisik. Nilai tentang bakti kepada orang tua, gotong royong, dan komunitas keagamaan dapat menjadi sumber dukungan sosial dan spiritual yang kuat, membantu proses penerimaan dan pemaknaan hidup. Di sisi lain, tabu mengenai seksualitas perempuan usia lanjut dapat menutup pembahasan tentang perubahan fungsi seksual dan dampaknya pada hubungan dengan pasangan, padahal isu ini berpengaruh nyata terhadap harga diri dan suasana hati. Sensitivitas budaya diperlukan agar dukungan psikososial tidak memaksa, tetapi menguatkan, serta memadukan ilmu kesehatan dengan keyakinan dan praktik lokal yang bermanfaat.

Semua faktor ini memiliki sifat saling memengaruhi. Gangguan tidur akibat gejala menopause memperburuk toleransi terhadap stres, lalu memperbesar kecenderungan menarik diri dari pergaulan, yang pada akhirnya memicu kesepian. Penyakit kronis membatasi aktivitas dan mengurangi kesempatan bertemu orang lain, memperberat gejala depresi, yang kemudian menurunkan motivasi untuk

berobat dan melakukan aktivitas fisik. Sebaliknya, dukungan keluarga yang hangat, lingkungan yang inklusif, dan aktivitas bermakna di komunitas dapat memoderasi dampak perubahan biologis serta menambah ketahanan psikologis. Dengan memahami jejaring pengaruh ini, intervensi dapat dirancang secara menyeluruh, menghormati martabat perempuan lansia, dan menyatukan pendekatan medis, psikologis, sosial, serta budaya agar kesehatan mental terjaga dan kualitas hidup pada usia lanjut semakin baik.

D. Masalah Umum Kesehatan Mental pada Perempuan Lansia

Masalah kesehatan mental pada perempuan lansia kerap hadir sebagai kumpulan gejala yang saling bertumpang tindih dan berubah sepanjang waktu. Pada fase ini, keluhan emosional jarang berdiri sendiri. Mereka berjaln dengan kondisi fisik, perubahan peran sosial, pengalaman kehilangan, serta cara perempuan lansia memaknai hidup. Gambaran klinis sering kali tidak khas. Gejala muncul sebagai keluhan nyeri, lelah berkepanjangan, pusing, gangguan tidur, atau menurunnya selera makan. Ketika gejala seperti ini dianggap sekadar konsekuensi penuaan, proses pencarian pertolongan menjadi tertunda. Padahal, deteksi dini dan penanganan yang tepat mampu mencegah penurunan fungsi, menekan beban keluarga, dan meningkatkan kualitas hidup.

Depresi merupakan salah satu masalah tersering. Pada perempuan lansia, depresi sering tersamar di balik keluhan fisik atau perilaku menarik diri yang dipandang wajar karena usia. Faktor pencetus meliputi kehilangan pasangan hidup, berkurangnya peran sosial, penyakit kronis yang menahun, dan rasa tidak berdaya menghadapi penurunan fisik. Berbeda dari duka yang normal dan berproses, depresi ditandai suasana hati muram yang menetap, hilangnya minat pada aktivitas yang dahulu menyenangkan, rasa tidak bernilai, gangguan tidur dan nafsu makan, serta penurunan energi yang mengganggu fungsi sehari-hari. Depresi pada lansia berisiko luput dikenali karena ekspresi sedih yang tidak selalu menonjol. Tanda yang lebih tampak adalah kelambanan gerak, keluhan nyeri, kebingungan ringan, atau penurunan motivasi merawat diri. Penanganan yang manusiawi menempatkan perempuan lansia sebagai pengambil keputusan terhadap hidupnya sendiri, dengan dukungan konseling, aktivasi sosial yang bermakna, penatalaksanaan penyakit fisik, serta penggunaan obat antidepresan secara hati-hati bila memang diperlukan.

Kecemasan atau ansietas juga sering mewarnai hari-hari perempuan lansia. Kekhawatiran tentang kesehatan, ketakutan akan jatuh, beban peran sebagai pengasuh pasangan atau cucu, hingga rasa tidak aman terkait keuangan dapat memicu kewaspadaan berlebihan, gelisah, tegang otot, gangguan tidur, dan kesulitan berkonsentrasi. Pada sebagian orang, kecemasan hadir sebagai serangan

panik dengan berdebar, sesak, atau rasa akan pingsan yang menakutkan. Kecemasan yang berkepanjangan memperburuk nyeri, mempercepat kelelahan, dan mendorong perilaku menghindar yang mempersempit ruang gerak sosial. Intervensi yang efektif menekankan keterampilan mengelola napas dan pikiran yang mengganggu, penataan rutinitas harian yang memberi rasa kendali, serta pendampingan keluarga agar tidak sekadar menenangkan, tetapi juga memfasilitasi kemandirian. Penggunaan obat penenang jangka panjang perlu dihindari karena risiko kantuk siang hari, kebingungan, hingga jatuh.

Demensia adalah gangguan neurokognitif yang progresif, ditandai penurunan memori dan satu atau lebih domain kognitif lain seperti bahasa, fungsi eksekutif, visuospasial, atau perhatian, hingga mengganggu kemandirian aktivitas harian. Perempuan memiliki harapan hidup lebih panjang sehingga lebih sering menghadapi demensia, terutama tipe Alzheimer dan vaskular. Pada tahap awal, perbedaan antara pelupa normal dan gangguan kognitif ringan bisa samar. Tanda peringatan termasuk mengulangi pertanyaan yang sama, tersesat di lingkungan akrab, kesulitan mengelola keuangan, atau bingung saat mengikuti instruksi sederhana. Di luar aspek kognitif, demensia kerap disertai gejala perilaku dan psikologis seperti apati, mudah marah, delusi, halusinasi, gelisah menjelang sore, dan pola tidur terbalik yang membebani pengasuh. Penatalaksanaan memerlukan pendekatan bertahap. Pastikan faktor yang dapat dibalik diperiksa, seperti depresi, gangguan tiroid, defisiensi vitamin, efek obat, infeksi, gangguan penglihatan atau pendengaran. Lingkungan yang akrab, rutinitas yang stabil, komunikasi sederhana yang penuh empati, serta dukungan bagi pengasuh adalah pilar utama.

Gangguan tidur menjadi masalah lintas diagnosis yang memperburuk suasana hati dan daya pikir. Perempuan lansia mengalami perubahan ritme sirkadian yang cenderung tidur lebih awal dan bangun lebih pagi, disertai tidur yang dangkal dan mudah terbangun. Keluhan hot flush pascamenopause, nyeri sendi, nokturia, refluks asam lambung, sleep apnea, dan kaki gelisah dapat memecah tidur malam berulang. Ketika tidur tidak pulih, kelelahan siang hari meningkat, toleransi terhadap stres menurun, dan perhatian mudah goyah. Siklus ini memperparah depresi dan kecemasan, sementara sedatif yang tidak terantau justru menambah risiko jatuh dan kebingungan. Perbaikan tidur perlu bertumpu pada kebiasaan sehat seperti konsistensi jadwal tidur, pencahayaan pagi untuk menata ulang jam biologis, aktivitas fisik ringan yang rutin, pembatasan kafein sore, serta pengelolaan nyeri dan nokturia. Evaluasi kemungkinan sleep apnea penting bila terdapat mendengkur keras atau kantuk berat di siang hari.

Di atas seluruh spektrum gangguan, stigma dan diskriminasi usia memainkan peran sunyi yang sering tidak disadari. Banyak perempuan lansia tumbuh dalam

budaya yang menilai keluhan emosional sebagai kelemahan sehingga mereka belajar diam. Labelisasi bahwa gangguan ingatan adalah bagian wajar dari tua membuat keluarga menormalisasi penurunan fungsi yang sebenarnya dapat ditangani. Ageisme di layanan kesehatan terwujud dalam konsultasi yang singkat, bahasa yang terlalu teknis, atau keputusan yang tidak melibatkan lansia sebagai subjek. Akibatnya, perempuan lansia menunda mencari bantuan dan datang dalam kondisi lebih berat. Mengikis stigma memerlukan perubahan cara pandang kolektif. Keluarga dan tenaga kesehatan perlu menghargai pengalaman hidup lansia, menggunakan bahasa yang ramah, mengundang partisipasi dalam keputusan klinis, serta menyampaikan bahwa depresi, kecemasan, demensia, dan gangguan tidur adalah kondisi medis yang bisa dinilai dan ditangani, bukan hukuman karena menua.

Konteks sosial dan budaya Indonesia memberi tantangan sekaligus peluang. Ikatan keluarga besar, komunitas keagamaan, posyandu lansia, dan kelompok sosial adalah aset yang dapat memperkuat resiliensi bila dirancang inklusif. Pengajian, arisan, senam lansia, kerja bakti, atau kelas keterampilan sederhana mengembalikan rasa memiliki dan tujuan. Di saat yang sama, norma yang membatasi pembicaraan tentang emosi, duka, dan seksualitas pada usia lanjut membuat isu penting tidak mendapat ruang. Perempuan lansia mungkin menyimpan rasa kehilangan, kesepian, atau gangguan fungsi seksual tanpa bisa mengungkapkannya. Pendekatan yang peka budaya membuka percakapan ini dengan hormat, mengaitkannya pada nilai keluarga, rasa syukur, dan ibadah, serta menekankan bahwa merawat kesehatan mental adalah bagian dari amanah menjaga diri.

Relasi antara masalah yang satu dengan yang lain bersifat timbal balik. Depresi mengganggu tidur dan mempercepat penurunan kognitif. Kecemasan memperbesar kewaspadaan terhadap sensasi tubuh dan memperbanyak kunjungan darurat yang melelahkan. Demensia menimbulkan perubahan perilaku yang memancing stres pengasuh sehingga suasana rumah menjadi tegang. Gangguan tidur memperburuk semua kondisi di atas. Menyadari jejaring ini membantu menyusun rencana penanganan yang tidak fragmentaris. Penilaian menyeluruh mencakup kondisi fisik, obat yang dikonsumsi, dukungan keluarga, aktivitas harian, dan makna hidup yang dirasakan. Intervensi berjalan paling baik ketika klinis, psikologis, dan sosial disatukan, misalnya menata nyeri dan penyakit kronis, mengajarkan keterampilan koping, mengaktifkan kelompok sebaya, serta menghubungkan keluarga dengan sumber daya komunitas.

E. Peran Keluarga dan Lingkungan Sosial

Keseimbangan mental perempuan lansia sangat dipengaruhi oleh iklim emosional di rumah dan kualitas keterhubungan dengan lingkungan sosial di

sekitarnya. Keluarga yang hangat dan menghargai martabat lansia membantu menjaga rasa aman, rasa memiliki, dan harga diri. Dukungan semacam ini tidak hanya berbentuk pengasuhan fisik, melainkan hadir dalam percakapan yang penuh empati, kesediaan mendengar tanpa menghakimi, serta pengakuan bahwa lansia tetap memiliki suara dan pilihan atas hidupnya. Ketika perempuan lansia diperlakukan sebagai mitra dalam pengambilan keputusan, mereka merasa dihargai, lebih tenang, dan lebih termotivasi untuk mempertahankan kebiasaan sehat serta mengikuti pengobatan penyakit kronis.

Dukungan keluarga yang efektif bekerja melalui beberapa saluran yang saling menguatkan. Dukungan emosional menyediakan ruang aman untuk mengekspresikan duka, marah, atau cemas, sementara dukungan informasional membantu lansia memahami diagnosis, pilihan terapi, dan cara mengelola gejala. Dukungan instrumental memastikan kebutuhan sehari-hari terpenuhi dengan tetap menjaga otonomi, misalnya memberikan bantuan pada tugas yang berat tanpa merebut tugas yang masih mampu dilakukan sendiri. Bentuk validasi sederhana seperti mengucapkan terima kasih atas masakan, meminta saran dalam urusan keluarga, atau mengingat bersama kenangan yang indah, dapat memperkuat perasaan bermakna dan mencegah rasa tersisih.

Keseimbangan antara perlindungan dan kemandirian merupakan kunci. Overproteksi yang membuat lansia tidak diberi kesempatan mengambil keputusan atau melakukan aktivitas ringan dapat menumbuhkan rasa tidak berdaya dan mempercepat ketergantungan. Sebaliknya, dukungan yang memampukan berfokus pada pendampingan, penyesuaian lingkungan, dan pemberian alat bantu agar lansia tetap dapat berpartisipasi. Pengaturan rumah yang ramah lansia, seperti pencahayaan yang cukup, penataan jalur berjalan yang aman, pengingat obat yang jelas, dan sudut baca yang tenang, mampu menurunkan kecemasan dan meningkatkan rasa kendali. Rutin harian yang disepakati bersama membantu menstabilkan ritme tidur bangun, mengurangi kebingungan pada lansia dengan gangguan kognitif, serta memberi struktur yang menenangkan bagi seluruh keluarga.

Perubahan peran keluarga sering menimbulkan ketegangan yang tidak disadari. Anak dewasa bisa berada pada posisi sandwich, yaitu mengasuh orang tua sekaligus membesarkan anak, sehingga rentan kelelahan emosional. Kelelahan pengasuh berdampak langsung pada lansia karena menurunkan kualitas komunikasi dan meningkatkan konflik kecil yang berulang. Keluarga memerlukan koreografi kerja sama yang adil, pembagian tugas yang realistis, dan waktu istirahat yang terjadwal. Akses pada layanan jeda perawatan, kelompok dukungan pengasuh, serta konsultasi dengan tenaga kesehatan untuk menyederhanakan regimen obat dan

kontrol penyakit kronis, dapat menurunkan beban dan memperbaiki suasana rumah. Ketika pengasuh merasa didengar, interaksi menjadi lebih lembut dan lansia lebih mudah merasakan ketenangan.

Kehilangan pasangan atau teman sebaya merupakan pengalaman yang sering dialami perempuan lansia dan dapat mengguncang keseimbangan mental. Keluarga membantu proses berduka dengan memberi ruang bercerita, melakukan ritual mengenang yang bermakna, dan menghindari dorongan untuk cepat melupakan. Praktik peninjauan hidup melalui album foto, menulis memoar singkat, atau menceritakan kembali kisah keluarga, bukan sekadar nostalgia. Kegiatan ini membantu integrasi pengalaman senang dan sedih, memperkuat identitas diri, serta menumbuhkan rasa syukur yang menjadi benteng terhadap depresi. Dengan cara ini, keluarga menjadi wadah pemulihan yang menegaskan bahwa hidup tetap memiliki arah meski mengalami kehilangan.

Lingkungan sosial di luar rumah tidak kalah penting dalam membentuk ketahanan mental. Komunitas yang inklusif memberikan peluang bagi perempuan lansia untuk tetap berperan dan merasa dibutuhkan. Posyandu lansia, Posbindu Penyakit Tidak Menular, kelompok senam ringan, pengajian, arisan, maupun kelas keterampilan sederhana menyediakan ruang pertemuan rutin yang memelihara jejaring pertemanan. Interaksi yang terjadwal membantu mengurai kesepian, memperbaiki suasana hati, dan menstimulasi kognisi melalui percakapan serta aktivitas bersama. Kehadiran kader kesehatan, tokoh masyarakat, dan pemuka agama yang peka lansia memperkuat jembatan antara layanan kesehatan formal dan kebutuhan nyata di lapangan.

Konsep gotong royong memiliki dampak nyata ketika diterjemahkan ke dalam program komunitas yang berkelanjutan. Inisiatif seperti kunjungan rumah terjadwal untuk lansia yang tinggal sendiri, bank waktu untuk saling membantu belanja atau ke puskesmas, hingga kegiatan lintas generasi seperti membaca bersama cucu atau berkebun di lahan kecil, membangun kohesi sosial yang menenangkan. Kegiatan bersama yang terstruktur mengaktifkan rasa memiliki, memberi ritme pada minggu, dan mengurangi fokus berlebihan pada keluhan fisik. Ketika komunitas menyediakan peran kecil namun konsisten, perempuan lansia memperoleh pengalaman kompeten dan berguna, yang berdampak pada peningkatan harga diri dan harapan.

Teknologi dapat menjadi penghubung baru antara keluarga, lansia, dan komunitas, asalkan kesenjangan digital diatasi dengan sabar. Grup pesan singkat keluarga memungkinkan pembaruan kabar harian, pengingat obat, dan koordinasi kunjungan. Telekonsultasi menurunkan hambatan akses untuk memantau mood, tidur, dan keluhan fisik, sementara panggilan video menghadirkan kembali wajah-

wajah yang dirindukan. Namun pendampingan literasi digital perlu dilakukan agar lansia tidak terpapar hoaks atau penipuan. Peran cucu sebagai mentor digital sering berhasil karena suasana belajar terasa akrab dan menyenangkan, sekaligus mempererat relasi antargenerasi.

Budaya setempat membingkai cara keluarga dan komunitas memaknai penuaan. Nilai bakti kepada orang tua, penghormatan kepada perempuan sepuh, dan kehadiran ruang ibadah dapat menjadi sumber daya spiritual yang memperkuat ketahanan. Di saat yang sama, norma yang menganggap keluhan emosional sebagai kelemahan perlu ditinjau ulang. Membuka percakapan tentang kesepian, kecemasan, atau berduka tanpa rasa malu adalah langkah penting untuk mencegah masalah menjadi berat. Tenaga kesehatan dan tokoh komunitas dapat mencontohkan bahasa yang ramah dan tidak menghakimi, sehingga lansia merasa aman meminta bantuan ketika dibutuhkan.

Pencegahan stigma dan diskriminasi usia merupakan prasyarat agar dukungan keluarga dan komunitas bekerja optimal. Sikap meremehkan, bercanda yang merendahkan, atau kebiasaan mengambil alih pembicaraan atas nama lansia mengikis martabat dan memicu penarikan diri. Sebaliknya, menyapa dengan nama, menatap mata, duduk sejajar, serta menunggu jawaban tanpa memotong, mengirim pesan kuat bahwa suara lansia dihormati. Ketika keluarga dan komunitas konsisten dengan praktik kecil yang penuh hormat seperti ini, rasa percaya diri tumbuh dan keseimbangan mental lebih mudah dijaga.

F. Strategi Pencegahan dan Promosi Kesehatan Mental Lansia

Upaya pencegahan dan promosi kesehatan mental pada perempuan lansia yang efektif selalu bertolak dari pandangan bahwa penuaan adalah proses yang wajar dan berharga. Program yang baik tidak sekadar menekan gejala, melainkan membangun rasa aman, otonomi, dan makna hidup. Strategi ini berlangsung di tiga arena yang saling berhubungan. Arena keluarga menjadi ruang kedekatan emosional dan pemulihan harian. Arena fasilitas kesehatan memastikan deteksi dini, tata laksana yang manusiawi, dan rujukan yang tepat. Arena komunitas menjaga keterhubungan sosial, peluang berperan, dan ritme aktivitas yang menyehatkan. Ketiganya berjalan serempak agar perempuan lansia tidak merasa sendirian menghadapi perubahan tubuh, peran sosial, dan pengalaman duka.

Intervensi berbasis komunitas memegang kunci karena kesepian dan penarikan diri adalah pintu masuk banyak masalah psikologis pada usia lanjut. Kegiatan terjadwal seperti posyandu lansia, kelompok senam ringan, kebun bersama, atau kelas keterampilan sederhana menghadirkan struktur yang menenangkan dan memberi kesempatan untuk saling menyapa. Percakapan yang

muncul dari aktivitas bersama menstimulasi daya pikir, menguatkan identitas, dan mengalihkan perhatian dari keluhan fisik yang berulang. Komunitas juga dapat menumbuhkan jejaring peduli yang konkret, misalnya jadwal kunjungan bergilir untuk lansia yang tinggal sendiri, pendampingan saat kontrol ke fasilitas kesehatan, atau bank waktu untuk membantu berbelanja dan mengurus administrasi. Praktik mudah seperti itu mengembalikan rasa memiliki dan berguna, dua unsur yang sangat melindungi kesehatan mental.

Pusat kesehatan masyarakat, kader, dan tokoh komunitas berperan sebagai penghubung antara layanan profesional dan kebutuhan nyata di lapangan. Mereka dapat mengadakan sesi literasi kesehatan mental dengan bahasa yang akrab, membahas tanda dini depresi, kecemasan, dan gangguan tidur tanpa stigma, sekaligus melatih cara menolong yang aman. Pendekatan peka budaya menjadi penting. Di banyak lingkungan, ekspresi emosi dianggap tabu. Mengaitkan perawatan diri dengan nilai keluarga, ibadah, dan syukur membuat pesan promotif lebih mudah diterima. Kegiatan lintas generasi, seperti membaca bersama cucu atau proyek kecil kewirausahaan keluarga, mempererat hubungan dan memperluas sumber dukungan sehingga lansia tidak terkunci dalam perasaan sendiri.

Tenaga kesehatan di lini pertama memegang peran sentral dalam deteksi dini dan pencegahan sekunder. Setiap kunjungan untuk penyakit fisik dapat dimanfaatkan untuk menanyakan suasana hati, kualitas tidur, selera makan, nyeri yang menetap, serta perubahan minat pada aktivitas harian. Skrining singkat untuk gejala depresi, kecemasan, dan fungsi kognitif membantu memilah siapa yang cukup dibantu dengan konseling dan aktivasi sosial, dan siapa yang perlu rujukan ke layanan khusus. Peninjauan obat perlu dilakukan rutin karena interaksi obat dan efek samping sering memengaruhi kejernihan pikir, tidur, dan kestabilan emosi. Tenaga kesehatan juga menguatkan pilar gaya hidup sehat yang berpengaruh besar pada mood dan daya pikir, seperti aktivitas fisik terukur, pola makan seimbang, paparan cahaya pagi, hobi kreatif, dan kebersihan tidur.

Dalam praktik klinis, pendekatan bertahap bermanfaat agar intervensi sesuai kebutuhan. Pada tingkat paling dasar, konseling singkat yang menghormati martabat lansia, teknik pernapasan untuk meredakan cemas, dan perencanaan aktivitas harian yang realistis sudah dapat memperbaiki kesejahteraan. Bila gejala menetap, intervensi psikologis terstruktur seperti edukasi tentang pikiran dan perasaan, pelatihan memecahkan masalah, atau terapi tinjauan hidup yang mengajak lansia menyusun kembali kisah diri secara utuh, terbukti memperkuat ketahanan. Penggunaan obat untuk depresi atau kecemasan dipertimbangkan hati-hati, dengan pemantauan ketat atas efek samping dan selalu diiringi strategi non farmakologis agar manfaatnya berjangka panjang.

Pencegahan primer berjalan melalui penataan lingkungan yang memungkinkan. Rumah yang terang, rapi, dan aman menurunkan rasa cemas dan risiko jatuh. Peningkat obat yang jelas, rutinitas makan dan tidur yang konsisten, serta sudut baca atau ibadah yang nyaman mengirim sinyal pada tubuh dan pikiran bahwa hari dapat dikendalikan. Di tingkat wilayah, ruang publik yang ramah lansia, jalur pejalan kaki yang aman, serta transportasi yang dapat diandalkan mengundang lansia keluar rumah untuk berinteraksi. Saat akses fisik membaik, suasana hati dan rasa percaya diri ikut terangkat, sementara kecenderungan menarik diri berkurang.

Teknologi dapat menjadi alat bantu yang kuat jika kesenjangan literasi digital dijembatani dengan sabar. Telekonsultasi memudahkan kontrol tanpa harus keluar rumah, aplikasi pengingat obat membantu keteraturan, dan panggilan video menghadirkan kembali wajah keluarga yang jauh. Grup pesan singkat keluarga mempermudah koordinasi dan memberi ruang berbagi kabar harian. Agar aman, keluarga perlu mendampingi penggunaan gawai dan mengajarkan tanda bahaya penipuan digital. Menjadikan cucu sebagai mentor digital sering berhasil karena suasana belajar menjadi hangat dan menyenangkan, sekaligus memperkuat kedekatan antargenerasi yang sangat baik bagi kesehatan mental.

Promosi kesehatan mental juga menyasar pengasuh, karena kesejahteraan pengasuh dan lansia saling memantul. Keluarga yang merawat memerlukan pengetahuan yang jelas mengenai penyakit yang dihadapi lansia, cara berkomunikasi yang menenangkan, dan teknik mengatur ulang harapan agar tidak kelelahan. Akses ke kelompok dukungan pengasuh dan jeda perawatan berkala menurunkan ketegangan rumah tangga dan mencegah ledakan konflik kecil yang mengikis harga diri lansia. Ketika pengasuh merasa didukung, interaksi menjadi lebih lembut, keputusan klinis lebih mudah dijalankan, dan lansia merasakan suasana yang aman untuk pulih.

Upaya preventif tidak lengkap tanpa penguatan spiritual dan makna hidup. Banyak perempuan lansia menemukan ketenangan melalui doa, meditasi, dan perenungan atas perjalanan hidup. Tenaga kesehatan dan komunitas dapat memfasilitasi kegiatan yang memberi ruang pada ekspresi duka, syukur, dan harapan, misalnya menulis memoar singkat, membuat album keluarga, atau ritual mengenang yang sederhana. Aktivitas ini bukan sekadar nostalgia. Ia membantu integrasi pengalaman senang dan sulit, memperkuat identitas diri, dan membangun jembatan dari masa lalu ke masa kini sehingga masa depan terasa lebih dapat diprediksi.

Agar semua strategi berjalan konsisten, pemantauan sederhana namun teratur perlu dilakukan. Indikator yang mudah dipahami oleh lansia dan keluarga seperti kualitas tidur, frekuensi ikut kegiatan sosial, selera makan, kerapian rumah, dan

kemauan berobat dapat menjadi penanda perubahan yang bermakna. Fasilitas kesehatan bersama kader dan tokoh lokal dapat meninjau hasil setiap beberapa bulan untuk menyesuaikan rencana. Pendekatan ini menumbuhkan rasa memiliki atas proses perawatan, karena lansia melihat sendiri kemajuan yang terjadi dari hari ke hari.

Inti dari pencegahan dan promosi kesehatan mental pada perempuan lansia adalah kemitraan yang menghormati. Program apa pun nilainya ditentukan oleh seberapa jauh ia memulihkan kendali kepada lansia atas tubuh dan kehidupannya. Ketika keluarga memberi tempat bagi suara lansia, ketika tenaga kesehatan menyediakan waktu untuk mendengar dan menjelaskan, dan ketika komunitas membuka ruang peran yang bermakna, kesehatan mental tidak lagi bergantung pada obat atau kunjungan sesekali. Ia tumbuh dari kebiasaan manusiawi yang diulang setiap hari. Dengan ekosistem seperti ini, perempuan lansia lebih siap menghadapi perubahan, lebih kuat bertahan dari guncangan, dan lebih bebas menikmati hari tua dengan rasa aman, bermakna, dan bermartabat.

G. Intervensi dan Pendekatan dalam Menangani Gangguan Mental Lansia

Penanganan gangguan mental pada perempuan lansia paling efektif bila dimulai dari asesmen komprehensif dan dilanjutkan dengan rencana perawatan yang disusun bersama, berpusat pada orang, dan sensitif terhadap konteks keluarga serta budaya. Asesmen yang baik tidak hanya menilai gejala emosional, tetapi juga menelusuri penyakit fisik yang menyertai, pola tidur, nyeri kronis, status gizi, fungsi penglihatan dan pendengaran, riwayat obat yang dikonsumsi, serta perubahan peran sosial dan peristiwa hidup seperti kehilangan pasangan. Pada tahap ini tenaga kesehatan perlu peka terhadap tanda bahaya seperti pikiran untuk bunuh diri, kebingungan akut, gejala psikotik, kekerasan atau penelantaran, karena kondisi tersebut memerlukan penanganan segera. Setelah gambaran menyeluruh diperoleh, tujuan jangka pendek dan jangka panjang dirumuskan bersama lansia dan keluarga, dengan ukuran keberhasilan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari, misalnya tidur lebih nyenyak, kembali mengikuti kegiatan komunitas, atau membaiknya nafsu makan.

Strategi manajemen terbaik mengikuti prinsip “perawatan bertahap”: mulai dari intervensi yang paling aman dan sederhana, kemudian ditingkatkan bila respons kurang memadai. Edukasi psikologis menjadi fondasi di semua tingkat. Perempuan lansia dan keluarga diajak memahami bahwa depresi, kecemasan, gangguan tidur, dan penurunan kognitif bukan “konsekuensi wajar menua” yang harus diterima begitu saja, melainkan kondisi yang bisa dinilai dan dikelola. Informasi diberikan dengan bahasa yang jelas dan empatik, disertai rencana harian

yang realistis seperti penataan rutinitas tidur, jadwal aktivitas yang memberi rasa makna, teknik relaksasi napas, dan strategi mengelola nyeri. Pendekatan ini mengembalikan rasa kendali kepada lansia dan menurunkan kecemasan yang sering memperberat gejala.

Terapi psikologis memainkan peran sentral karena aman, efektif, dan dapat disesuaikan dengan kapasitas kognitif. Terapi Perilaku Kognitif (Cognitive Behavioral Therapy) untuk depresi dan kecemasan dapat diadaptasi dengan tempo lebih lambat, penggunaan contoh konkret, lembar kerja bergambar, dan bantuan anggota keluarga untuk mengingat tugas rumah. Aktivasi perilaku, yaitu menata kembali kegiatan harian yang bermakna dan menyenangkan, terbukti mengangkat suasana hati serta memutus lingkaran menarik diri. Terapi Pemecahan Masalah membantu lansia memetakan satu demi satu persoalan nyata, misalnya pengelolaan keuangan, kunjungan ke fasilitas kesehatan, atau komunikasi dengan anggota keluarga, agar terasa terurai dan dapat ditindaklanjuti. Pada mereka yang berduka, Terapi Interpersonal bermanfaat untuk memproses perubahan peran dan memperkuat jejaring dukungan. Tinjauan hidup dan terapi kenangan menghadirkan kembali kisah diri secara utuh, mencakup keberhasilan, kegagalan, dan pelajaran, yang menegaskan identitas serta menumbuhkan rasa syukur. Untuk gangguan tidur, Terapi Perilaku Kognitif untuk Insomnia menggabungkan edukasi kebersihan tidur, pengaturan rangsang, dan teknik kognitif sehingga kualitas tidur pulih tanpa ketergantungan obat penenang.

Konseling yang efektif bersandar pada komunikasi terapeutik yang menghormati otonomi dan martabat lansia. Tenaga kesehatan mendengarkan aktif, memvalidasi perasaan, dan menegosiasikan tujuan yang disepakati bersama. Keluarga dilibatkan bukan untuk mengambil alih, tetapi sebagai mitra pendukung yang membantu menjalankan strategi harian. Konseling juga menyasar pengasuh, baik anak maupun pasangan, karena kesejahteraan pengasuh dan lansia saling memengaruhi. Ketika pengasuh memahami kondisi yang dihadapi, memiliki strategi menghadapi perilaku sulit dengan tenang, serta mendapat jeda perawatan berkala, suasana rumah menjadi lebih stabil dan ramah pemulihan. Pada lansia dengan penurunan kognitif, pendekatan yang berpusat pada pribadi, yang menghargai preferensi, kebiasaan lama, dan ritme harian, mengurangi agitasi dan kebingungan. Teknik validasi, komunikasi kalimat pendek, isyarat visual, musik, atau stimulasi sensorik ringan sering lebih manjur daripada argumen rasional yang memicu perlawanan.

Farmakoterapi dipertimbangkan bila intervensi psikososial tidak cukup atau gejala tergolong sedang sampai berat. Prinsip kehati-hatian mutlak dijaga karena kerentanan terhadap efek samping dan polifarmasi. Untuk depresi dan kecemasan,

antidepresan golongan penghambat pengambilan ulang serotonin selektif dapat menjadi pilihan awal. Dosis dimulai rendah dan dinaikkan perlahan sambil memantau efek samping seperti mual, gangguan natrium, memar, atau perubahan ritme jantung pada obat tertentu. Pada lansia dengan susah tidur serta penurunan berat badan, obat yang dapat meningkatkan nafsu makan dan memperbaiki tidur dipertimbangkan secara selektif. Penggunaan obat penenang dan obat tidur jangka panjang sebaiknya dihindari karena meningkatkan risiko bingung, jatuh, dan ketergantungan. Bila benar-benar diperlukan, gunakan dosis kecil dalam waktu singkat dengan rencana penghentian yang jelas. Pada demensia, penanganan gejala perilaku dan psikologis selalu mendahulukan intervensi nonfarmakologis. Obat untuk agitasi atau psikosis hanya dipakai pada kondisi berat yang membahayakan keselamatan, dengan persetujuan yang diinformasikan dan pemantauan ketat karena risiko stroke dan kematian meningkat. Untuk penurunan kognitif, obat penunjang kognisi dapat dipertimbangkan oleh dokter sesuai indikasi, sambil tetap menata faktor yang dapat diubah seperti depresi, gangguan tiroid, defisiensi vitamin, nyeri, gangguan tidur, infeksi, serta gangguan penglihatan dan pendengaran.

Pendekatan kebidanan dan keperawatan memberikan jembatan konkret antara rencana klinis dan kehidupan sehari-hari. Perawat berperan sebagai manajer kasus yang memetakan kebutuhan, menyusun rencana aktivitas harian, melakukan konseling singkat, merekonsiliasi obat, dan memantau tanda kemajuan sederhana seperti kualitas tidur, selera makan, dan frekuensi mengikuti kegiatan sosial. Kunjungan rumah memungkinkan penyesuaian lingkungan agar lebih aman: pencahayaan memadai, jalur berjalan bebas hambatan, pengingat obat yang mudah dibaca, sehingga kecemasan menurun dan kemandirian meningkat. Perawatan keperawatan juga mencakup manajemen nyeri, latihan rentang gerak, latihan keseimbangan, dukungan nutrisi, latihan dasar panggul pada perempuan dengan keluhan urologi yang memengaruhi percaya diri, serta pencegahan delirium melalui hidrasi, mobilisasi dini, orientasi realitas, dan koreksi gangguan sensorik. Bidan, sebagai penyedia layanan kesehatan perempuan sepanjang daur kehidupan, memperkuat edukasi pada masa pascamenopause terkait perubahan fisik dan fungsional, konseling hubungan intim yang sehat, strategi mengatasi nyeri saat berhubungan, dan rujukan tepat waktu bila muncul gejala depresi, kecemasan, atau gejala urogenital yang menurunkan harga diri. Peran bidan dan perawat sama-sama penting dalam membuka percakapan tentang isu yang sering dianggap tabu, seperti kesepian, duka, atau fungsi seksual, dengan bahasa yang hormat dan aman.

Intervensi komunitas menutup celah antara perawatan klinis dan kebutuhan sosial. Program posyandu lansia, kelompok senam ringan, kebun bersama,

pengajian, arisan, atau kelas keterampilan sederhana memberi ritme mingguan yang menstimulasi kognisi dan memperkaya jejaring pertemanan. Kader kesehatan dan tokoh komunitas dapat memfasilitasi literasi kesehatan mental, mengajarkan tanda dini gangguan suasana hati, serta cara merespons yang tidak menghakimi. Kegiatan lintas generasi, seperti membaca dengan cucu atau proyek sukarela, membangun kembali rasa berguna. Teknologi dimanfaatkan secukupnya: panggilan video untuk menjaga koneksi keluarga, pengingat obat, dan telekonsultasi untuk memantau gejala tanpa harus keluar rumah, dengan pendampingan literasi digital agar aman dari penipuan dan informasi palsu.

Krisis harus ditangani dengan protokol yang tegas tetapi tetap manusiawi. Bila muncul pikiran untuk bunuh diri, rencana tindakan segera disusun: memastikan lingkungan aman, menghapus akses ke alat berbahaya, meningkatkan frekuensi pemantauan, dan mengatur rujukan darurat. Keluarga diberi panduan mengenali perburukan gejala, misalnya insomnia total, agitasi berat, kebingungan mendadak, atau menarik diri ekstrem, serta nomor kontak yang bisa dihubungi. Setelah krisis mereda, rencana perawatan ditinjau agar faktor pemicu diatasi dan dukungan diperkuat.

Pemantauan dan evaluasi berlangsung berkala agar perawatan tetap relevan. Tenaga kesehatan dan keluarga menyepakati indikator sederhana yang mudah dirasakan lansia, seperti kualitas tidur, selera makan, semangat mengikuti aktivitas, kemampuan merapikan diri, dan keteraturan minum obat. Skala penapisan yang ringkas dapat membantu mendeteksi perubahan halus dari waktu ke waktu, sementara catatan harian singkat memberi gambaran nyata tentang pola baik dan hari-hari sulit. Bila tidak ada kemajuan, rencana dinaikkan tingkatnya. Bila stabil, intervensi dapat disederhanakan untuk menjaga kemandirian.

keberhasilan penanganan gangguan mental pada perempuan lansia ditentukan oleh kualitas kemitraan di antara lansia, keluarga, tenaga kesehatan, dan komunitas. Terapi psikologis yang hangat, konseling yang memberdayakan, obat yang digunakan secara bijaksana, serta perawatan kebidanan dan keperawatan yang mendekatkan layanan ke kehidupan sehari-hari akan saling menguatkan. Ketika setiap orang di sekitar lansia menjaga bahasa yang hormat, memberi waktu untuk mendengar, dan membuka ruang peran yang bermakna, proses pemulihan menjadi lebih mungkin. Perempuan lansia tidak hanya pulih dari gejala, tetapi juga mendapatkan kembali rasa kendali, martabat, dan harapan untuk menikmati hari tua dengan tenang dan berarti.

H. Pemanfaatan Teknologi dan Media dalam Mendukung Kesehatan Mental Lansia

Pemanfaatan teknologi dan media untuk mendukung kesehatan mental perempuan lansia bekerja paling baik ketika dirancang sebagai jembatan antara kehidupan sehari-hari dan layanan profesional. Teknologi bukan tujuan, melainkan alat yang memudahkan akses, memperkuat keterhubungan, dan menjaga kesinambungan perawatan. Kunci keberhasilan terletak pada rancangan yang sederhana, huruf besar yang mudah dibaca, kontras warna yang jelas, tombol yang mudah disentuh, pilihan audio untuk yang penglihatannya menurun, serta alur penggunaan yang tidak berbelit. Di Indonesia, pendekatan yang peka konteks berarti memadukan aplikasi ponsel, telekonsultasi, dan media edukasi yang akrab seperti WhatsApp, video singkat, radio komunitas, serta materi cetak yang bisa disimak bersama keluarga atau kader di posyandu lansia.

Aplikasi digital dapat membantu di tiga ranah sekaligus. Ranah pertama adalah pemantauan harian. Pencatatan suasana hati, kualitas tidur, tingkat nyeri, selera makan, dan aktivitas ringan memberi gambaran yang berguna bagi tenaga kesehatan, terutama bila ditampilkan dalam grafik sederhana yang mudah dipahami lansia dan keluarga. Pengingat minum obat, jadwal kontrol, waktu tidur, serta dorongan untuk melakukan aktivitas bermakna membantu menstabilkan ritme harian yang sangat berpengaruh pada mood. Ranah kedua adalah dukungan psikologis mandiri. Modul singkat tentang teknik napas, relaksasi otot, restrukturisasi pikiran yang mengganggu, serta aktivasi perilaku dapat disajikan dalam format video pendek, audio panduan, atau kartu langkah demi langkah agar tidak membebani daya ingat. Ranah ketiga adalah komunikasi aman. Fitur pesan singkat dan panggilan video terproteksi memudahkan tanya jawab singkat dengan perawat atau konselor, serta memungkinkan keluarga berbagi kabar tanpa harus menunggu kunjungan tatap muka.

Telehealth menghadirkan konsultasi klinis tanpa hambatan jarak. Sesi video atau telepon yang terjadwal memberi ruang evaluasi suasana hati, tidur, nyeri, kepatuhan obat, dan kendala sosial yang muncul di antara kunjungan langsung. Praktik yang baik dimulai dengan persiapan sederhana. Lansia dibantu menyiapkan tempat yang tenang, pencahayaan cukup, daftar obat dan keluhan terbaru, serta kehadiran anggota keluarga bila lansia menghendaki. Tenaga kesehatan menilai kebutuhan mendesak, menyesuaikan kecepatan bicara, menggunakan pertanyaan jelas, dan memastikan rencana tindak lanjut tercatat. Telehealth melengkapi, bukan menggantikan, kunjungan tatap muka ketika pemeriksaan fisik diperlukan atau ketika gejala memburuk. Pada situasi gawat, jalur rujukan cepat harus disepakati sejak awal agar keluarga tahu langkah yang harus ditempuh.

Integrasi teknologi dengan layanan primer memperkuat kesinambungan. Puskesmas dan klinik dapat memanfaatkan daftar tindak lanjut otomatis dari aplikasi untuk menghubungi lansia yang absen kontrol, membaca tren suasana hati yang menurun, atau kualitas tidur yang memburuk. Kader dan perawat dapat mengadakan kunjungan rumah singkat berdasarkan sinyal dari aplikasi, misalnya ketika grafik aktivitas tiba-tiba turun atau lansia menandai keluhan kesepian. Catatan telehealth, hasil pemantauan mandiri, dan pengamatan kader kemudian dirangkum dalam satu berkas ringkas agar keputusan klinis lebih tepat. Pola kerja ini menutup jurang antara data digital dan tindakan nyata di lapangan.

Media edukasi berperan dalam menurunkan stigma dan meningkatkan literasi kesehatan mental. Video dua sampai tiga menit dengan bahasa sehari-hari yang hangat dapat menjelaskan perbedaan duka yang sehat dan depresi, tanda kecemasan yang perlu ditangani, kebiasaan tidur yang menyehatkan, serta cara berkomunikasi yang menenangkan di rumah. Podcast atau siaran radio komunitas berguna bagi lansia yang lebih nyaman mendengar daripada membaca. Infografik cetak berukuran besar yang ditempel di posyandu lansia mengingatkan rutinitas sederhana seperti paparan sinar matahari pagi, peregangan ringan, jeda istirahat siang yang cukup, serta minum obat sesuai jadwal. Konten dibuat singkat, berurutan, dan konsisten, karena pengulangan yang tepat membantu pembelajaran pada usia lanjut.

Peran keluarga tidak tergantikan dalam menjembatani kesenjangan digital. Banyak perempuan lansia merasa lebih percaya diri ketika belajar bersama anggota keluarga. Cucu dapat menjadi mentor digital yang sabar, mengajarkan cara membuka aplikasi, membaca grafik sederhana, dan melakukan panggilan video. Grup keluarga di aplikasi pesan dipakai untuk berbagi kabar harian, mengirim pengingat ramah, serta saling menyemangati. Agar aman, keluarga membantu pengaturan privasi, mengaktifkan verifikasi dua langkah, serta mengajari tanda bahaya penipuan digital. Pendampingan seperti ini memastikan teknologi memberi rasa aman, bukan kecemasan baru.

Keamanan data dan etika penggunaan teknologi memerlukan perhatian serius. Setiap aplikasi atau layanan telehealth perlu menjelaskan dengan jelas data apa yang dikumpulkan, untuk apa digunakan, siapa yang dapat mengakses, dan berapa lama disimpan. Persetujuan harus diinformasikan, artinya lansia benar-benar memahami sebelum menyetujui. Identitas dilindungi, percakapan dienkripsi, dan akses dibatasi hanya untuk tenaga kesehatan dan keluarga yang ditunjuk. Ketika konten edukasi disebarkan di media sosial, sumber harus kredibel dan bebas klaim berlebihan. Prinsipnya sederhana. Teknologi harus menjaga martabat dan kedaulatan data lansia, bukan mengeksploitasinya.

Keterbatasan koneksi dan kepemilikan gawai tidak boleh menjadi penghalang. Solusi hibrid dapat disiapkan. Posyandu lansia atau balai warga memiliki tablet bersama yang dioperasikan kader untuk sesi telekonsultasi terjadwal. Materi edukasi disalin ke kartu memori agar bisa diputar tanpa internet. Formulir pemantauan suasana hati dan tidur tersedia dalam versi kertas yang kemudian difoto dan diunggah oleh kader ketika jaringan tersedia. Cara seperti ini memastikan manfaat teknologi tetap terasa bahkan di wilayah dengan infrastruktur terbatas.

Teknologi juga membuka ruang intervensi kelompok yang menumbuhkan rasa kebersamaan. Sesi dukungan sebaya melalui video singkat dengan moderator perawat atau konselor memberi kesempatan berbagi strategi mengelola duka, kecemasan, dan kesepian. Kegiatan terpandu seperti senam duduk, latihan napas, atau menulis catatan syukur harian dapat dilakukan serentak, lalu peserta saling memberi umpan balik. Pengalaman dilihat dan didengar menurunkan rasa terasing yang sering memperburuk gejala emosional. Moderasi yang baik memastikan suasana aman, menghargai, dan bebas penilaian.

Pemantauan kualitas menjalankan program memerlukan ukuran yang mudah diikuti. Aplikasi dan layanan telehealth sebaiknya menyajikan indikator sederhana. Frekuensi penggunaan modul relaksasi, jumlah hari dengan tidur yang cukup, partisipasi dalam sesi kelompok, serta perubahan skor singkat suasana hati dari waktu ke waktu. Indikator ini dibahas bersama pada saat kontrol agar lansia melihat sendiri kemajuan yang dicapai. Ketika angka menunjukkan kemunduran, tim dapat menyesuaikan rencana. Misalnya menambah sesi telekonsultasi, meminta keluarga memperkuat pendampingan, atau menjadwalkan kunjungan rumah untuk meninjau faktor lingkungan.

I. Tantangan dan Hambatan dalam Peningkatan Kesehatan Mental Lansia

Upaya meningkatkan kesehatan mental perempuan lansia tidak pernah berlangsung dalam ruang hampa. Ia dipengaruhi oleh tatanan sosial, ekonomi, budaya, serta struktur layanan yang ada. Gambaran di lapangan menunjukkan bahwa banyak lansia berada pada persilangan berbagai keterbatasan, mulai dari akses fisik menuju fasilitas kesehatan, kemampuan finansial untuk membiayai layanan, literasi kesehatan yang rendah, hingga hambatan komunikasi dengan tenaga kesehatan. Kondisi ini semakin kompleks karena gejala psikologis pada usia lanjut kerap hadir sebagai keluhan fisik yang samar sehingga bantuan sering terlambat dicari. Ketika hambatan bertumpuk, perjalanan menuju pemulihan terasa jauh dan melelahkan, baik bagi lansia maupun keluarganya.

Keterbatasan akses menjadi pangkal banyak persoalan. Di wilayah yang jauh dari pusat layanan, transportasi yang terbatas membuat lansia bergantung pada

keluarga untuk datang ke fasilitas kesehatan. Kelelahan saat perjalanan, antrian panjang, ruang tunggu yang bising, dan jadwal praktik yang tidak ramah lansia menambah beban emosional. Biaya tidak langsung seperti ongkos transportasi, pendampingan, dan waktu kerja anak yang hilang sering luput diperhitungkan, padahal hal ini dapat menghalangi kunjungan ulang. Kesenjangan digital juga menghadang. Telekonsultasi memang membuka peluang, tetapi sinyal yang tidak stabil, perangkat yang tidak tersedia, dan kecemasan menggunakan gawai menjadi hambatan nyata bagi banyak perempuan lansia.

Ketersediaan tenaga ahli yang terbatas memperlebar jurang antara kebutuhan dan layanan. Spesialis kejiwaan geriatri, psikolog klinis yang terlatih menangani lansia, dan pekerja sosial kesehatan jumlahnya tidak sebanding dengan populasi yang membutuhkan. Distribusi tenaga juga tidak merata, menumpuk di kota besar sementara daerah menengah dan rural sering hanya bergantung pada layanan primer. Beban kerja yang tinggi membuat waktu konsultasi singkat dan komunikasi kurang mendalam, padahal lansia butuh tempo yang lebih pelan, bahasa yang jelas, serta kesempatan mengulang informasi. Tanpa dukungan pelatihan berkelanjutan untuk tenaga lini pertama dan mekanisme supervisi yang mudah diakses, kemampuan deteksi dini dan tata laksana dasar sulit meningkat.

Stigma sosial adalah hambatan yang halus namun kuat. Banyak perempuan lansia tumbuh dalam budaya yang menilai keluhan emosional sebagai kelemahan pribadi, sehingga mereka belajar menutupi kesedihan, cemas, atau rasa putus asa. Labelisasi gangguan jiwa menimbulkan ketakutan akan dikucilkan, dan pada komunitas kecil, persoalan kerahasiaan membuat mereka enggan mencari pertolongan. Ageisme memperburuk keadaan. Anggapan bahwa lupa, murung, atau mudah marah adalah hal biasa pada usia tua membuat keluarga dan tenaga kesehatan menormalisasi gejala yang seharusnya ditangani. Stigma yang diinternalisasi akhirnya mengikis rasa berharga dan membuat lansia merasa tidak pantas dibantu.

Kesenjangan pelayanan tampak pada kurangnya integrasi antara layanan kesehatan jiwa, layanan penyakit kronis, dan dukungan sosial. Rantai rujukan sering tidak jelas, catatan kesehatan tersebar di berbagai tempat, dan komunikasi antartenanta kesehatan kurang terjaga. Banyak fasilitas belum memiliki protokol singkat untuk skrining mood, kecemasan, dan fungsi kognitif saat kunjungan rutin penyakit kronis, padahal kesempatan ini sangat berharga untuk deteksi dini. Ketersediaan obat yang aman untuk lansia tidak selalu memadai, sementara psikoterapi dan konseling sering tidak terjangkau oleh pembiayaan yang ada. Di sisi lain, pelayanan berbasis komunitas seperti kunjungan rumah, kelompok dukungan

sebayu, dan layanan jeda bagi pengasuh masih sporadis sehingga kesinambungan perawatan rapuh.

Hambatan komunikasi menjadi masalah tersendiri yang sering tidak disadari. Penurunan pendengaran atau penglihatan membuat percakapan di ruang praktik yang ramai terasa melelahkan. Bahasa medis yang rumit dan tempo bicara yang cepat membingungkan, sementara rasa sungkan untuk bertanya membuat informasi penting hilang begitu saja. Perbedaan generasi antara tenaga kesehatan dan lansia juga dapat memunculkan jarak, terutama ketika nilai dan cara berkomunikasi tidak disesuaikan. Ketika komunikasi tersendat, kepatuhan terhadap rencana perawatan menurun dan peluang keberhasilan intervensi mengecil.

Aspek ekonomi mempertebal dinding penghalang. Pendapatan tetap yang terbatas, biaya obat yang harus ditebus rutin, dan kebutuhan dasar lain membuat keluarga menunda kunjungan kecuali ketika gejala sudah berat. Pada banyak kasus, perempuan lansia tidak menjadi pengambil keputusan utama dalam rumah tangga sehingga urusan kesehatan bergantung pada ketersediaan waktu dan dana anggota keluarga. Ketidaksetaraan ini menyulitkan, terutama bila keluarga belum memahami bahwa perawatan kesehatan mental yang tepat justru menurunkan biaya jangka panjang melalui pengurangan komplikasi, perbaikan kepatuhan obat, dan berkurangnya kunjungan gawat darurat.

Beban pengasuh adalah hambatan yang sering luput masuk perhitungan. Anak atau pasangan yang mendampingi lansia menghadapi kelelahan fisik, tekanan emosional, dan kebingungan administratif. Tanpa edukasi, dukungan, dan jeda yang memadai, pengasuh mudah frustrasi dan emosi rumah tangga menjadi tegang. Suasana seperti ini membuat lansia semakin enggan mengungkapkan perasaan atau kebutuhan, lalu memilih diam. Ketika beban pengasuh tidak ditangani, kualitas perawatan lansia ikut merosot meski rencana klinis di atas kertas tampak baik.

Penerapan teknologi yang seharusnya membantu juga membawa tantangan. Tidak semua aplikasi dirancang ramah lansia dengan huruf besar, kontras jelas, dan alur sederhana. Kekhawatiran tentang keamanan data dan penipuan digital membuat keluarga ragu mengenalkan teknologi pada lansia, sementara standar perlindungan data belum selalu dipahami oleh semua pihak. Tanpa pendampingan literasi digital, solusi teknologi berisiko menambah kecemasan baru alih-alih mempermudah akses.

Semua hambatan ini saling terkait dan sering memperkuat satu sama lain. Keterbatasan akses memperlambat deteksi, tenaga ahli yang kurang membatasi kualitas tata laksana, stigma menunda pencarian pertolongan, sementara kesenjangan pelayanan memutus kesinambungan perawatan. Gambaran ini tidak dimaksudkan untuk membuat surut harapan, melainkan untuk memperjelas medan

kerja agar strategi perbaikan dapat disusun dengan tajam. Jalan keluarnya terletak pada penguatan layanan primer yang peka usia dan gender, integrasi rujukan yang sederhana, pelatihan berkelanjutan bagi tenaga kesehatan, pemberdayaan keluarga dan komunitas, serta rancangan pembiayaan yang membuat konseling dan dukungan psikososial dapat diakses. Ketika hambatan diakui dan dijawab secara sistematis, perempuan lansia akan lebih dekat pada layanan yang manusiawi, berkesinambungan, dan benar-benar bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari mereka.

J. Simpulan

Bab ini menegaskan bahwa kesehatan mental perempuan lansia merupakan prioritas kesehatan masyarakat yang menuntut pendekatan menyeluruh. Penuaan biologis pascamenopause, beban penyakit kronis, perubahan peran psikologis, serta dinamika sosial dan budaya saling berkelindan membentuk kerentanan maupun ketahanan mental. Berbeda dari kelompok usia lebih muda, gejala sering tampil dalam bentuk keluhan somatik dan perubahan perilaku yang halus sehingga mudah terlewat. Kerangka biopsikososial memberikan lensa yang paling tepat, karena mengakui keterhubungan erat antara tubuh, pikiran, dan lingkungan dalam menentukan kesejahteraan lansia.

Masalah yang paling sering muncul adalah depresi, kecemasan, demensia, dan gangguan tidur, yang dampaknya meluas pada fungsi harian, kepatuhan berobat, serta kualitas hidup keluarga. Kunci pencegahan terletak pada rumah yang memungkinkan, komunitas yang inklusif, dan layanan kesehatan yang peka usia dan gender. Keluarga berperan menjaga martabat, otonomi, dan makna hidup lansia melalui dukungan emosional, informasional, dan instrumental yang seimbang. Komunitas melalui posyandu lansia, kelompok sebaya, kegiatan lintas generasi, dan jejaring kader menjadi penyangga yang menurunkan kesepian dan menstimulasi kognisi. Teknologi dan media yang ramah lansia memperluas akses edukasi, pemantauan harian, dan telekonsultasi, selama kesenjangan literasi digital dijumpai dan privasi data dijaga.

Intervensi yang efektif mengikuti prinsip perawatan bertahap. Edukasi psikologis, aktivasi perilaku, terapi pemecahan masalah, terapi interpersonal, tinjauan hidup, serta terapi perilaku kognitif untuk insomnia terbukti aman dan bermanfaat ketika disesuaikan dengan kapasitas kognitif serta ritme hidup lansia. Farmakoterapi digunakan secara bijaksana pada kasus sedang hingga berat dengan pemantauan ketat terhadap efek samping dan interaksi obat. Perawat dan bidan menjembatani rencana klinis dengan kehidupan sehari-hari melalui manajemen kasus, kunjungan rumah, penyesuaian lingkungan, manajemen nyeri, dukungan

nutrisi, pencegahan delirium, serta konseling isu yang kerap tabu seperti duka, kesepian, dan seksualitas pascamenopause. Keberhasilan diukur tidak hanya oleh berkurangnya gejala, tetapi juga pulihnya tidur, meningkatnya partisipasi sosial, membaiknya selera makan, keteraturan minum obat, dan yang paling penting kembalinya rasa kendali dan martabat.

Berbagai hambatan tetap nyata, mulai dari akses fisik dan ekonomi, keterbatasan tenaga ahli, stigma dan ageisme, hingga kesenjangan integrasi layanan dan kesenjangan digital. Jalan keluarnya memerlukan komitmen lintas sektor untuk memperkuat layanan primer dengan skrining singkat pada setiap kunjungan penyakit kronis, merapikan alur rujukan, membiayai konseling dan dukungan psikososial, melatih tenaga kesehatan tentang kesehatan jiwa geriatri, membangun ruang publik ramah lansia, serta mengembangkan ekosistem teknologi yang sederhana, aman, dan berpihak pada pengguna. Dengan kombinasi kebijakan yang tepat, praktik klinis yang manusiawi, keluarga yang memberdayakan, komunitas yang aktif, dan teknologi yang bermakna, perempuan lansia dapat menua dengan sehat secara mental, merasa aman dan berarti, serta terus memberi teladan kebijaksanaan bagi generasi berikutnya.

K. Referensi

- Al-Ghafri, B. R., Al-Mahrezi, A., & Chan, M. F. (2021). Effectiveness of life review on depression among elderly: A systematic review and meta-analysis. *Pan African Medical Journal*, 40, 168. <https://doi.org/10.11604/pamj.2021.40.168.30040>
- American Geriatrics Society Beers Criteria® Update Expert Panel. (2023). American Geriatrics Society 2023 updated AGS Beers Criteria® for potentially inappropriate medication use in older adults. *Journal of the American Geriatrics Society*. <https://doi.org/10.1111/jgs.18372>
- American Psychiatric Association. (2022). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed., text rev.; DSM-5-TR). American Psychiatric Publishing. <https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425787>
- Edinger, J. D., Arnedt, J. T., Bertisch, S. M., Carney, C. E., Harrington, J. J., Lichstein, K. L., ... Martin, J. L. (2021). Behavioral and psychological treatments for chronic insomnia disorder in adults: An American Academy of Sleep Medicine clinical practice guideline. *Journal of Clinical Sleep Medicine*, 17(2), 255–262. <https://doi.org/10.5664/jcsm.8986>
- Guarnera, J., Kohler, C. G., Pirooznia, M., & Jayatillake, R. (2023). The impact of loneliness and social isolation on cognitive functioning in older adults: A systematic review. *Aging & Mental Health*, 27(7), 1323–1338. <https://doi.org/10.1080/13607863.2022.2136985>
- Handajani, Y. S., Lutfi, A. M., & Paramashanti, B. A. (2022). Depression among older

adults in Indonesia: Prevalence, role of chronic conditions, and other associated factors. *International Journal of Health Promotion and Education*, 60(4), 218–229. <https://doi.org/10.1080/14635240.2021.1876003>

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). Pedoman untuk Puskesmas dalam pemberdayaan lanjut usia. Kemenkes RI. <https://repository.kemkes.go.id/book/280>

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). Buku pedoman penyelenggaraan kesehatan jiwa di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Kemenkes RI. <https://ayosehat.kemkes.go.id/buku-pedoman-penyelenggaraan-kesehatan-jiwa-di-fasilitas-kesehatan-tingkat-pertama>

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). Profil Kesehatan Indonesia 2023. Kemenkes RI. https://kemkes.go.id/app_asset/file_content_download/172231123666a86244b83fd8.51637104.pdf

National Institute for Health and Care Excellence. (2018, updated 2023). Dementia: Assessment, management and support for people living with dementia and their carers (NG97). <https://www.nice.org.uk/guidance/ng97>

National Institute for Health and Care Excellence. (2022, reviewed 2024). Depression in adults: Treatment and management (NG222). <https://www.nice.org.uk/guidance/ng222>

Office of the U.S. Surgeon General. (2023). Our epidemic of loneliness and isolation: The U.S. Surgeon General's advisory on the healing effects of social connection and community. U.S. Department of Health and Human Services. <https://www.hhs.gov/sites/default/files/surgeon-general-social-connection-advisory.pdf>

Reynolds, C. F., Nutt, D., Stahl, S., & Blazer, D. (2022). Mental health care for older adults: Recent advances and new directions. *World Psychiatry*, 21(3), 404–426. <https://doi.org/10.1002/wps.20905>

Sum, G., Lau, L. K., Abdul Jabbar, K., Lun, P., George, P. P., Munro, Y. L., & Ding, Y. Y. (2022). The WHO Integrated Care for Older People (ICOPE) framework: Adoption worldwide and lessons learnt. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(1), 154. <https://doi.org/10.3390/ijerph20010154>

U.S. Department of Health and Human Services. (2023). Key takeaways: Our epidemic of loneliness and isolation. <https://www.hhs.gov/sites/default/files/sg-social-connection-general.pdf>

Wang, F., Feng, T., Yang, S., & Zheng, D. (2023). Social isolation and loneliness as predictors of mortality: A systematic review and meta-analysis of prospective cohort studies. *Nature Human Behaviour*, 7(9), 1476–1488. <https://doi.org/10.1038/s41562-023-01617-6>

- World Health Organization. (2016). mhGAP intervention guide for mental, neurological and substance use disorders in non-specialized health settings (Version 2.0). <https://www.who.int/publications/i/item/9789241549790>
- World Health Organization. (2020). Decade of healthy ageing: Baseline report. <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/338677/9789240017900-eng.pdf>
- World Health Organization. (2021). Global report on ageism. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240016866>
- World Health Organization. (2023, October 20). Mental health of older adults. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/mental-health-of-older-adults>
- World Health Organization. (2024). Integrated care for older people (ICOPE): Guidance for person-centred assessment and pathways in primary care (updated handbook). <https://www.who.int/publications/i/item/9789240103726>
- World Health Organization. (2025, March 31). Dementia: Fact sheet. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dementia>

L. Glosarium

Ageisme: Sikap, keyakinan, atau kebijakan yang mendiskriminasi berdasarkan usia, misalnya menganggap keluhan emosi pada lansia sebagai hal wajar sehingga tidak perlu ditangani.

Aktivasi perilaku: Pendekatan psikologis yang menata kembali kegiatan harian yang bermakna dan menyenangkan untuk mengangkat suasana hati dan memutus siklus menarik diri.

Aktivitas kehidupan sehari-hari (Activities of Daily Living, ADL): Serangkaian kemampuan dasar seperti mandi, berpakaian, makan, berpindah, dan ke toilet yang mencerminkan kemandirian fungsional.

Aktivitas instrumental kehidupan sehari-hari (Instrumental Activities of Daily Living, IADL): Kemampuan tingkat lanjut seperti mengelola keuangan, berbelanja, menyiapkan makanan, menggunakan telepon, dan mengatur obat yang menunjukkan kemandirian sosial.

Aplikasi kesehatan: Perangkat lunak pada gawai yang membantu pemantauan suasana hati, tidur, nyeri, kepatuhan obat, serta komunikasi dengan tenaga kesehatan dan keluarga.

Ansietas: Keadaan cemas berlebihan yang memunculkan gejala fisik dan kognitif seperti gelisah, tegang otot, gangguan tidur, sulit konsentrasi, dan kecenderungan menghindari.

Asesmen komprehensif geriatri: Penilaian menyeluruh yang mencakup kondisi fisik, mental, sosial, fungsional, obat yang dikonsumsi, serta lingkungan rumah untuk menyusun rencana perawatan yang relevan.

Beban pengasuh: Dampak fisik, emosional, sosial, dan finansial yang dialami pendamping atau keluarga yang merawat lansia, yang dapat memengaruhi kualitas perawatan di rumah.

Beers Criteria: Daftar obat yang berisiko kurang aman untuk lansia yang digunakan sebagai rujukan untuk meminimalkan efek samping dan interaksi obat.

Biopsikososial: Kerangka yang memandang kesehatan sebagai hasil interaksi faktor biologis, psikologis, dan sosial yang saling memengaruhi sepanjang proses penuaan.

Cognitive Behavioral Therapy atau Terapi perilaku kognitif: Terapi terstruktur yang membantu mengidentifikasi dan mengubah pola pikir serta perilaku yang mempertahankan depresi, ansietas, atau insomnia.

Delirium: Gangguan akut pada perhatian dan kesadaran yang berfluktuasi, sering berkaitan dengan penyakit fisik, obat tertentu, infeksi, atau dehidrasi pada lansia.

Demensia: Gangguan neurokognitif progresif dengan penurunan memori dan fungsi kognitif lain yang mengganggu kemandirian aktivitas harian, misalnya tipe Alzheimer atau vaskular.

Depresi pada lansia: Gangguan suasana hati yang ditandai murung menetap, kehilangan minat, gangguan tidur dan nafsu makan, penurunan energi, yang kerap tersamar sebagai keluhan fisik.

Duka berkepanjangan: Respons kehilangan yang menetap dan mengganggu fungsi harian, disertai kerinduan mendalam dan kesulitan beradaptasi setelah kematian orang terdekat.

Dukungan emosional: Kehangatan, empati, dan validasi perasaan yang diberikan keluarga atau komunitas untuk meningkatkan rasa aman dan harga diri lansia.

Dukungan informasional: Penyediaan pengetahuan praktis tentang diagnosis, pilihan terapi, dan strategi mengelola gejala agar lansia dan keluarga mampu mengambil keputusan.

Dukungan instrumental: Bantuan konkret seperti pengantaran kontrol, penataan obat, belanja, atau penyesuaian rumah tanpa mengurangi otonomi lansia.

Dukungan sebaya: Pertemuan rutin dengan kelompok lansia lain untuk berbagi pengalaman, strategi koping, dan saling menyemangati.

Farmakoterapi: Penggunaan obat untuk menangani gejala sedang sampai berat pada depresi, ansietas, atau gejala perilaku demensia dengan prinsip kehati-hatian pada lansia.

Fungsi eksekutif: Kemampuan mengatur, merencanakan, memecahkan masalah, mengendalikan impuls, dan berganti tugas yang penting bagi kemandirian.

Gangguan kognitif ringan: Penurunan kognitif melebihi penuaan normal tetapi belum mengganggu kemandirian aktivitas harian; memerlukan pemantauan berkala.

Gangguan tidur insomnia: Kesulitan memulai atau mempertahankan tidur yang menurunkan fungsi siang hari, sering memburuk oleh nyeri, nokturia, atau kecemasan.

Gotong royong: Modal sosial khas Indonesia berupa kerja bersama yang menopang jejaring dukungan, kunjungan rumah, dan bantuan praktis bagi lansia.

Hot flush: Sensasi panas mendadak pascamenopause yang dapat mengganggu tidur dan kenyamanan, berdampak pada suasana hati.

ICOPE (Integrated Care for Older People): Pedoman perawatan terpadu berpusat pada orang untuk menjaga fungsi dan kemandirian lansia di layanan primer.

Isolasi sosial: Minimnya kontak sosial objektif yang meningkatkan risiko depresi, penurunan kognitif, hingga mortalitas.

Kader kesehatan: Relawan terlatih di komunitas yang menjembatani layanan kesehatan dengan kebutuhan nyata lansia, termasuk pemantauan dan rujukan.

Kebersihan tidur: Kumpulan kebiasaan sehat seperti konsistensi jam tidur, paparan cahaya pagi, pembatasan kafein sore, dan lingkungan kamar yang nyaman.

Kemandirian fungsional: Kemampuan menjalankan ADL dan IADL tanpa bantuan, menjadi indikator penting kualitas hidup lansia.

Keluarga sandwich: Kondisi anak dewasa yang menanggung perawatan orang tua sekaligus membesarkan anak, rentan mengalami kelelahan pengasuh.

Kesepian: Persepsi tidak terhubung secara emosional dengan orang lain meski ada orang di sekitar, berhubungan dengan depresi dan penurunan kognitif.

Ketahanan psikologis atau resiliensi: Kemampuan bangkit dan beradaptasi setelah pengalaman sulit melalui makna hidup, dukungan sosial, dan strategi coping.

Komorbiditas: Keberadaan lebih dari satu penyakit pada individu yang sama, misalnya diabetes dan penyakit jantung, yang memperumit penanganan mental.

Konseling: Proses komunikasi terapeutik yang memberdayakan lansia dan keluarga untuk memahami masalah, menetapkan tujuan, dan menjalankan strategi pemulihan.

Krisis psikologis: Perburukan akut seperti pikiran untuk bunuh diri atau agitasi berat yang memerlukan penanganan segera dan rujukan darurat.

Kunjungan rumah: Layanan keperawatan di rumah untuk asesmen, edukasi, penyesuaian lingkungan, pemantauan obat, dan penguatan dukungan keluarga.

Life review atau Tinjauan hidup: Intervensi yang mengajak lansia merefleksikan perjalanan hidup untuk memperkuat identitas, syukur, dan makna.

Literasi digital: Kemampuan menggunakan gawai dan aplikasi secara aman, termasuk memahami privasi data dan menghindari penipuan.

Literasi kesehatan: Kemampuan mencari, memahami, dan menggunakan informasi kesehatan untuk membuat keputusan yang tepat.

PROFIL PENULIS



Dr, Fitriana, S.SiT., M.Kes. Lahir di Pringsewu, 23 Juli 1982. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu Pendidikan Doktorat pada Universitas Sebelas Maret lulus tahun 2024. Riwayat pekerjaan mengabdikan diri di Universitas Aisyah Pringsewu Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku yang Sebagian dalam lingkup kebidanan, rutin melaksanakan penelitian dengan output publikasi pada jurnal nasional maupun internasional, serta secara berkesinambungan melaksanakan kegiatan pengabdian Masyarakat.



Deny Eka Widyastuti, SST., M.Kes., M.Keb Lahir di Karanganyar, 01 Desember 1988. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang DIV Kebidanan pada Program Studi Kebidanan Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2006. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Pendidikan Kedokteran Keluarga pada Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tahun 2011 dan lulus pada tahun 2013. Kemudian pada Tahun 2018 penulis mengambil pendidikan Magister Kebidanan di Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta dan lulus di tahun 2020. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2010 sebagai dosen di STIKes Kusuma Husada Surakarta. Saat ini penulis bekerja di Universitas Kusuma Husada Surakarta mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Pada Kehamilan, Asuhan Kebidanan pada Remaja dan perimenopause dan Asuhan Kebidanan pada Bayi, Balita dan Anak Pra Sekolah serta Evidence Based pada Kebidanan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, pengabdian kepada masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: denka_widyastuti@ukh.ac.id
"Kehidupan adalah rangkaian sebuah pilihan. Kita perlu memilih hal yang tepat untuk mendapatkan hasil yang memuaskan"

PROFIL PENULIS



Dr. Subang Aini Nasution, SKM, M.Kes, Lahir di Sapilpil, 06 Januari 1985. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Kesehatan Masyarakat, Universitas Prima Indonesia tahun 2006. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Sumatra Utara dan lulus tahun 2011. Lalu melanjutkan pendidikan S3 pada Program Studi Ilmu Kedokteran, Universitas Prima Indonesia dan lulus pada tahun 2023. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2008 di Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Prima Indonesia sampai tahun 2017. Mulai tahun 2018 sampai saat ini penulis bekerja di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan di Universitas Adiwangsa Jambi, mengampu mata kuliah di bidang Kesehatan Ibu dan Anak. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, serta workshop. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: subang.aini@unaja.ac.id

Sinopsis

Buku bab “Bunga Rampai Kesehatan Mental Perempuan: Pendekatan Kebidanan dari Remaja Hingga Lansia” menyajikan panduan komprehensif yang menautkan teori mutakhir dengan praktik kebidanan lintas siklus hidup. Bab 1 mengawali dengan fondasi konseptual kesehatan mental menurut WHO (2022), diikuti Rubin’s Theory of Maternal Role Attainment dan model stress–diathesis untuk menjelaskan kerentanan psikologis selama kehamilan. Bab ini mengulas spektrum gangguan yang lazim pada kehamilan serta strategi deteksi dini dan intervensi klinis yang peka budaya, dilengkapi perspektif global dan lokal sebagai pijakan kebijakan dan layanan.

Memasuki Bab 2, fokus diarahkan pada periode pascapersalinan dengan pemetaan kondisi psikologis umum dan spektrum gangguan: baby blues, depresi pascapersalinan, kecemasan, hingga psikosis. Disajikan faktor risiko, strategi pencegahan dan skrining berjenjang, serta pendekatan terapi yang terintegrasi mulai dari dukungan psikososial hingga tata laksana rujukan dengan penekanan pada peran kolaboratif tenaga kesehatan. Setiap subbagian dirangkum dengan simpulan praktis, referensi terkini, dan glosarium untuk memperjelas terminologi klinis.

Pada Bab 3, pembahasan bergeser ke perempuan dewasa: konsep dasar, determinan risiko, masalah umum, dan dampaknya terhadap peran domestik, sosial, serta pekerjaan. Bab ini menonjolkan strategi promosi–pencegahan, peran tenaga kesehatan, serta studi kasus/praktik baik sebagai contoh implementasi. Bab 4 menutup dengan lansia perempuan: konsep inti, faktor biologis–psikososial, peran keluarga/lingkungan, intervensi ramah usia, dan pemanfaatan teknologi/media untuk mempertahankan kemandirian. Tantangan implementasi dibahas kritis, disertai simpulan, referensi, glosarium, dan profil penulis sebagai jaminan akuntabilitas ilmiah.

Buku bab “Bunga Rampai Kesehatan Mental Perempuan: Pendekatan Kebidanan dari Remaja Hingga Lansia” menyajikan panduan komprehensif yang menautkan teori mutakhir dengan praktik kebidanan lintas siklus hidup. Bab 1 mengawali dengan fondasi konseptual kesehatan mental menurut WHO (2022), diikuti Rubin’s Theory of Maternal Role Attainment dan model stress diathesis untuk menjelaskan kerentanan psikologis selama kehamilan. Bab ini mengulas spektrum gangguan yang lazim pada kehamilan serta strategi deteksi dini dan intervensi klinis yang peka budaya, dilengkapi perspektif global dan lokal sebagai pijakan kebijakan dan layanan.

Memasuki Bab 2, fokus diarahkan pada periode pascapersalinan dengan pemetaan kondisi psikologis umum dan spektrum gangguan: baby blues, depresi pascapersalinan, kecemasan, hingga psikosis. Disajikan faktor risiko, strategi pencegahan dan skrining berjenjang, serta pendekatan terapi yang terintegrasi mulai dari dukungan psikososial hingga tata laksana rujukan dengan penekanan pada peran kolaboratif tenaga kesehatan. Setiap subbagian dirangkum dengan simpulan praktis, referensi terkini, dan glosarium untuk memperjelas terminologi klinis.

Pada Bab 3, pembahasan bergeser ke perempuan dewasa: konsep dasar, determinan risiko, masalah umum, dan dampaknya terhadap peran domestik, sosial, serta pekerjaan. Bab ini menonjolkan strategi promosi-pencegahan, peran tenaga kesehatan, serta studi kasus/praktik baik sebagai contoh implementasi. Bab 4 menutup dengan lansia perempuan: konsep inti, faktor biologis-psikososial, peran keluarga/lingkungan, intervensi ramah usia, dan pemanfaatan teknologi/media untuk mempertahankan kemandirian. Tantangan implementasi dibahas kritis, disertai simpulan, referensi, glosarium, dan profil penulis sebagai jaminan akuntabilitas ilmiah.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta

